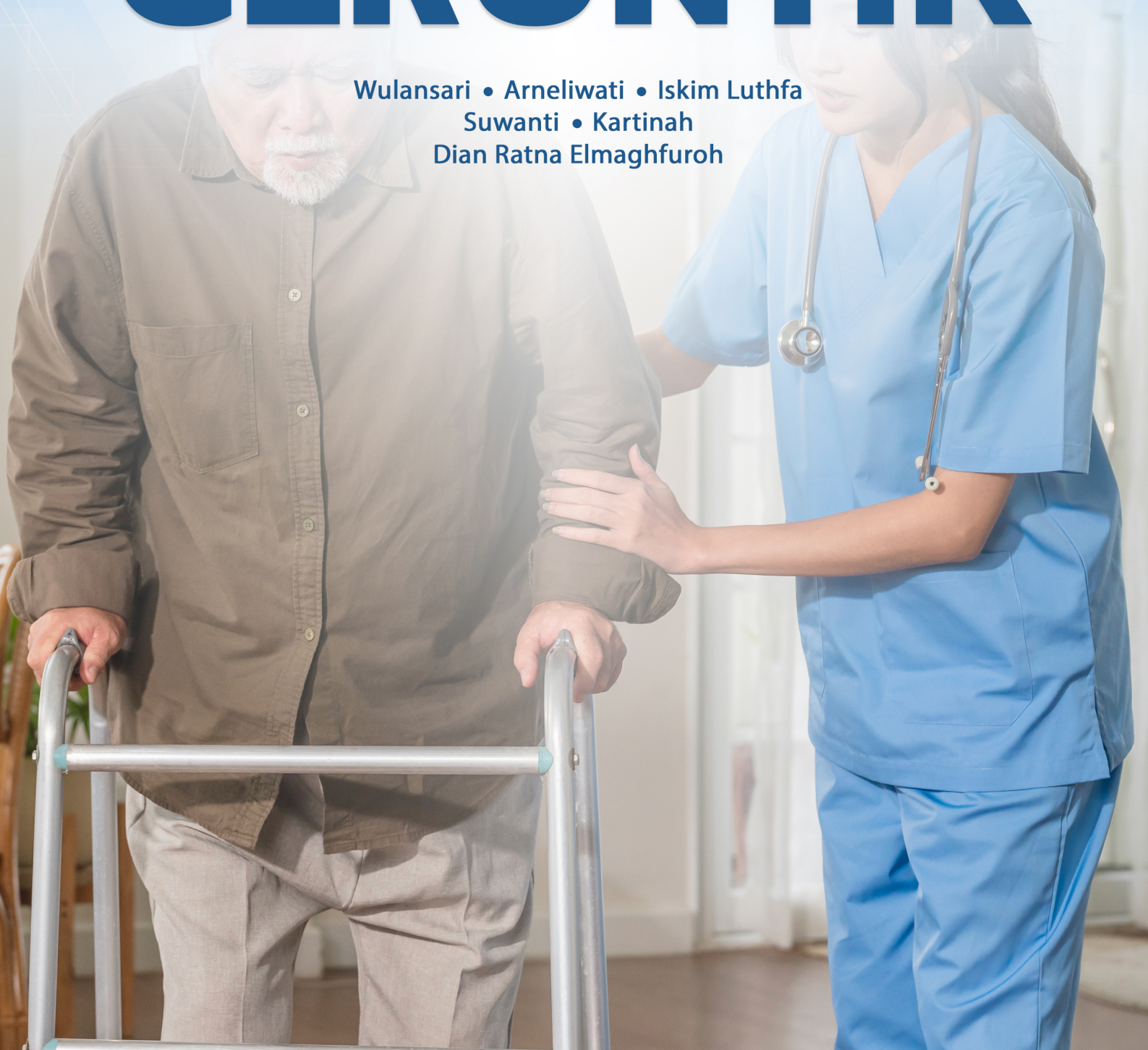


Buku Ajar

KEPERAWATAN GERONTIK

Wulansari • Arneliwati • Iskim Luthfa
Suwanti • Kartinah
Dian Ratna Elmagfuroh



BUKU AJAR KEPERAWATAN GERONTIK

Penulis:

Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Arneliwati, M.Kep.

Dr. Iskim Luthfa, S.Kep., Ns., M.Kep.

Suwanti, S.Kep., Ns., MNS.

Kartinah, S.Kep., Ns., MPH.

Ns. Dian Ratna Elmaghfuroh, S.Kep., M.Kes.



BUKU AJAR KEPERAWATAN GERONTIK

Penulis: Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Arneliwati, M.Kep.

Dr. Iskim Luthfa, S.Kep., Ns., M.Kep.

Suwanti, S.Kep., Ns., MNS.

Kartinah, S.Kep., Ns., MPH.

Ns. Dian Ratna Elmaghfuroh, S.Kep., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-96029-3-8

Cetakan Pertama : Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Buku Ajar Keperawatan Gerontik ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai respons terhadap kebutuhan yang meningkat akan tenaga keperawatan yang terampil dan kompeten dalam menangani populasi lanjut usia (lansia). Pembahasan buku ini dirancang sistematis, mulai dari konsep dasar tentang lansia, berbagai model keperawatan gerontik, hingga aplikasi nyata dalam praktik sehari-hari, dengan harapan dapat membantu mahasiswa dan praktisi keperawatan dalam memberikan pelayanan optimal kepada lansia.

Buku ini diawali dengan pemaparan komprehensif mengenai konsep lansia, mencakup perubahan fisiologis, psikologis, sosial, serta spiritual yang terjadi seiring pertambahan usia. Selanjutnya, berbagai model keperawatan gerontik dari para ahli seperti Callista Roy, Martha Rogers, Betty Neuman, dan Dorothea Orem diulas secara mendalam, sehingga pembaca dapat memahami pendekatan teoritis dalam praktik keperawatan yang berorientasi pada kebutuhan spesifik lansia.

Pada bab-bab berikutnya, buku ini secara detail menjelaskan prosedur pengkajian kesehatan lansia, proses perencanaan dan implementasi asuhan keperawatan, serta tindakan praktis seperti terapi kognitif, aktivitas fisik, bantuan aktivitas sehari-hari, hingga aplikasi Comprehensive Geriatric Assessment (CGA). Akhirnya, penulis berharap buku ini tidak hanya menjadi acuan akademis tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi lansia, sejalan dengan paradigma baru pelayanan kesehatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kebutuhan individu lansia secara menyeluruh.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 KONSEP LANSIA	1
A. Defenisi lansia	3
B. Perubahan Fisiologis pada Lansia.....	3
C. Perubahan Psikologis pada Lansia	4
D. Perubahan Sosial pada Lansia	4
E. Perubahan Spiritual pada Lansia.....	4
F. Kebutuhan Fisik Lansia	5
G. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan	5
H. Kebutuhan Sosial.....	6
I. Kebutuhan Psikologis	6
J. Kebutuhan Spiritual	6
K. Paradigma Baru Pelayanan Kesehatan Lansia.....	7
L. Peran Perawat Gerontik di Berbagai Lini Pelayanan.....	7
M. Latihan.....	7
N. Rangkuman Materi	8
O. Glosarium.....	9
P. Daftar Pustaka.....	10
BAB 2 MODEL KEPERAWATAN GERONTIK.....	11
A. Definisi Model Keperawatan	12
B. Definisi Model Keperawatan Gerontik	13
C. Model Keperawatan Gerontik (Callista Roy)	13
D. Model Keperawatan Gerontik (Martha Rogers)	17
E. Model Keperawatan Gerontik (Betty Neuman)	19
F. Model Keperawatan Gerontik (Virginia Henderson)	22
G. Model Keperawatan Gerontik (Madeleine Leininger).....	25
H. Model Keperawatan Gerontik (Dorothy E. Johnson).....	28
I. Model Keperawatan Gerontik (Dorothea Orem)	30
J. Latihan.....	32
K. Rangkuman Materi	34
L. Glosarium.....	35

M. Daftar Pustaka.....	36
BAB 3 PENGKAJIAN KESEHATAN PADA LANSIA.....	39
A. Skrining Kesehatan	41
B. Pengkajian kesehatan	43
C. Mewancarai Lansia	43
D. Pengkajian Riwayat Kesehatan Lansia.....	46
E. Pemeriksaan Fisik Pada Lansia	46
F. Mengukur Tanda-Tanda Vital Pada Lansia.....	48
G. Pengkajian Sensori pada lansia.....	50
H. Pengkajian Psikososial Pada lansia.....	50
I. Pengkajian Perubahan Kondisi Pada lansia	51
J. Latihan.....	52
K. Rangkuman Materi	53
L. Glosarium.....	54
M. Daftar Pustaka.....	55
BAB 4 PROSES KEPERAWATAN PADA INDIVIDU DAN KELOMPOK KHUSUS LANSIA	57
A. Konsep Dasar Keperawatan Lansia.....	59
B. Perubahan Fisiologis dan Psikososial pada Lansia.....	61
C. Pengkajian Keperawatan pada Lansia	63
D. Perencanaan Asuhan Keperawatan Lansia	65
E. Implementasi Asuhan Keperawatan Lansia.....	67
F. Evaluasi Asuhan Keperawatan Lansia	69
G. Latihan Soal.....	71
H. Rangkuman Materi	73
I. Glosarium.....	75
J. Daftar Pustaka.....	77
BAB 5 PROSEDUR TINDAKAN KEPERAWATAN PADA LANSIA.....	79
A. Tindakan keperawatan pada lansia	81
B. Terapi kognitif pada lansia.....	84
C. Terapi aktivitas untuk lansia.....	88
D. Bantuan Aktivitas Sehari Hari (Activity Daily Living/ADL) pada kelompok lansia	91
E. Senam Lansia.....	94
F. Latihan.....	97

G. Rangkuman Materi	99
H. Glosarium.....	99
I. Daftar Pustaka.....	99

BAB 6 APLIKASI ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA DALAM

KONTEKS INDIVIDU.....103

A. Pengkajian	105
B. Elemen Comprehensive Geriatric Assessment (CGA).....	106
C. Diagnosa Keperawatan	108
D. Intervensi Keperawatan.....	110
E. Implementasi	111
F. Evaluasi	114
G. Latihan.....	115
H. Rangkuman Materi	117
I. Glosarium.....	117
J. Daftar Pustaka.....	119

PROFIL PENULIS.....121

BAB 1

KONSEP LANSIA

Tujuan Intruksional:

Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar tentang lansia serta penerapannya dalam konteks keperawatan gerontik.

Capaian Pembelajaran:

1. Menjelaskan definisi dan klasifikasi lansia.
2. Menyebutkan perubahan fisiologis, psikologis, sosial, dan spiritual pada lansia.
3. Menjelaskan kebutuhan dasar dan masalah umum yang dialami lansia.
4. Mengidentifikasi prinsip dan peran perawat dalam keperawatan gerontik.

Pendahuluan:

Penuaan adalah proses alami yang pasti akan dialami oleh setiap individu yang hidup cukup lama. Proses ini ditandai dengan menurunnya kemampuan tubuh secara bertahap, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Penuaan bukanlah penyakit, tetapi merupakan suatu fase dalam siklus kehidupan manusia yang memerlukan perhatian dan pendekatan tersendiri, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan. Dengan bertambahnya usia harapan hidup, jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di dunia, termasuk Indonesia, meningkat secara signifikan. Fenomena ini membawa dampak besar terhadap sistem pelayanan kesehatan dan sosial yang ada. Secara global, lansia didefinisikan sebagai individu yang berusia 60 tahun ke atas. Di Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia menjadi landasan hukum bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak lansia. Dalam konteks keperawatan, pemahaman terhadap konsep lansia sangat penting karena lansia merupakan kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus. Lansia seringkali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penyakit kronis, penurunan kemampuan fisik, masalah psikologis seperti kesepian dan depresi, hingga keterbatasan sosial dan ekonomi. Perubahan fisiologis yang terjadi pada lansia memengaruhi berbagai sistem tubuh, seperti sistem kardiovaskular, pernapasan, muskuloskeletal, pencernaan, dan saraf. Selain itu, perubahan psikologis seperti penurunan daya ingat dan emosi yang tidak stabil juga menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan asuhan keperawatan.

Aspek sosial, seperti kehilangan pasangan hidup, pengurangan peran sosial, dan isolasi dari komunitas, turut memperburuk kondisi lansia jika tidak ditangani dengan baik. Dalam konteks pelayanan keperawatan, pendekatan terhadap lansia harus bersifat holistik, mencakup aspek bio-psiko-sosial-spiritual. Perawat tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan emosional dan sosial lansia. Keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam perawatan lansia sangat penting agar lansia tetap merasa dihargai, bermakna, dan dapat menjalani hidup dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, dalam buku ini akan dibahas secara mendalam mengenai konsep lansia, perubahan yang terjadi seiring bertambahnya usia, serta implikasinya dalam praktik keperawatan. Harapannya, mahasiswa keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya dapat memiliki pemahaman yang lebih baik dan mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi lansia. Pemahaman ini juga penting untuk mendorong terbentuknya kebijakan yang mendukung keberdayaan dan kesejahteraan lansia dalam kehidupan bermasyarakat.

A. Defenisi lansia

Menurut WHO, lansia adalah individu yang berusia 60 tahun ke atas. Di Indonesia, UU No. 13 Tahun 1998 menyatakan bahwa lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Lansia diklasifikasikan menjadi: Lansia awal (60–74 tahun), lansia madya (75–90 tahun), lansia tua (>90 tahun), dan lansia risiko tinggi (dengan kondisi penyakit kronis atau disabilitas).

Lanjut usia (lansia) merupakan tahap akhir dalam rentang kehidupan manusia yang ditandai oleh penurunan kemampuan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami berbagai perubahan yang kompleks dan saling berkaitan, yang berpengaruh terhadap kualitas hidup dan status kesehatannya. Oleh karena itu, perawat perlu memahami karakteristik lansia agar dapat memberikan asuhan keperawatan yang sesuai, bermakna, dan berfokus pada peningkatan kemandirian serta kualitas hidup lansia.

B. Perubahan Fisiologis pada Lansia

Perubahan fisiologis adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi tubuh seiring bertambahnya usia. Hampir semua sistem tubuh mengalami penurunan fungsi yang memengaruhi respons tubuh terhadap penyakit dan penyembuhan.

1. Sistem Kardiovaskular: Dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku, curah jantung menurun, tekanan darah meningkat, meningkatkan risiko hipertensi dan gagal jantung.
2. Sistem Respirasi: Penurunan elastisitas paru-paru, menurunnya kapasitas vital dan peningkatan risiko infeksi pernapasan.
3. Sistem Pencernaan: Lambatnya gerakan usus menyebabkan konstipasi, penurunan asam lambung memengaruhi penyerapan vitamin B12.
4. Sistem Muskuloskeletal: Penurunan massa dan kekuatan otot (sarkopenia), pengeroposan tulang (osteoporosis), serta nyeri sendi (osteoarthritis).
5. Sistem Saraf: Penurunan kecepatan impuls saraf, mempengaruhi refleks dan daya ingat jangka pendek.
6. Sistem Integumen: Kulit menjadi tipis, kering, elastisitas berkurang, kerentanan terhadap luka meningkat.
7. Sistem Endokrin dan Metabolik: Penurunan sensitivitas insulin, metabolisme melambat, peningkatan risiko diabetes melitus.

8. Sistem Urogenital: Fungsi ginjal menurun, kontrol kandung kemih berkurang, meningkatkan risiko inkontinensia.

C. Perubahan Psikologis pada Lansia

Aspek psikologis sangat penting dalam memahami kondisi lansia. Perubahan ini bisa dipicu oleh faktor biologis maupun pengalaman hidup seperti kehilangan pasangan, pensiun, atau penyakit kronis.

1. Depresi: Umum terjadi akibat kesepian, kehilangan peran sosial, atau penyakit kronis yang diderita. Depresi sering tidak dikenali dan dianggap sebagai bagian dari penuaan.
2. Gangguan Kognitif: Penurunan kemampuan mengingat, memperhatikan, dan mengambil keputusan. Lansia juga rentan terhadap penyakit Alzheimer dan bentuk lain dari demensia.
3. Kecemasan dan stres: Dapat terjadi karena perubahan fisik, rasa tidak berdaya, dan ketakutan akan kematian.
4. Harga Diri dan Identitas Diri: Perasaan tidak berharga karena tidak produktif lagi atau merasa menjadi beban keluarga.

D. Perubahan Sosial pada Lansia

Perubahan sosial mencakup pergeseran dalam hubungan, peran, dan keterlibatan lansia dalam komunitas.

1. Isolasi Sosial: Lansia sering kali kehilangan pasangan hidup, teman sebaya, atau tinggal terpisah dari anak-anaknya. Hal ini memengaruhi kesehatan mental dan memperbesar risiko gangguan kognitif.
2. Ketergantungan: Ketika fungsi fisik menurun, lansia menjadi lebih tergantung pada orang lain untuk aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, dan berpakaian.
3. Perubahan Peran: Setelah pensiun, lansia kehilangan peran sebagai pencari nafkah atau pemimpin keluarga. Hal ini bisa menyebabkan krisis identitas dan hilangnya makna hidup.
4. Ekonomi: Ketergantungan finansial terhadap anak atau pensiun yang tidak mencukupi dapat menurunkan kualitas hidup lansia.

E. Perubahan Spiritual pada Lansia

Aspek spiritual menjadi lebih menonjol seiring bertambahnya usia. Lansia mulai mencari makna hidup dan mempersiapkan diri menghadapi kematian.

1. Pencarian Makna Hidup: Lansia sering kali melakukan refleksi terhadap kehidupan yang telah dijalani, menilai pencapaian dan kesalahan, serta mencari kedamaian batin.
2. Ibadah dan Spiritualitas: Banyak lansia yang meningkatkan kegiatan ibadah atau mencari komunitas spiritual sebagai bentuk kedekatan dengan Tuhan.
3. Harapan dan Ketenangan Batin: Spiritualitas membantu lansia mengatasi ketakutan terhadap kematian dan meningkatkan ketenangan psikologis.
4. Hubungan dengan Keluarga dan Tuhan: Lansia memperdalam hubungan dengan orang terdekat dan memperbaiki hubungan yang renggang sebagai bagian dari persiapan spiritual.

F. Kebutuhan Fisik Lansia

Kebutuhan fisik meliputi nutrisi yang adekuat, istirahat dan tidur, aktivitas fisik, eliminasi, serta kebersihan diri.

1. Nutrisi: Lansia membutuhkan makanan dengan kandungan gizi seimbang. Penurunan nafsu makan, gangguan penciuman, dan masalah gigi dapat menyebabkan defisiensi nutrisi. Nutrisi tinggi serat, rendah lemak jenuh, cukup protein, dan kalsium sangat disarankan.
2. Istirahat dan Tidur: Lansia sering mengalami gangguan tidur seperti insomnia atau tidur tidak nyenyak. Kondisi ini dapat memengaruhi daya tahan tubuh dan kondisi psikologis. Lingkungan tidur yang nyaman dan rutinitas tidur yang konsisten perlu diperhatikan.
3. Aktivitas Fisik: Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki, senam lansia, atau yoga sangat baik untuk menjaga kekuatan otot dan fleksibilitas sendi. Aktivitas ini juga dapat mengurangi risiko penyakit kronis.
4. Eliminasi: Gangguan buang air kecil atau besar umum terjadi, seperti inkontinensia atau konstipasi. Perawat perlu memberikan edukasi tentang pola makan dan hidrasi.
5. Kebersihan Diri: Lansia membutuhkan bantuan dalam menjaga kebersihan tubuh. Perawatan kulit, kuku, dan mulut harus dilakukan secara rutin untuk mencegah infeksi.

G. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan

Kebutuhan akan rasa aman sangat penting bagi lansia, terutama karena mereka lebih rentan terhadap risiko jatuh, cedera, dan perlakuan salah.

1. Lingkungan Aman: Tempat tinggal harus dirancang ramah lansia, seperti penerangan cukup, lantai tidak licin, pegangan di kamar mandi, dan tempat tidur dengan tinggi sesuai.
2. Pengawasan Obat: Polifarmasi dapat menyebabkan interaksi obat yang berbahaya. Perlu pengawasan dalam penggunaan obat sesuai dosis dan waktu.
3. Perlindungan dari Kekerasan: Lansia rawan mengalami kekerasan fisik, emosional, maupun finansial. Pemeriksaan rutin dan komunikasi terbuka dapat membantu mendeteksi tanda-tanda kekerasan.

H. Kebutuhan Sosial

Lansia memiliki kebutuhan untuk tetap merasa diterima dan dihargai dalam lingkungan sosialnya. Kehilangan pasangan hidup, pensiun, dan perpisahan dengan anak dapat memicu isolasi sosial.

1. Interaksi Sosial: Lansia perlu tetap terlibat dalam komunitas atau kelompok lansia agar merasa memiliki peran.
2. Hubungan Keluarga: Dukungan emosional dari keluarga membantu lansia mengatasi kesepian dan stres.
3. Kegiatan Sosial: Lansia didorong untuk mengikuti kegiatan keagamaan, rekreasi, atau edukatif yang sesuai dengan minatnya.

I. Kebutuhan Psikologis

Lansia membutuhkan penghargaan dan pengakuan terhadap eksistensinya.

1. Harga Diri: Lansia sering merasa tidak berguna setelah pensiun atau Ketika mengalami ketergantungan. Dukungan keluarga dan pemberian peran penting dalam rumah tangga dapat membantu meningkatkan harga diri.
2. Kebutuhan Dihargai: Perlakuan hormat dari keluarga dan tenaga kesehatan sangat penting agar lansia merasa dihormati.
3. Kemandirian: Lansia perlu didukung untuk tetap melakukan aktivitas harian secara mandiri sejauh kemampuannya memungkinkan.

J. Kebutuhan Spiritual

Kebutuhan spiritual berkaitan dengan pencarian makna hidup, koneksi dengan Tuhan, dan persiapan menghadapi kematian.

1. Makna Hidup: Lansia sering melakukan refleksi terhadap masa lalu dan mencari makna atas apa yang telah mereka jalani.

2. Ibadah: Lansia lebih aktif beribadah sebagai bentuk pencarian kedamaian batin. Fasilitas ibadah yang mudah diakses perlu disediakan.
3. Ketenangan Batin: Doa, meditasi, dan bimbingan rohani penting untuk mengurangi kecemasan terhadap kematian.

K. Paradigma Baru Pelayanan Kesehatan Lansia

Paradigma pelayanan kesehatan bergeser dari kuratif ke preventif dan promotif. Konsep "Healthy Aging" menjadi pusat perhatian, yaitu bagaimana lansia dapat tetap sehat, aktif, dan mandiri. Perawat berperan penting dalam mendorong lansia untuk memiliki pola hidup sehat, melakukan deteksi dini penyakit, dan melibatkan keluarga serta komunitas dalam proses perawatan. Pelayanan lansia harus berbasis komunitas, berkelanjutan, dan mendukung nilai-nilai kultural lokal.

L. Peran Perawat Gerontik di Berbagai Lini Pelayanan

Perawat gerontik memiliki peran yang luas, mulai dari pelayanan primer di Puskesmas, Posyandu Lansia, hingga ke rumah sakit dan pelayanan paliatif. Tugasnya meliputi edukasi kesehatan, asuhan langsung, kolaborasi interprofesional, advokasi hak lansia, serta perencanaan pulang dan perawatan rumah. Dalam pelayanan komunitas, perawat berfungsi sebagai fasilitator dan penggerak masyarakat dalam mendukung lansia menjalani hidup sehat dan bermartabat.

M. Latihan

Pilihan Ganda:

1. Berikut ini yang merupakan klasifikasi lansia menurut WHO adalah...
 - A. Lansia muda (50–64 tahun)
 - B. Lansia dewasa (65–74 tahun)
 - C. Lansia tua (75–89 tahun)
 - D. Lansia akhir (85–99 tahun)
 - E. Lansia sangat tua (80 tahun ke atas)
2. Salah satu perubahan fisiologis yang umum terjadi pada lansia adalah...
 - A. Peningkatan elastisitas kulit
 - B. Penurunan massa otot (sarkopenia)
 - C. Peningkatan daya ingat jangka pendek
 - D. Peningkatan sistem imun
 - E. Meningkatnya ketajaman pendengaran

3. Gangguan psikososial yang paling sering dialami oleh lansia adalah...
 - A. Euforia
 - B. Agitasi berlebihan
 - C. Depresi dan isolasi sosial
 - D. Delirium ringan
 - E. Mania
4. Yang termasuk kebutuhan spiritual lansia adalah...
 - A. Meningkatkan aktivitas fisik
 - B. Menurunkan tekanan darah
 - C. Mencari makna hidup dan kedamaian batin
 - D. Mengikuti program diet tinggi kalori
 - E. Menjalin interaksi sosial dengan anak-anak
5. Faktor yang paling memengaruhi pendekatan keperawatan pada lansia adalah...
 - A. Umur lansia saja
 - B. Jenis kelamin dan pendidikan
 - C. Kondisi fisik dan psikososial lansia
 - D. Status pernikahan
 - E. Golongan darah

Kunci Jawaban

1. C
2. B
3. C
4. C
5. C

N. Rangkuman Materi

Lansia merupakan kelompok populasi yang unik dan kompleks karena mengalami perubahan di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pendekatan keperawatan terhadap lansia harus bersifat komprehensif, individual, dan penuh empati. Dengan pemahaman yang baik terhadap konsep lansia, tenaga kesehatan dapat membantu lansia untuk menjalani masa tuanya secara bermartabat, aktif, dan berkualitas.

O. Glosarium

Lansia (Lanjut Usia) : Individu yang telah mencapai usia ≥ 60 tahun, baik menurut WHO maupun perundangan di Indonesia.

Penuaan : Proses alami yang menyebabkan penurunan bertahap fungsi fisiologis, psikologis, sosial, dan spiritual seiring bertambahnya usia.

Gerontologi : Ilmu yang mempelajari aspek biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi dari proses penuaan dan kehidupan lansia.

Geriatri : Cabang ilmu kedokteran yang khusus menangani diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit pada lansia.

Sarkopenia : Penurunan massa dan kekuatan otot yang terjadi seiring bertambahnya usia, menyebabkan kelemahan dan risiko jatuh pada lansia.

Osteoporosis: Kondisi tulang menjadi rapuh dan mudah patah akibat penurunan kepadatan tulang yang umum terjadi pada lansia, terutama wanita pasca-menopause.

Demensia : Sindrom yang ditandai dengan penurunan fungsi kognitif seperti daya ingat, orientasi, pemahaman, dan kemampuan berpikir, umumnya bersifat progresif.

Alzheimer: Bentuk paling umum dari demensia yang memengaruhi memori, perilaku, dan kemampuan berpikir pada lansia secara bertahap.

Depresi pada Lansia: Gangguan suasana hati yang sering dialami lansia akibat kehilangan, kesepian, atau penyakit kronis, ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan.

Inkontinensia: Ketidakmampuan menahan buang air kecil atau besar, sering terjadi pada lansia karena kelemahan otot panggul atau gangguan saraf.

Polifarmasi: Penggunaan lebih dari satu jenis obat secara bersamaan yang umum pada lansia dan berisiko menimbulkan interaksi obat atau efek samping.

Kebutuhan Dasar Lansia: Kebutuhan yang meliputi aspek fisik (nutrisi, istirahat), keamanan, sosial, psikologis, dan spiritual yang harus dipenuhi secara holistik.

Isolasi Sosial: Keadaan ketika lansia kehilangan kontak sosial yang bermakna, biasanya karena pensiun, kehilangan pasangan, atau keterbatasan fisik.

Penuaan Biologis : Perubahan struktural dan fungsional dalam tubuh yang disebabkan oleh proses penuaan alami, bukan karena penyakit.

Penuaan Kronologis : Penentuan usia berdasarkan waktu yang telah dilalui sejak lahir.

Kemandirian : Kemampuan lansia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa bergantung pada orang lain.

Kualitas Hidup Lansia : Tingkat kesejahteraan lansia yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Asuhan Keperawatan Lansia : Proses keperawatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan lansia dengan pendekatan yang empatik dan berfokus pada individu.

Spiritualitas Lansia : Dimensi kehidupan yang berkaitan dengan pencarian makna, tujuan hidup, dan hubungan dengan Tuhan atau kekuatan transenden lainnya.

Senam Lansia : Program latihan fisik ringan yang dirancang khusus untuk menjaga kebugaran dan keseimbangan tubuh lansia.

Geriatric Assessment : Pengkajian multidimensi yang mencakup fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan untuk menentukan status kesehatan lansia secara menyeluruh.

P. Daftar Pustaka

Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2010). *Family Nursing: Research, Theory, and Practice* (5th ed.). Pearson.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas*. Jakarta: Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer.

Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. (2020). *Fundamentals of Nursing: Concepts, Process and Practice* (9th ed.). Pearson Education.

LeMone, P., Burke, K. M., & Bauldoff, G. (2015). *Medical-Surgical Nursing: Critical Thinking in Patient Care* (6th ed.). Pearson.

Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2022). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). St. Louis: Elsevier.

Purnell, L. D. (2013). *Transcultural Health Care: A Culturally Competent Approach*. F. A. Davis Company.

Setiati, S., & Alwi, I. (Eds.). (2017). *Ilmu Kedokteran Geriatri*. Jakarta: EGC.

Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2010). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing* (12th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

Stuart, G. W. (2013). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing* (10th ed.). Mosby Elsevier.

World Health Organization (WHO). (2021). *World Report on Ageing and Health*. Geneva: World Health Organization.

BAB 2

MODEL KEPERAWATAN GERONTIK

Tujuan Intruksional:

1. Menjelaskan konsep model keperawatan Callista Roy.
2. Menjelaskan konsep model keperawatan Martha Rogers.
3. Menjelaskan konsep model keperawatan Betty Neuman.
4. Menjelaskan konsep model keperawatan Virginia Henderson.
5. Menjelaskan konsep model keperawatan Madeleine Leininger.
6. Menjelaskan konsep model keperawatan Dorothy E. Johnson.
7. Menjelaskan konsep model keperawatan Dorothea Orem.

Capaian Pembelajaran:

1. Menerapkan konsep model keperawatan Callista Roy dalam keperawatan gerontik.
2. Menerapkan model keperawatan Martha Rogers dalam keperawatan gerontik.
3. Menerapkan model keperawatan Betty Neuman dalam keperawatan gerontik.
4. Menerapkan model keperawatan Virginia Henderson dalam keperawatan gerontik.
5. Menerapkan model keperawatan Madeleine Leininger dalam keperawatan gerontik.
6. Menerapkan model keperawatan Dorothy E. Johnson dalam keperawatan gerontik.
7. Menerapkan model keperawatan Dorothea Orem dalam keperawatan gerontik.

Uraian Materi

Populasi lanjut usia (lansia) di seluruh dunia terus mengalami peningkatan yang signifikan akibat kemajuan di bidang kesehatan, teknologi, dan kesejahteraan sosial. Namun, seiring bertambahnya usia, lansia sering kali menghadapi berbagai tantangan kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Hal ini memerlukan pendekatan keperawatan yang terintegrasi dan berpusat pada kebutuhan spesifik lansia untuk mendukung kualitas hidup mereka secara holistik.

Model keperawatan gerontik adalah pendekatan yang dirancang untuk memberikan kerangka kerja dalam merawat lansia dengan mempertimbangkan berbagai dimensi kebutuhan mereka. Model ini mengintegrasikan teori keperawatan, konsep penuaan sehat, serta prinsip-prinsip perawatan berpusat pada individu. Dengan fokus pada pencegahan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas hidup, model ini membantu perawat memahami kompleksitas kondisi lansia dan menyediakan intervensi yang efektif dan humanistik.

Bab ini akan membahas berbagai model keperawatan gerontik, termasuk landasan teoritis, penerapan praktis, serta dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Dengan memahami model-model ini, diharapkan perawat dapat memberikan pelayanan yang profesional dan adaptif terhadap kebutuhan lansia yang terus berkembang.

A. Definisi Model Keperawatan

Model keperawatan adalah kerangka kerja teoretis yang digunakan untuk memandu praktik keperawatan, memberikan pemahaman tentang konsep-konsep inti seperti individu, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan itu sendiri. Model ini berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan, sehingga menciptakan pendekatan yang konsisten, holistik, dan berfokus pada kebutuhan pasien (Alligood, 2017).

Model keperawatan adalah representasi konseptual yang memberikan panduan untuk memahami hubungan antara manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan, serta membantu dalam pengambilan keputusan klinis berdasarkan prinsip-prinsip profesional. Model ini bertujuan untuk menciptakan praktik keperawatan yang berorientasi pada kebutuhan pasien (Risnah & Irwan, 2021).

Model keperawatan adalah kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori dan praktik keperawatan, berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan asuhan yang komprehensif kepada individu, keluarga, dan komunitas (Munandar et al., 2020).

Definisi-definisi ini menekankan pentingnya model keperawatan sebagai

kerangka kerja yang menggabungkan teori dan praktik untuk memberikan asuhan yang holistik dan adaptif sesuai dengan kebutuhan pasien.

B. Definisi Model Keperawatan Gerontik

Model keperawatan gerontik adalah kerangka kerja konseptual yang dirancang untuk mengidentifikasi, memahami, dan memenuhi kebutuhan spesifik lansia melalui pendekatan yang holistik, adaptif, dan berpusat pada individu. Model ini memadukan teori keperawatan, prinsip penuaan sehat, dan strategi perawatan berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas hidup lansia di berbagai aspek, termasuk fisik, psikologis, sosial, dan spiritual (Touhy & Jett, 2020).

Model keperawatan gerontik adalah pendekatan sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan yang berfokus pada optimalisasi kesehatan fisik, mental, dan sosial lanjut usia. Model ini dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan unik lansia dan menyediakan intervensi berbasis bukti yang mendukung penuaan sehat dan kualitas hidup yang lebih baik (Stanhope & Lancaster, 2020)

Model keperawatan gerontik mencakup pendekatan holistik untuk memahami dan merespons perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial yang terjadi pada lansia. Model ini memprioritaskan pencegahan komplikasi, promosi kesehatan, serta adaptasi terhadap perubahan fungsional yang terjadi selama proses penuaan (Boltz et al., 2016).

Definisi ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam asuhan keperawatan bagi lansia, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

C. Model Keperawatan Gerontik (Callista Roy)

Model Konseptual Adaptasi Callista Roy dalam keperawatan gerontik menekankan. Roy melihat manusia sebagai sistem yang saling berinteraksi dengan lingkungannya, dan keberhasilan adaptasi bergantung pada kemampuan individu untuk mengatasi tantangan yang ada (Roy, 2009).

Dalam konteks gerontik, model ini sangat relevan karena lansia sering mengalami perubahan dalam banyak aspek kehidupan, seperti penurunan fungsi fisik, masalah kesehatan kronis, penurunan kognitif, dan perubahan dalam hubungan sosial. Model ini memberikan panduan bagi perawat untuk memahami bagaimana lansia merespons dan beradaptasi terhadap perubahan tersebut, serta bagaimana perawat dapat membantu memfasilitasi adaptasi yang lebih baik melalui intervensi yang sesuai.

Model Adaptasi Roy terdiri dari empat komponen utama (Roy, 2011):

1. Sistem adaptasi: Manusia dianggap sebagai sistem terbuka yang berinteraksi

dengan lingkungan dan beradaptasi untuk mempertahankan keseimbangan dan kesejahteraan. Dalam konteks gerontik, lansia dianggap harus mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi, baik itu perubahan fisik (misalnya penurunan kemampuan tubuh), perubahan sosial (misalnya peran sosial yang berubah), atau masalah kesehatan lainnya.

2. Proses adaptasi: Lansia beradaptasi terhadap stresor melalui dua cara utama:
 - a. Fungsi Regulator: Merupakan respons fisiologis atau biologis terhadap stresor. Sebagai contoh, tubuh lansia akan mengalami penurunan fungsi organ, sehingga mereka perlu beradaptasi dengan cara menjaga pola makan, olahraga ringan, dan pengelolaan penyakit.
 - b. Fungsi Kontrol: Merupakan respons sosial atau psikologis terhadap perubahan. Lansia perlu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam peran sosial, hubungan keluarga, atau perasaan diri, yang sering kali dipengaruhi oleh isolasi sosial atau kehilangan orang yang mereka cintai.
3. Lingkungan: Roy menyebutkan bahwa lingkungan (baik internal maupun eksternal) memengaruhi kemampuan individu untuk beradaptasi. Dalam keperawatan gerontik, lingkungan ini termasuk rumah tinggal, keluarga, perawatan medis, dan dukungan sosial yang dapat memengaruhi kemampuan lansia untuk menyesuaikan diri.
4. Tujuan adaptasi: Tujuan utama dari adaptasi adalah untuk mempertahankan keseimbangan dan kesejahteraan. Dalam konteks lansia, perawat bekerja untuk membantu lansia beradaptasi agar mereka dapat mempertahankan fungsi optimal, kualitas hidup yang baik, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan sehari-hari.

Dalam keperawatan gerontik, perawat menggunakan Model Adaptasi Roy untuk membantu lansia mengatasi masalah kesehatan, penurunan fisik, perubahan sosial, serta perasaan kesepian atau stres. Perawat berfokus pada penilaian kebutuhan lansia dalam menghadapi tantangan hidup mereka dan memberikan dukungan untuk memfasilitasi proses adaptasi, baik melalui pengelolaan kondisi medis maupun peningkatan dukungan sosial dan emosional.

Perawat berperan dalam mendukung lansia dengan cara:

1. Menilai respons adaptif mereka terhadap perubahan fisik dan sosial.
2. Memberikan intervensi untuk membantu mereka mengatasi hambatan atau stresor.
3. Mengubah lingkungan untuk mendukung adaptasi yang lebih baik.

Model Adaptasi Callista Roy mencakup berbagai mode yang menjelaskan bagaimana individu beradaptasi terhadap berbagai perubahan dalam hidup mereka. Dalam konteks keperawatan gerontik, perawat perlu mempertimbangkan lima

mode utama dalam adaptasi, yaitu biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Keberhasilan lansia dalam beradaptasi dengan perubahan yang terjadi sering kali bergantung pada seberapa baik mereka dapat mengelola dan menanggapi faktor-faktor yang ada di setiap mode ini (Zhang et al., 2021).

1. Mode biologis (*physiological mode*)

Mode biologis berkaitan dengan respons fisiologis tubuh terhadap perubahan fisik yang terjadi pada lansia. Ini mencakup perubahan dalam sistem organ tubuh, penurunan kekuatan fisik, dan kondisi kesehatan yang lebih rentan terhadap penyakit kronis (seperti diabetes, hipertensi, osteoarthritis) atau gangguan fisik lainnya. Lansia juga bisa mengalami penurunan kemampuan tubuh dalam beradaptasi dengan stresor fisik.

Peran perawat dalam mode biologis:

- a. Pemantauan dan pengelolaan kesehatan: Membantu lansia dalam pengelolaan kondisi medis mereka, memberikan edukasi tentang perawatan diri, serta memfasilitasi pemulihan dan pemeliharaan kesehatan.
- b. Intervensi medis: Menyediakan pengobatan yang sesuai dan mengawasi efek samping yang mungkin terjadi pada lansia.
- c. Pencegahan masalah kesehatan: Membantu lansia dengan pencegahan penyakit dan menjaga kualitas hidup mereka melalui pola makan sehat, olahraga ringan, dan manajemen stres.

2. Mode psikologis (*cognitive-emotional mode*)

Mode psikologis melibatkan aspek kognitif dan emosional lansia dalam menghadapi perubahan hidup. Ini mencakup penurunan kemampuan kognitif, seperti gangguan memori, serta respons emosional terhadap masalah hidup, seperti kecemasan, depresi, atau perasaan kehilangan (misalnya kehilangan pasangan atau teman). Lansia mungkin mengalami kesulitan dalam menerima perubahan atau merasa kesepian dan terisolasi.

Peran perawat dalam mode psikologis:

- a. Dukungan emosional: Memberikan dukungan psikologis untuk membantu lansia mengelola perasaan kesepian, depresi, kecemasan, atau perasaan kehilangan.
- b. Pengembangan keterampilan kognitif: Membantu lansia mempertahankan atau meningkatkan kapasitas kognitif mereka melalui aktivitas yang merangsang otak atau terapi kognitif.
- c. Intervensi psikologis: Memberikan dukungan untuk mengurangi stres emosional dan meningkatkan ketahanan psikologis lansia.

3. Mode sosial (*role function mode*)

Mode sosial berkaitan dengan perubahan dalam peran sosial lansia.

Perubahan ini bisa meliputi pensiun, peran sebagai orang tua atau kakek/nenek, atau hilangnya peran sosial penting lainnya akibat penurunan fisik atau mental. Lansia mungkin merasa terisolasi atau kehilangan rasa identitas akibat perubahan peran ini.

Peran perawat dalam mode sosial:

- a. Pemberdayaan peran sosial: Membantu lansia menemukan peran baru dalam kehidupan mereka, baik di dalam keluarga maupun masyarakat.
- b. Interaksi sosial: Mendorong lansia untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, baik dengan keluarga, teman, atau kelompok pendukung.
- c. Mengurangi isolasi sosial: Membantu lansia membangun atau memelihara hubungan sosial yang bermakna untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

4. Mode kultural (*cultural mode*)

Mode kultural berkaitan dengan nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi budaya yang memengaruhi cara lansia beradaptasi terhadap perubahan dalam hidup mereka. Setiap budaya memiliki cara yang berbeda dalam merespons penuaan, perubahan peran sosial, dan penyakit. Lansia sering kali dipengaruhi oleh tradisi atau cara pandang budaya mereka tentang penuaan dan bagaimana mereka seharusnya beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Peran perawat dalam mode kultural:

- a. Penghormatan terhadap budaya: Memahami dan menghormati keyakinan budaya lansia yang mungkin memengaruhi perawatan medis dan sosial mereka.
- b. Penyesuaian perawatan sesuai budaya: Memberikan perawatan yang sensitif terhadap nilai budaya lansia dan mengintegrasikan aspek budaya dalam pengelolaan kesehatan.
- c. Edukasi budaya: Meningkatkan kesadaran perawat terhadap perbedaan budaya dan menghindari pendekatan yang tidak sensitif terhadap perbedaan tersebut.

5. Mode spiritual (*spiritual mode*)

Mode spiritual berhubungan dengan keyakinan dan nilai-nilai spiritual lansia yang memberi mereka makna dan tujuan hidup. Lansia sering kali mencari makna dan kenyamanan dalam keyakinan agama atau spiritualitas mereka, terutama dalam menghadapi akhir hayat, penyakit, atau perasaan kehilangan.

Peran perawat dalam mode spiritual:

- a. Dukungan spiritual: Memberikan dukungan yang sesuai dengan keyakinan spiritual atau agama lansia, yang dapat mencakup doa, meditasi, tujuan hidup dan makna hidup.
- b. Pemberian kenyamanan: Membantu lansia menemukan ketenangan dan

penghiburan melalui pendekatan spiritual yang sesuai dengan nilai mereka.

- c. Menghargai keyakinan pribadi: Menghargai dan mendukung kebutuhan spiritual lansia dalam proses perawatan mereka, serta bekerja sama dengan pemimpin agama atau konselor spiritual jika diperlukan.

D. Model Keperawatan Gerontik (Martha Rogers)

Model Konseptual *Human Being* yang dikembangkan oleh Martha Rogers adalah teori yang sering digunakan dalam keperawatan, termasuk dalam konteks keperawatan gerontik. Dalam pandangan Rogers, manusia tidak dipandang hanya sebagai entitas fisik atau psikologis, tetapi sebagai suatu sistem energi yang utuh dan terus-menerus terhubung dengan lingkungan (Bauman et al., 2014). Teori ini memberikan dasar untuk memahami kompleksitas manusia secara holistik, yang sangat penting dalam perawatan lansia.

Model Human Being Rogers terdiri dari empat komponen utama (Report & Kabusi, 2024):

1. Manusia sebagai sistem energi: Rogers memandang manusia sebagai sistem energi yang terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan. Ini mencakup seluruh dimensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual individu. Dalam konteks gerontik, lansia dianggap sebagai individu yang terus berkembang dan beradaptasi meskipun menghadapi perubahan fisik dan kognitif yang berkaitan dengan penuaan.
2. Medan energi: Rogers mengembangkan konsep medan energi, yaitu ruang yang lebih besar dari sekadar tubuh fisik individu. Medan ini melibatkan hubungan antara individu dengan lingkungannya. Lansia, sebagai bagian dari sistem energi ini, memiliki potensi untuk berinteraksi dan memengaruhi lingkungan mereka. Di dalam perawatan gerontik, konsep ini membantu perawat untuk melihat lansia bukan hanya sebagai pasien yang membutuhkan perawatan, tetapi sebagai individu yang memiliki hubungan dinamis dengan lingkungannya.
3. Integritas dan keutuhan: Rogers menekankan bahwa setiap individu, termasuk lansia, memiliki keutuhan dan integritas sebagai manusia. Dalam perawatan gerontik, ini berarti bahwa perawat harus memperlakukan lansia sebagai individu yang memiliki martabat dan hak untuk menjalani kehidupan dengan penuh makna, meskipun mereka menghadapi penurunan fisik atau mental.
4. Perubahan dan adaptasi: Model ini mengakui bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk dalam penuaan. Lansia mengalami berbagai perubahan yang memengaruhi fisik, mental, dan sosialnya, dan keperawatan gerontik harus mendukung lansia dalam beradaptasi dengan perubahan ini melalui pemberdayaan dan dukungan berkelanjutan.

Aplikasi teori *Human Being* dari Martha Rogers dalam keperawatan gerontik melibatkan pendekatan holistik terhadap lansia, di mana perawat melihat individu sebagai kesatuan yang terorganisir secara energi dan selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Teori ini menganggap bahwa manusia (termasuk lansia)

bukan sekadar bagian tubuh atau fungsi biologis, tetapi merupakan entitas yang lebih luas yang melibatkan dimensi fisik, mental, emosional, dan sosial. Dalam konteks gerontik, penerapan teori ini dapat dilihat dalam beberapa cara sebagai berikut:

1. Pendekatan holistik dalam perawatan lansia

Rogers mengajarkan bahwa manusia adalah sistem energi yang terus berkembang. Dalam keperawatan gerontik, perawat harus mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan lansia, tidak hanya masalah fisik atau medis. Ini berarti bahwa lansia diperlakukan sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang meskipun mengalami perubahan terkait usia. Perawat dapat menggunakan prinsip ini untuk merancang perawatan yang berfokus pada kesejahteraan fisik, emosional, sosial, dan spiritual lansia.

2. Interaksi dengan lingkungan

Teori ini menekankan pentingnya hubungan antara individu dengan lingkungan mereka. Lansia sering kali mengalami perubahan dalam hubungan sosial dan lingkungan mereka seiring penuaan, yang dapat memengaruhi kesejahteraan mereka. Dengan memahami lansia sebagai entitas yang berinteraksi dengan lingkungan mereka, perawat dapat membantu lansia menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kesejahteraan lansia, baik dari segi fisik, emosional, sosial maupun spiritual. Contohnya, perawat bisa membantu lansia untuk tetap terhubung dengan keluarga atau komunitas, atau menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.

3. Fokus pada proses adaptasi

Rogers menekankan konsep *homeodynamics* atau keseimbangan dinamis yang selalu berubah antara individu dan lingkungannya. Dalam keperawatan gerontik, hal ini dapat diterjemahkan menjadi fokus pada bagaimana lansia beradaptasi dengan perubahan yang datang dengan penuaan, seperti perubahan fisik, kognitif, emosional atau sosial. Perawat dapat membantu lansia untuk beradaptasi dengan cara meningkatkan kualitas hidup mereka, seperti memberikan dukungan emosional atau merencanakan kegiatan yang sesuai dengan kapasitas mereka.

4. Penggunaan teknologi dan inovasi

Teori ini memungkinkan perawat untuk menerapkan teknologi dalam memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia. Misalnya, penggunaan teknologi untuk memantau kondisi kesehatan lansia, atau penggunaan alat bantu yang membantu lansia tetap aktif dan mandiri. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip Rogers yang melihat manusia sebagai entitas yang dinamis dan berpotensi berkembang meski dalam kondisi yang

terbatas oleh usia atau penyakit.

E. Model Keperawatan Gerontik (Betty Neuman)

Model Konseptual Betty Neuman, yang dikenal dengan Neuman Systems Model (NSM), adalah salah satu model yang sering diterapkan dalam keperawatan gerontik. Model ini berfokus pada pendekatan holistik terhadap individu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kesehatannya. Model ini menggambarkan individu sebagai suatu sistem yang memiliki batas-batas, dengan interaksi yang dinamis antara berbagai elemen dalam sistem tersebut, seperti fisik, psikologis, sosial, dan spiritual (Neuman, 2001). Keberhasilan perawatan bergantung pada kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara faktor-faktor ini.

Dalam konteks keperawatan gerontik, model ini memberikan penekanan pada pentingnya mengenali dan menangani stresor yang mungkin memengaruhi individu lanjut usia, baik yang bersifat fisik maupun psikososial. Neuman menyatakan bahwa individu rentan terhadap stresor yang dapat mengganggu keseimbangan dan kesehatan mereka. Stresor ini dapat datang dari berbagai sumber, termasuk lingkungan, keluarga, atau masalah kesehatan yang berkaitan dengan usia.

Konsep utama dalam Neuman System Model adalah tentang garis pertahanan diri (*lines of defense*) yang menggambarkan bagaimana individu, termasuk lansia, dapat mempertahankan keseimbangan dan kesehatan mereka dengan melawan stresor dari lingkungan atau faktor internal yang berpotensi merusak. Konsep ini sangat relevan dalam keperawatan gerontik, karena lansia sering menghadapi peningkatan kerentanannya terhadap stresor fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Dalam keperawatan gerontik, garis pertahanan diri digunakan untuk merancang intervensi yang mengutamakan penguatan sistem pertahanan tubuh, agar lansia dapat mempertahankan keseimbangan yang optimal.

Terdapat tiga garis pertahanan diri, yang berfungsi untuk melindungi individu dari stresor yang dapat mengganggu kesehatannya. Garis-garis pertahanan ini berlapis, dengan garis yang lebih dalam bertindak sebagai perlindungan yang lebih kuat. Garis pertahanan ini terdiri dari (Ahmadi & Sadeghi, 2017):

1. Garis Pertahanan Normal (*Normal Line of Defense*)

Garis ini menggambarkan keseimbangan kesehatan individu dalam keadaan normal, sebelum terjadi gangguan atau stres. Pada lansia, garis pertahanan normal bisa berupa kondisi fisik dan mental yang sehat, seperti: Pola makan yang seimbang, Aktivitas fisik yang cukup, Hubungan sosial yang mendukung, Kesehatan mental yang stabil.

2. Garis Pertahanan Perifer (*Flexible Line of Defense*)

Garis ini lebih fleksibel dan merupakan lapisan pertama yang melindungi tubuh dari stresor eksternal. Dalam konteks lansia, stresor eksternal bisa datang dari berbagai faktor, seperti lingkungan yang tidak aman, masalah sosial, atau penyakit yang mendekat. Garis ini bertindak sebagai batas pertama yang merespons perubahan lingkungan dan berusaha mengembalikan individu ke keadaan normal.

3. Garis Pertahanan Rintangan (*Line of Resistance*)

Garis ini terletak lebih dalam, di sekitar inti individu dan bertindak sebagai sistem pertahanan terakhir yang melawan stresor atau ancaman kesehatan yang lebih besar. Jika stresor berhasil melewati garis pertahanan perifer, maka garis pertahanan rintangan akan bekerja untuk memulihkan keseimbangan. Garis ini berfungsi untuk memperbaiki atau mempertahankan fungsi tubuh, baik secara fisik maupun mental.

Neuman Systems Model mengidentifikasi tiga tingkatan pencegahan terhadap stressor, yaitu (Kabusi & Yazdi, 2024):

1. Pencegahan primer (*Primary prevention*): Menghindari atau mengurangi stresor sebelum memengaruhi individu.
2. Pencegahan sekunder (*Secondary prevention*): Intervensi untuk mengurangi dampak stresor setelah terjadinya gangguan.
3. Pencegahan tersier (*Tertiary prevention*): Pemulihan dan pengembalian individu ke keadaan keseimbangan setelah gangguan.

Aplikasi garis pertahanan diri dalam teori Betty Neuman dapat dipahami dengan mengidentifikasi tingkatan pencegahan yang ada dalam model ini. Model ini menekankan pentingnya melindungi individu dari stresor yang dapat mengganggu keseimbangan mereka. Dalam konteks keperawatan gerontik, teori ini sangat relevan karena lansia sering kali lebih rentan terhadap berbagai faktor stres yang dapat memengaruhi fisik, psikologis, dan sosial mereka. Betty Neuman membagi pencegahan ke dalam tiga tingkatan, yang berfungsi untuk memperkuat garis pertahanan diri lansia.

1. Pencegahan primer (*Primary prevention*)

Pencegahan primer berfokus pada upaya untuk menghindari stresor atau masalah kesehatan sebelum terjadi. Pada tingkat ini, perawat bertindak proaktif untuk memelihara keseimbangan tubuh dan mencegah gangguan kesehatan yang mungkin muncul.

Aplikasi dalam keperawatan gerontik:

- a. Mendukung gaya hidup sehat: Perawat dapat mengedukasi lansia tentang pentingnya pola makan seimbang, berolahraga secara teratur, dan menjaga kebugaran fisik.

- b. Mencegah masalah fisik: Pemberian vaksinasi (seperti vaksin flu atau pneumonia), pemeriksaan kesehatan rutin untuk mendeteksi dini masalah kesehatan, serta edukasi mengenai pencegahan jatuh dan cedera di rumah.
- c. Mencegah gangguan psikologis: Program-program pencegahan seperti dukungan sosial, terapi kelompok, atau kegiatan yang memperkuat ikatan sosial antara lansia dapat membantu mengurangi risiko depresi atau kecemasan.
- d. Pencegahan masalah lingkungan: Menata rumah lansia agar lebih aman, seperti memasang pegangan tangan di kamar mandi dan memastikan penerangan yang cukup, guna mencegah kecelakaan dan cedera.

Dengan pencegahan primer, perawat bekerja pada garis pertahanan yang lebih luar, yaitu garis pertahanan fleksibel yang berfungsi untuk memblokir stresor yang dapat mengganggu keseimbangan sebelum stresor tersebut memengaruhi individu.

2. Pencegahan sekunder (*Secondary prevention*)

Pencegahan sekunder berfokus pada deteksi dini dan intervensi untuk mengurangi dampak dari stresor yang sudah mulai memengaruhi individu. Pada tingkat ini, garis pertahanan tubuh akan terstimulasi dan bertindak untuk mengembalikan keseimbangan tubuh yang terancam oleh gangguan atau penyakit.

Aplikasi dalam keperawatan gerontik:

- a. Deteksi dini masalah kesehatan: Melakukan pemeriksaan rutin seperti skrining untuk depresi, diabetes, hipertensi, atau osteoporosis pada lansia untuk mengetahui adanya masalah kesehatan lebih awal.
- b. Pengobatan dan intervensi dini: Setelah gangguan kesehatan terdeteksi, perawat dapat merencanakan pengobatan atau terapi untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah. Misalnya, merawat luka atau infeksi, memberikan terapi fisik untuk mengatasi kelemahan otot, atau memberikan obat untuk mengelola penyakit kronis.
- c. Pengelolaan stres psikologis: Jika lansia mulai menunjukkan gejala kecemasan atau depresi, perawat dapat memberikan dukungan psikologis atau merujuk mereka untuk terapi atau konseling.
- d. Pendampingan dalam rehabilitasi: Untuk lansia yang mengalami cedera atau penyakit yang membatasi fungsi, perawat dapat berperan dalam membantu pemulihan dan rehabilitasi fisik untuk mengembalikan mobilitas dan kemandirian mereka.

Pencegahan sekunder berfokus pada garis pertahanan perifer atau garis pertahanan rintangan, yang aktif dalam merespons masalah yang sudah terjadi

dan mengurangi dampak dari gangguan kesehatan yang telah teridentifikasi.

3. Pencegahan tersier (*Tertiary prevention*)

Pencegahan tersier berfokus pada upaya untuk memulihkan atau mengembalikan individu ke kondisi seimbang setelah terjadi gangguan yang lebih serius. Ini melibatkan pemulihan, pengelolaan jangka panjang, dan pencegahan komplikasi lebih lanjut dari penyakit atau kondisi kronis.

Aplikasi dalam keperawatan gerontik:

- a. Pengelolaan penyakit kronis: Perawat dapat membantu lansia dalam mengelola penyakit jangka panjang seperti diabetes, hipertensi, atau arthritis, dengan memberikan perawatan yang berkelanjutan dan memastikan mereka mematuhi pengobatan yang diresepkan.
- b. Rehabilitasi pasca-cedera: Setelah lansia mengalami kecelakaan atau kondisi medis serius (seperti stroke atau serangan jantung), pencegahan tersier berfokus pada rehabilitasi fisik dan psikologis untuk memulihkan fungsi tubuh atau meningkatkan kualitas hidup lansia.
- c. Perawatan paliatif: Pada lansia yang menghadapi penyakit terminal, perawatan paliatif untuk mengurangi rasa sakit, meningkatkan kenyamanan, dan mendukung kualitas hidup yang optimal sangat penting. Perawat bekerja dengan tim medis untuk memastikan bahwa kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual lansia terpenuhi.
- d. Dukungan sosial dan emosional: Perawat juga berperan dalam memberikan dukungan psikologis untuk lansia yang berjuang dengan isolasi sosial atau depresi akibat kondisi fisik yang menurun.

Pencegahan tersier bekerja di garis pertahanan rintangan, yang lebih dalam, dan bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan setelah terjadi gangguan besar, serta meminimalkan komplikasi lebih lanjut dari kondisi yang ada.

F. Model Keperawatan Gerontik (Virginia Henderson)

Virginia Henderson mengembangkan Teori Kebutuhan Dasar, yang berfokus pada peran perawat dalam membantu individu memenuhi kebutuhan dasar yang esensial bagi kesehatan. Henderson mendefinisikan keperawatan sebagai membantu individu, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, untuk melakukan aktivitas yang mendukung kesehatan, pemulihan, atau kematian yang damai (Ahtisham & Jacoline, 2015). Teori ini menekankan bahwa perawat harus mendukung pasien untuk menjadi mandiri secepat mungkin.

Inti dari definisi ini:

1. Perawat membantu memenuhi kebutuhan dasar yang tidak dapat dilakukan pasien.
2. Tujuan utama adalah mencapai kemandirian pasien.

3. Perawatan melibatkan pendekatan holistik, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Virginia Henderson mengembangkan teori keperawatan yang berfokus pada pemenuhan **14 kebutuhan dasar manusia** untuk mendukung individu mencapai kemandirian. Dalam keperawatan gerontik, teori ini digunakan untuk memberikan perawatan holistik yang mempertimbangkan perubahan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pada lansia (Ahtisham & Jacoline, 2015; Potter & Perry, 2021).

1. Bernafas secara normal

Penurunan fungsi tubuh pada lansia:

- Elastisitas paru-paru menurun, menyebabkan penurunan kapasitas vital paru-paru.
- Efisiensi pertukaran gas berkurang karena perubahan struktur alveolus.

Aplikasi:

- Monitor pola pernapasan dan saturasi oksigen.
- Ajarkan teknik pernapasan (misalnya, pursed-lip breathing) untuk meningkatkan fungsi paru-paru.

2. Makan dan minum secara cukup

Penurunan fungsi tubuh pada lansia:

- Penurunan indera pengecap dan penciuman menyebabkan penurunan nafsu makan.
- Atrofi otot faring menyebabkan disfagia (kesulitan menelan), malnutrisi akibat penurunan nafsu makan dan dehidrasi akibat asupan cairan yang tidak cukup.

Aplikasi:

- Berikan diet kaya nutrisi dan sesuai kebutuhan individu.
- Pastikan hidrasi cukup dengan memantau asupan cairan.

3. Eliminasi (buang air besar/kecil) secara memadai.

Penurunan fungsi tubuh pada lansia:

- Penurunan kontraktilitas otot usus menyebabkan konstipasi.
- Penurunan elastisitas kandung kemih meningkatkan risiko inkontinensia.

Aplikasi:

- Edukasi diet tinggi serat dan hidrasi untuk konstipasi.
- Latihan kandung kemih untuk mengurangi inkontinensia.

4. Bergerak dan mempertahankan postur tubuh yang sesuai.

Penurunan fungsi tubuh pada lansia:

- Sarkopenia (penurunan massa otot) menyebabkan kelemahan fisik.
- Penurunan kepadatan tulang meningkatkan risiko osteoporosis dan fraktur.
- Gangguan keseimbangan tubuh menyebabkan resiko jatuh. Kelemahan otot menyebabkan kesulitan mengubah posisi.

Aplikasi:

- Latihan mobilisasi ringan untuk meningkatkan kekuatan otot.
- Berikan alat bantu mobilitas seperti walker atau tongkat.

5. Tidur dan istirahat.

Penurunan fungsi tubuh pada lansia:

- Perubahan pola tidur seperti penurunan fase tidur dalam (deep sleep).
- Gangguan ritme sirkadian akibat penurunan produksi melatonin.
- Nyeri kronis atau efek samping obat menyebabkan Insomnia.

Aplikasi:

- Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan bebas gangguan.
- Anjurkan rutinitas tidur yang konsisten.

6. Memilih pakaian yang sesuai (termasuk melepas dan memakai pakaian).

Penurunan fungsi tubuh pada lansia:

- Penurunan koordinasi motorik halus memengaruhi kemampuan berpakaian.
- Nyeri artritis membatasi gerakan.

Aplikasi:

- Bantu memilih pakaian yang mudah dipakai.
- Ajarkan cara berpakaian mandiri menggunakan alat bantu jika diperlukan.

7. Menjaga suhu tubuh dalam batas normal.

Penurunan fungsi tubuh pada lansia:

- Penurunan respons vasokonstriksi atau vasodilatasi menyebabkan ketidakmampuan mempertahankan suhu tubuh.
- Penurunan massa otot dan lemak subkutan menyebabkan intoleransi terhadap suhu dingin.

Aplikasi:

- Pastikan lansia mengenakan pakaian yang sesuai cuaca.
- Monitor suhu lingkungan untuk mencegah kondisi ekstrem.

8. Menjaga kebersihan dan integritas kulit.

Penurunan fungsi tubuh pada lansia:

- Keterbatasan mobilitas fisik memengaruhi kemampuan menjaga kebersihan diri.
- Penurunan penglihatan mempersulit pengamatan terhadap kebersihan.

Aplikasi:

- Berikan bantuan untuk aktivitas seperti mandi atau mencuci rambut.
- Edukasi keluarga tentang pentingnya menjaga kebersihan lansia.

9. Menghindari bahaya di lingkungan.

Penurunan fungsi tubuh pada lansia:

- Penurunan keseimbangan dan proprioepsi (kemampuan merasakan posisi tubuh) meningkatkan risiko jatuh.
- Penurunan penglihatan (misalnya, katarak) dan pendengaran menyebabkan keterbatasan deteksi bahaya.

Aplikasi:

- Lakukan asesmen lingkungan untuk mengurangi bahaya seperti karpet longgar.
- Berikan edukasi tentang teknik berjalan yang aman.

10. Berkomunikasi dengan orang lain.

Penurunan fungsi tubuh pada lansia:

- Gangguan pendengaran (presbikusis) memengaruhi komunikasi verbal.

- Penurunan fungsi kognitif seperti demensia mengurangi kemampuan ekspresi.

Aplikasi:

- Gunakan pendekatan yang empati untuk mendengar keluhan lansia.
- Sediakan alat bantu dengar jika diperlukan.

11. Menyembah sesuai keyakinan agama.

Penurunan fungsi tubuh pada lansia:

- Mobilitas terbatas menghalangi partisipasi dalam aktivitas spiritual di luar rumah.
- Kesulitan memahami teks atau doa karena penurunan penglihatan atau pendengaran.

Aplikasi:

- Fasilitasi lansia untuk beribadah sesuai keyakinan.
- Libatkan komunitas spiritual untuk mendukung kesejahteraan lansia.

12. Bekerja untuk menghasilkan pencapaian.

Penurunan fungsi tubuh pada lansia:

- Keterbatasan fisik dan kognitif membatasi kemampuan berkontribusi secara aktif.
- Kehilangan pekerjaan atau pensiun mengurangi rasa makna diri.

Aplikasi:

- Libatkan lansia dalam kegiatan bermakna seperti berkebun atau terapi seni.
- Dorong partisipasi dalam pekerjaan ringan yang mereka nikmati.

13. Bermain atau berpartisipasi dalam rekreasi.

Penurunan fungsi tubuh pada lansia:

- Penurunan stamina dan energi mengurangi keterlibatan dalam aktivitas rekreasi.
- Isolasi sosial membatasi akses ke kegiatan kelompok.

Aplikasi:

- Ajak lansia berpartisipasi dalam aktivitas sosial seperti terapi kelompok.
- Fasilitasi hobi sesuai dengan minat lansia.

14. Belajar atau menemukan kepuasan melalui pendidikan.

Penurunan fungsi tubuh pada lansia:

- Penurunan fungsi kognitif seperti memori kerja memengaruhi kemampuan belajar.
- Kesulitan mengadopsi teknologi baru karena keterbatasan pengalaman sebelumnya.

Aplikasi:

- Berikan edukasi kesehatan, misalnya cara mengelola penyakit kronis.
- Ajak lansia mengikuti kursus atau pelatihan untuk keterampilan baru.

G. Model Keperawatan Gerontik (Madeleine Leininger)

Madeleine Leininger mengembangkan konsep teori keperawatan transkultural yang dikenal sebagai Culture Care Diversity and Universality Theory. Teori ini

menekankan pentingnya budaya dalam praktik keperawatan. Teori ini berfokus pada bagaimana perbedaan budaya memengaruhi nilai, keyakinan, dan praktik kesehatan individu atau kelompok, serta bagaimana perawat dapat memberikan perawatan yang sensitif budaya.

Menurut Leininger, keperawatan transkultural bertujuan untuk memberikan perawatan berbasis budaya yang bermakna, yang mendukung atau memfasilitasi kesehatan dan kesejahteraan, atau membantu individu menghadapi penyakit dan kematian sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka. Ada tujuh faktor yang memengaruhi budaya yang harus dipahami oleh perawat untuk memberikan perawatan sensitif budaya. Ketujuh faktor ini memengaruhi kepercayaan, nilai, praktik kesehatan, dan keputusan pasien dalam berbagai konteks, termasuk keperawatan gerontik (Mc Farland & Wehbe-Alamah, 2019).

1. Teknologi

Kemajuan teknologi memengaruhi cara individu mengakses dan memanfaatkan layanan kesehatan. Beberapa budaya mungkin memiliki tingkat penerimaan yang rendah terhadap teknologi kesehatan modern karena kurangnya pemahaman atau ketidakcocokan dengan nilai budaya.

Contoh dalam keperawatan:

Lansia dari komunitas tradisional mungkin enggan menggunakan alat bantu kesehatan berbasis teknologi seperti telemedicine atau perangkat digital.

2. Agama dan filosofi

Sistem kepercayaan agama dan filosofi hidup memainkan peran penting dalam membentuk nilai, keyakinan, dan praktik kesehatan.

Contoh dalam keperawatan:

Lansia yang taat beragama mungkin memiliki kebiasaan tertentu, seperti puasa atau doa, yang memengaruhi perawatan mereka.

3. Faktor sosial dan struktur keluarga

Hubungan sosial dan struktur keluarga memengaruhi dukungan emosional dan fisik yang diterima individu, termasuk lansia.

Contoh dalam keperawatan:

Dalam budaya kolektif, keluarga besar sering menjadi pengambil keputusan utama dalam perawatan lansia, sementara dalam budaya individualis, lansia mungkin lebih mandiri.

4. Nilai budaya, gaya hidup dan tradisi

Nilai budaya, tradisi, dan gaya hidup memengaruhi pilihan dan kebiasaan kesehatan.

Contoh dalam keperawatan:

Lansia dari budaya tertentu mungkin lebih memilih pengobatan herbal tradisional daripada obat modern.

5. Kebijakan dan regulasi

Sistem kebijakan kesehatan dan regulasi pemerintah memengaruhi aksesibilitas layanan kesehatan. Budaya tertentu mungkin memiliki persepsi berbeda tentang layanan yang diberikan oleh sistem formal.

Contoh dalam keperawatan:

Lansia dari budaya migran mungkin menghadapi hambatan bahasa atau birokrasi yang memengaruhi akses mereka ke layanan kesehatan.

6. Ekonomi

Status ekonomi memengaruhi kemampuan individu untuk mengakses dan membayar layanan kesehatan.

Contoh dalam keperawatan:

Lansia dengan sumber daya ekonomi terbatas mungkin memilih pengobatan alternatif atau perawatan rumah dibandingkan perawatan rumah sakit.

7. Pendidikan

Tingkat pendidikan memengaruhi pemahaman individu terhadap informasi kesehatan dan pilihan perawatan.

Contoh dalam keperawatan:

Lansia dengan pendidikan rendah mungkin tidak memahami pentingnya perawatan preventif seperti vaksinasi atau pemeriksaan kesehatan rutin.

Intervensi Keperawatan Transkultural dalam keperawatan gerontik diterapkan melalui strategi yang menghormati dan mengakomodasi budaya, nilai, dan keyakinan lansia. Madeleine Leininger dalam *Culture Care Theory* mengidentifikasi tiga pendekatan utama untuk intervensi keperawatan transkultural (Fabry et al., 2024):

1. Preservasi atau Pemeliharaan Budaya

Perawat mendukung praktik budaya yang bermanfaat bagi kesehatan lansia.

Penerapan:

- Membantu lansia menjalankan kebiasaan budaya yang positif, seperti mengikuti ritual keagamaan atau tradisi keluarga.
- Contoh: Memastikan lansia dapat berdoa atau bermeditasi sesuai dengan tradisinya, yang dapat memberikan kenyamanan emosional dan spiritual.

2. Akomodasi atau Adaptasi Budaya

Perawat menyesuaikan rencana perawatan agar sejalan dengan keyakinan budaya lansia.

Penerapan:

- Menyesuaikan jadwal pemberian obat dengan waktu ibadah lansia atau tradisi tertentu.
- Contoh: Jika lansia menjalankan puasa, perawat dapat mengatur pemberian obat di luar jam puasa untuk menghormati keyakinan mereka.

3. Restrukturisasi atau Repatterning Budaya

Perawat membantu lansia memodifikasi kebiasaan budaya yang kurang sehat tanpa menghilangkan esensi budaya mereka.

Penerapan:

- Memberikan edukasi tentang cara yang lebih sehat untuk menjalankan kebiasaan budaya.
- Contoh: Jika lansia dari budaya tertentu terbiasa mengonsumsi makanan tinggi garam, perawat dapat menyarankan penggunaan rempah-rempah tradisional sebagai alternatif untuk mengurangi risiko hipertensi.

H. Model Keperawatan Gerontik (Dorothy E. Johnson)

Model konseptual yang dikembangkan oleh Dorothy E. Johnson dikenal sebagai Johnson Behavioral System Model (JBSM). Teori ini menempatkan perilaku manusia sebagai fokus utama keperawatan, dengan pandangan bahwa manusia adalah sistem perilaku yang kompleks dan terorganisasi. Johnson memandang individu sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan dan memiliki tujuh subsistem perilaku yang harus dijaga keseimbangannya untuk mencapai kesehatan optimal.

Konsep utama dalam teori JBSM (Askar & Ovayolu, 2022):

1. Manusia sebagai Sistem Perilaku

Johnson memandang manusia sebagai sistem yang terdiri dari perilaku-perilaku yang saling berhubungan, yang dirancang untuk menjaga stabilitas dan integritas individu. Perilaku ini adalah hasil dari upaya adaptasi terhadap perubahan lingkungan.

2. Tujuh Subsistem Perilaku

Johnson mengidentifikasi tujuh subsistem perilaku yang menjadi dasar fungsi manusia:

- Afiliatif subsystem: Kebutuhan untuk membangun hubungan sosial dan keterhubungan dengan orang lain.
- Dependensi subsystem: Kebutuhan untuk menerima dukungan emosional dan bantuan dari orang lain.
- Achievement subsystem: Dorongan untuk mencapai tujuan, kompetensi, dan produktivitas.
- Agresif/Protetif subsystem: Mekanisme pertahanan untuk melindungi diri dari ancaman.
- Ingestive subsystem: Kebutuhan untuk makan dan minum, sesuai dengan kebutuhan fisiologis.
- Eliminative subsystem: Proses pembuangan limbah tubuh untuk menjaga homeostasis.
- Sexual subsystem: Perilaku terkait fungsi seksual dan reproduksi.

3. Keseimbangan dan Kesehatan

Kesehatan dalam model ini didefinisikan sebagai keadaan di mana subsistem perilaku berada dalam keseimbangan dan berfungsi secara optimal. Ketidakseimbangan dalam salah satu subsistem dapat menyebabkan gangguan perilaku yang memengaruhi kesehatan individu.

4. Peran Perawat

Dalam teori Johnson, peran perawat adalah menjaga dan mengembalikan keseimbangan sistem perilaku dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mengganggu subsistem perilaku dan memberikan intervensi yang sesuai. Perawat juga berfungsi sebagai agen eksternal yang mendukung adaptasi individu terhadap lingkungan.

Aplikasi Teori Sistem Perilaku Johnson dalam keperawatan gerontik bertujuan untuk membantu perawat memahami, menganalisis, dan mengintervensi perilaku lansia untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan. Pendekatan ini berfokus pada pengelolaan subsistem perilaku untuk mendukung adaptasi lansia terhadap perubahan yang terjadi selama proses penuaan. Berikut adalah beberapa aplikasi teori Johnson dalam keperawatan gerontik (Miller, 2020; Touhy & Jett, 2020):

1. Afiliatif Subsystem (hubungan sosial dan dukungan)

Problem: Lansia membutuhkan hubungan sosial yang mendukung untuk mengurangi isolasi dan kesepian, terutama setelah kehilangan pasangan atau teman sebaya

Aplikasi: Perawat memfasilitasi hubungan sosial lansia, seperti melalui kelompok dukungan, kunjungan keluarga, atau program komunitas untuk mencegah isolasi sosial. Isolasi sering kali menjadi masalah pada lansia, terutama setelah kehilangan pasangan atau teman sebaya.

Contoh: Membantu lansia berpartisipasi dalam kegiatan kelompok di panti jompo atau komunitas lansia.

2. Dependency Subsystem (ketergantungan dan dukungan)

Problem: Lansia sering mengalami peningkatan ketergantungan karena keterbatasan fisik.

Aplikasi: Perawat memberikan dukungan yang memungkinkan lansia tetap merasa dihargai, sambil memastikan bahwa kebutuhan fisik mereka terpenuhi. Intervensi ini termasuk pemberian bantuan dengan aktivitas sehari-hari tanpa mengurangi otonomi mereka.

Contoh: Mendorong lansia untuk melakukan tugas sederhana secara mandiri, seperti memilih pakaian atau menyiapkan makanan kecil.

3. Achievement Subsystem (dorongan untuk berkontribusi)

Problem: Lansia memiliki keinginan untuk merasa kompeten dan berharga.

Aplikasi: Perawat mendukung lansia dalam mencapai tujuan pribadi, baik melalui keterlibatan dalam hobi maupun pencapaian kecil dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini meningkatkan rasa percaya diri dan makna hidup mereka.

Contoh: Mendorong lansia untuk mengikuti kegiatan seni, kerajinan tangan, atau berkebun.

4. Aggressive/Protective Subsystem (mekanisme perlindungan diri)

Problem: Perubahan fungsi tubuh dan lingkungan baru dapat memicu stres atau ketakutan.

Aplikasi: Perawat membantu lansia menghadapi ketakutan, stres, atau ancaman terhadap keamanan mereka, terutama di lingkungan baru seperti rumah sakit atau panti jompo. Intervensi ini mencakup menciptakan lingkungan yang

aman dan mendukung.

Contoh: Memberikan informasi yang jelas tentang prosedur medis untuk mengurangi kecemasan lansia.

5. Ingestive Subsystem (kebutuhan nutrisi)

Problem: Lansia mengalami masalah gigi dan mulut dan gangguan pencernaan menyebabkan gangguan makan dan minum.

Aplikasi: Mengidentifikasi masalah, memberikan intervensi yang sesuai, serta mendukung lansia agar dapat memenuhi kebutuhan makan dan minum secara optimal.

Contoh: Perawat memberikan edukasi tentang makanan tinggi kalori dan protein, menciptakan suasana makan yang nyaman, dan melibatkan keluarga untuk mendukung lansia saat makan.

6. Eliminative Subsystems (kebutuhan eliminasi)

Problem: Lansia sering menghadapi perubahan proses eliminasi tubuh yaitu buang air kecil (BAK) dan buang air besar (BAB).

Aplikasi: Perawat menilai pola eliminasi lansia, termasuk masalah seperti inkontinensia urin atau konstipasi yang umum pada lansia. Intervensi berfokus pada pengaturan pola makan dan eliminasi yang sehat.

Contoh: Menyusun rencana diet yang sesuai dengan kondisi kesehatan lansia, seperti diet tinggi serat untuk mencegah konstipasi, melakukan kegel exercise untuk melatih otot panggul.

7. Sexual Subsystem (identitas seksual dan reproduksi)

Problem: Lansia mengalami penurunan fungsi reproduksi, kebutuhan emosional dan hubungan intim tetap penting bagi lansia.

Aplikasi: Perawat mendukung lansia dalam mempertahankan identitas seksual mereka dan memahami kebutuhan emosional mereka terkait hubungan intim. Intervensi dilakukan dengan cara yang sensitif terhadap norma budaya dan nilai individu.

Contoh: Memberikan edukasi tentang kesehatan seksual pada lansia atau mendukung pasangan lansia dalam membangun kedekatan emosional.

I. Model Keperawatan Gerontik (Dorothea Orem)

Model keperawatan yang dikembangkan oleh Dorothea Orem dikenal sebagai *Self-Care Deficit Nursing Theory* berfokus pada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan perawatan dirinya sendiri. Teori ini berlandaskan asumsi bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk menjaga dirinya agar sehat dan sejahtera. Ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan intervensi keperawatan untuk mendukung atau mengembalikan kemandiriannya (Maruca, 2023).

Teori ini sangat relevan diterapkan kepada lansia, karena membantu perawat memahami bagaimana memberikan dukungan kepada lansia berdasarkan tingkat kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan perawatan diri. Lansia sering

mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial akibat proses penuaan yang dapat menyebabkan keterbatasan dalam perawatan diri. Dalam konteks ini, teori Orem sangat relevan karena mendorong perawat untuk memberikan dukungan yang bersifat individual, sesuai dengan kebutuhan setiap lansia (Anaka, 2022).

Model ini terdiri dari tiga konsep utama:

1. Self-Care

- Aktivitas yang dilakukan individu secara mandiri untuk menjaga kesehatan, seperti makan, berpakaian dan mengelola pengobatan. Pada lansia, kemampuan ini sering kali menurun akibat penuaan atau penyakit kronis (Eliopoulos, 2020).

2. Self-Care Deficit

- Ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri, perawat harus mengambil peran dalam mendukung atau menggantikan perawatan tersebut
- Contoh: Lansia dengan demensia mungkin memerlukan bantuan untuk mengingat jadwal minum obat.

3. Nursing Systems

- Wholly Compensatory: Perawat mengambil alih seluruh perawatan karena pasien tidak mampu sama sekali.
- Partially Compensatory: Perawat memberikan bantuan sebagian, seperti memandu lansia berpakaian.
- Supportive-Educative: Perawat hanya memberikan edukasi dan bimbingan, karena pasien masih mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Teori Self-Care Orem dalam keperawatan gerontik memberikan kerangka kerja untuk membantu lansia memenuhi kebutuhan perawatan diri mereka. Dengan mempromosikan kemandirian, melibatkan keluarga, dan menyesuaikan intervensi dengan kemampuan individu, teori ini meningkatkan kualitas hidup lansia dan mengurangi ketergantungan mereka pada orang lain. Aplikasi dalam keperawatan gerontik (Miller, 2020; Touhy, 2022; Touhy & Jett, 2020):

1. Pengkajian Kebutuhan Self-Care

- Perawat mengidentifikasi kebutuhan perawatan diri lansia, seperti kemampuan makan, mandi, berpakaian, atau mobilitas.
- Contoh: Lansia dengan artritis berat mungkin memerlukan alat bantu untuk makan, berpakaian dan berjalan.

2. Identifikasi Self-Care Deficit

- Perawat menentukan sejauh mana lansia membutuhkan bantuan.
- Contoh: Lansia pasca-stroke mungkin memerlukan bantuan penuh untuk aktivitas sehari-hari.

3. Penerapan Nursing Systems

- Wholly Compensatory:

Lansia dengan gangguan mobilitas total membutuhkan perawat untuk memberikan bantuan penuh dalam makan, mandi, atau berpakaian.

- Partially Compensatory:

Lansia yang kesulitan berjalan mungkin hanya memerlukan bantuan perawat untuk pergi ke kamar mandi, tetapi mampu makan sendiri.

- Supportive-Educative:

Lansia dengan diabetes diajarkan cara mengelola gula darah secara mandiri.

4. Pemberdayaan Lansia

- Teori ini mendorong perawat untuk membantu lansia memaksimalkan potensi kemandirian mereka.

- Contoh: Lansia yang kesulitan berpakaian diberi alat bantu seperti tongkat pakaian atau sepatu dengan perekat agar tetap dapat melakukannya sendiri.

5. Edukasi Keluarga

- Keluarga sering menjadi pendukung utama lansia. Perawat memberikan edukasi tentang bagaimana mereka dapat mendukung kebutuhan lansia tanpa mengurangi kemandiriannya.

- Contoh: Memberikan pelatihan kepada keluarga tentang cara menggunakan alat bantu mobilitas.

6. Pencegahan dan Promosi Kesehatan

- Perawat menggunakan teori Orem untuk mendorong lansia menjaga kesehatan melalui tindakan preventif dan gaya hidup sehat.

- Contoh: Lansia didorong untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik ringan sesuai kemampuan mereka untuk mempertahankan fungsi tubuh.

7. Evaluasi dan Penyesuaian Rencana Perawatan

- Perawat mengevaluasi perubahan kondisi lansia dan menyesuaikan rencana perawatan mereka sesuai dengan perkembangan fisik atau psikologis.

- Contoh: Jika kemampuan mobilitas lansia meningkat, perawat mengurangi bantuan secara bertahap untuk mendukung kemandirian.

J. Latihan

Soal Multiple Choice:

1. Model keperawatan gerontik yang dikembangkan oleh Callista Roy yaitu tentang?
 - a. Model sistem
 - b. Model budaya
 - c. Model perilaku
 - d. Model adaptasi

- e. Model Human being
- 2. Model keperawatan gerontik yang dikembangkan oleh Martha Rogers yaitu tentang?
 - a. Model sistem
 - b. Model budaya
 - c. Model perilaku
 - d. Model adaptasi
 - e. Model Human being
- 3. Model keperawatan gerontik yang dikembangkan oleh Betty Neuman yaitu tentang?
 - a. Model sistem
 - b. Model budaya
 - c. Model perilaku
 - d. Model adaptasi
 - e. Model Human being
- 4. Model keperawatan gerontik yang dikembangkan oleh Virginia Henderson yaitu tentang?
 - a. Model sistem
 - b. Model budaya
 - c. Model perilaku
 - d. Model adaptasi
 - e. Model kebutuhan dasar
- 5. Model keperawatan gerontik yang dikembangkan oleh Madeleine Leininger yaitu tentang?
 - a. Model sistem
 - b. Model budaya
 - c. Model perilaku
 - d. Model adaptasi
 - e. Model kebutuhan dasar

Soal Essay:

1. Jelaskan konsep keperawatan model adaptasi yang dikembangkan oleh Callista Roy? Serta jelaskan bagaimana peran perawat dalam lima mode adaptasi meliputi mode biologis, psikologis, sosial, kultural dan spiritual?
2. Jelaskan garis pertahanan diri menurut teori Betty Neuman? Serta jelaskan bagaimana tingkatan pencegahan stressor memperkuat garis pertahanan diri?
3. Jelaskan konsep keperawatan yang dikembangkan oleh Virginia Henderson tentang kebutuhan dasar manusia? Serta berikan contoh intervensi keperawatan dalam membantu lansia memenuhi 14 kebutuhan dasarnya?

4. Jelaskan konsep teori keperawatan Culture Care Diversity and Universality Theory yang dikembangkan Madeleine Leininger? Serta berikan contoh penerapan intervensi keperawatan yang meliputi perseverasi, akomodasi dan restrukturisasi?
5. Jelaskan konsep model self care deficit nursing theory yang dikembangkan oleh Dorothea Orem? Serta berikan contoh peran perawat dalam penerapan nursing system meliputi Wholly compensatory, partial compensatory dan supportive educative?

Kunci Jawaban Soal Multiple Choice

1. D
2. E
3. A
4. E
5. B

K. Rangkuman Materi

Model keperawatan memiliki peran penting dalam memberikan panduan komprehensif untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi perawatan yang sesuai dengan kebutuhan unik lansia. Model keperawatan menyediakan dasar teoritis yang membantu perawat memahami proses penuaan, perubahan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pada lansia.

Model keperawatan gerontik Callista Roy dikenal sebagai model adaptasi, menekankan pada bagaimana lansia beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Model keperawatan gerontik Martha Rogers dikenal sebagai model *human being*, menekankan pada manusia adalah sistem energi yang utuh dan terhubung dengan lingkungan. Model keperawatan gerontik Betty Neuman dikenal sebagai model sistem, menekankan pada garis pertahanan diri normal, flexible dan resistance. Model keperawatan gerontik Virginia Henderson menekankan pada manusia memiliki 14 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai kemandirian.

Model keperawatan gerontik Madeleine Leininger dikenal sebagai *Culture Care Diversity and Universality Theory*, menekankan pentingnya pemahaman budaya dalam praktik keperawatan. Model keperawatan gerontik Dorothy E. Johnson dikenal sebagai *Johnson Behavioral System Model (JBSM)*, menekankan pada individu sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan dan memiliki tujuh subsistem perilaku yang harus dijaga keseimbangannya untuk mencapai kesehatan optimal. Model keperawatan gerontik Dorothea Orem dikenal *Self-Care Deficit Nursing Theory*, menekankan pada individu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan perawatan dirinya sendiri.

L. Glosarium

Atrofi : Kondisi di mana terjadi pengecilan atau penyusutan ukuran sel, jaringan, organ, atau bagian tubuh tertentu.

Cemas : Keadaan emosional yang ditandai dengan perasaan tidak nyaman, khawatir, atau takut.

Depresi : Gangguan suasana hati (*mood disorder*) yang ditandai oleh perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari

Diabetes : Penyakit metabolik yang ditandai dengan meningkatkan kadar gula dalam darah.

Disfagia : Gangguan menelan, baik itu makanan, minuman, atau bahkan air liur

Fraktur : Kondisi patahnya tulang, baik sebagian maupun seluruhnya.

Hipertensi : Kondisi seseorang dimana tekanan darah meningkat melebihi batas normal, pada lansia melebihi 140/90 mmHg.

Kegel exercise : Latihan yang dirancang untuk memperkuat otot dasar panggul

Lansia : Seseorang yang telah memiliki umur lebih dari 60 tahun ke atas.

Osteoarthritis : Penyakit degeneratif yang ditandai dengan kerusakan tulang rawan pada persendian.

Osteoporosis : Kondisi medis yang ditandai dengan penurunan kepadatan dan kualitas tulang.

Paliatif : Kondisi dimana pasien memiliki penyakit serius, kronis, atau mengancam jiwa

Presbiakusis : Gangguan pendengaran yang terjadi akibat proses penuaan.

Pursed-lip breathing : Teknik pernapasan yang melibatkan menarik napas melalui hidung dan menghembuskan napas perlahan melalui bibir yang dirapatkan, seperti sedang meniup lilin.

Ritme sirkadian : Siklus biologis yang berlangsung dalam periode sekitar 24 jam, yang mengatur berbagai proses fisiologis dalam tubuh.

Stressor : stimulus, kejadian, atau kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami stres, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis.

Vaksin : Perlindungan terhadap penyakit tertentu dengan merangsang sistem kekebalan tubuh.

Vasodilatasi : Proses pelebaran pembuluh darah yang terjadi ketika otot polos pada dinding pembuluh darah mengalami relaksasi.

Vasokonstriksi : Proses penyempitan pembuluh darah, terutama arteri dan arteriol, yang terjadi sebagai respons terhadap berbagai rangsangan.

M. Daftar Pustaka

- Ahmadi, Z., & Sadeghi, T. (2017). Application of the Betty Neuman systems model in the nursing care of patients/clients with multiple sclerosis. *Multiple Sclerosis Journal*, 3(3), 1–8. <https://doi.org/10.1177/2055217317726798>
- Ahtisham, Y., & Jacoline, S. (2015). Integrating Nursing Theory and Process into Practice. *International Journal of Caring Sciences*, 8(2), 443–450. http://www.internationaljournalofcaringsciences.org/docs/23_ahtisham.pdf
- Alligood, M. R. (2017). *Nursing Theorists and Their Work (9th ed.)*. St. Louis, MO: Elsevier.
- Anaka, M. (2022). Orem's nursing self-care deficit theory: A theoretical analysis focusing on its philosophical and sociological foundation. *Nurs Forum*, 57(3), 480–485.
- Askar, S. E., & Owayolu, O. (2022). Nursing care based on Dorothy Johnson's Behavioral System Model in Coronary Artery Disease: A case report. *Medical Science and Discovery*, 9(2), 138–142. <https://doi.org/10.36472/msd.v9i2.671>
- Bauman, S. ., Wright, S. ., & Settecase-Wu, C. . (2014). A science of unitary human beings perspective of global health nursing. *Nursing Science Quarterly*, 27(4), 324–328.
- Boltz, M., Capezuti, E., Fulmer, T., & Zwicker, D. (2016). *Evidence-Based Geriatric Nursing Protocols for Best Practice (5th ed.)*. Springer Publishing Company.
- Fabry, L., McDermott, S., & Wilford, B. (2024). Culturally Competent Care for Diverse Populations: A Review of Transcultural Nursing Education. *Advanced Emergency Nursing Journal*, 46(3), 274–282.
- Kabusi, M., & Yazdi, K. (2024). Nursing process based on Betty Neuman's systemic model: A case study. *Journal of Nursing Advances in Clinical Sciences*, 1(Issue 2), 111–117. https://www.jnacs.com/article_193536.html
- Maruca, A. (2023). Empowering Health Journey: Dorothea Orem's Self-care Deficit Theory in Patient Empowerment. *Reviews: Journal of Nursing & Health Sciences*, 9(4), 4–6. <https://doi.org/10.4172/JNHS.2023.9.4.88>
- Mc Farland, M. ., & Wehbe-Alamah, H. . (2019). Leininger's Theory of Culture Care Diversity and Universality: An Overview With a Historical Retrospective and a View Toward the Future. *Nursing, Journal of Transcultural*, 30(6), 540–557.
- Miller, C. A. (2020). *Nursing for wellness in older adults*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Munandar, A., Setyorini, D., Cahyono, I., Rahman, I., Wahyuni, F., Albyn, D. ., R, D., & Kornelis. (2020). *Falsafah dan teori keperawatan*. CV. Media Sains Indonesia.
- Neuman, B. (2001). Neuman B. The nurse theorists: 21st-century updates--Betty Neuman. Interview by Jacqueline Fawcett. *Nursing Science Quarterly*, 14(3),

211–214.

Potter, P. ., & Perry, A. . (2021). *Fundamentals of Nursing*. Elsevier.

Report, C., & Kabusi, M. (2024). The application of Martha Rogers ' science of unitary human beings in nursing care : A case report. *Journal of Nursing Advances in Clinical Sciences*, 1(2).

Risnah, & Irwan, M. (2021). *Falsafah dan teori keperawatan*. Media Sains Indonesia.

Roy, C. (2009). *The Roy Adaptation Model (2nd ed.)*. Pearson.

Roy, C. (2011). Extending the Roy Adaptation Model to Meet Changing Global Needs. *Nursing Science Quarterly*, 24(4), 345–351.
<https://doi.org/10.1177/0894318411419210>

Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). *Public Health Nursing: Population-Centered Health Care in the Community (10th ed.)*. Elsevier.

Touhy. (2022). *Ebersole and Hess' gerontological nursing & healthy aging*. Elsevier.

Touhy, T. A., & Jett, K. F. (2020). *Ebersole and Hess' Gerontological Nursing & Healthy Aging (6th ed.)*. Elsevier.

Zhang, J., Guo, L., Mao, J., Qi, X., Chen, L., Huang, H., Sun, Y., & Yang, X. (2021). The effects of nursing of Roy adaptation model on the elderly hypertensive: a randomised control study. *Annals of Palliative Medicine*, 10(12), 12149–12158.
<https://doi.org/10.21037/apm-21-2803>

BAB 3

PENGKAJIAN KESEHATAN PADA LANSIA

Tujuan Intruksional:

1. Mengidentifikasi perbedaan level dalam pengkajian
2. Membandingkan dan membedakan data subyektif dan data objektif.
3. Mendiskusikan pentingnya pengkajian yang menyeluruh
4. Mendeskripsikan metode yang tepat merancang dan melakukan interview.
5. Mengidentifikasi pendekatan yang memfasilitasi keberhasilan pengkajian fisik.
6. Mendiskusikan modifikasi yang digunakan ketika menyiapkan lansia untuk pemeriksaan fisik.
7. Mendeskripsikan teknik yang digunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik.
8. Menjelaskan adaptasi yang digunakan pada saat pengkajian tanda-tanda vital pada lansia.
9. Mendiskusikan tool pengkajian pada lansia yang mengalami perubahan kondisi

Capaian Pembelajaran:

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK:

- CPL-S : Mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam mengembangkan asuhan keperawatan usia lanjut.
- CPL-P: Menggunakan proses keperawatan dalam menyelesaikan masalah klien usia Lanjut.
- CPL-KU: Mendemonstrasikan keterampilan teknis keperawatan yang sesuai dengan dengan standar yang berlaku atau secara kreatif dan inovatif agar pelayanan yang diberikan efisien dan efektif

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK): Bila diberikan pengalaman belajar di kelas, mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan, sikap dan ketrampilan praktik dalam memberika asuhan keperawatan pada lansia.

Sub CPMK: Mahasiswa mampu melakukan pengkajian pada lansia

Pendahuluan

Lansia adalah individu yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, yang sering kali menghadapi berbagai tantangan kesehatan, fisik, psikologis, dan sosial. Seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup di banyak negara, populasi lansia terus berkembang pesat, sehingga pengkajian terhadap kondisi mereka menjadi semakin relevan dan crucial diperlukan.

Latar belakang penulis yang bekerja sebagai perawat dan pengajar gerontik, sehingga dengan pendidikan, pengalaman kerja, serta motivasi atau minat khusus terhadap kesehatan lansia merasa penting sekali adanya referensi yang dapat diandalkan tentang pengkajian pada lansia, yang mana tahap pengkajian menjadi langkah awal dan esensial dalam proses keperawatan. Materi dari tulisan ini di ambil dari buku *Basic Geriatric Nursing* yang di tulis oleh Patricia William pada tahun 2016.

Pengkajian lansia tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga kondisi mental, sosial, dan kualitas hidup mereka. Dengan pendekatan yang holistik, pengkajian ini bertujuan untuk menggali berbagai faktor yang dapat memengaruhi kesejahteraan lansia, seperti adanya penyakit kronis, kondisi fungsional, dukungan sosial, dan faktor lingkungan. Selain itu, pengkajian ini juga penting untuk mengidentifikasi kebutuhan perawatan yang sesuai dan strategi pencegahan penyakit, guna meningkatkan kualitas hidup lansia dan mengurangi beban sistem kesehatan.

Dengan hadirnya tulisan ini diharapkan tenaga kesehatan khususnya perawat, mahasiswa, keluarga lansia, dan pembaca lainnya mampu memahami tanda-tanda atau gejala awal, atau lainnya sehingga dapat memberikan solusi terbaik pada lansia.

Melalui pengkajian lansia yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi terbaik dalam mendukung lansia untuk hidup secara mandiri dan sehat, serta memperhatikan aspek psikososial mereka, yang turut berperan besar dalam kesejahteraan dan kebahagiaan mereka.

Buku ini berisi tentang pengkajian kesehatan pada lansia dan dibahas secara singkat, jelas tentang sub sub topiknya. Penulisan dalam buku ini menggunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami, sehingga pembaca dapat melakukan pembelajaran mandiri. Pendekatan Pembelajaran dalam tulisan pembelajaran aktif, *self directive learning*.

Pedoman Penggunaan pada BAB ini yaitu disarankan pembaca yang ada keinginan untuk memberikan asuhan keperawatan khususnya pada lansia, untuk memperdalam hal pengkajian.

Uraian Materi

Pengkajian kesehatan pada lansia dapat dilakukan dengan beberapa level. Dimulai dari pengkajian sederhana sampai pengkajian yang kompleks. Untuk dapat melakukan pengkajian yang akurat, mahasiswa, perawat dan pemberi layanan kesehatan yang berinteraksi dengan lansia ditekankan pentingnya pengetahuan dan skill untuk melakukan pengkajian lansia yang tepat. Mereka harus mengetahui bagaimana menggunakan perangkat diagnostik dan alat lainnya secara aman. Sehingga perawat harus berpengetahuan luas dan sensitif terhadap keperluan unik lansia.

A. Skrining Kesehatan

Skrining Kesehatan dilakukan untuk mengidentifikasi individu lansia yang membutuhkan evaluasi lanjutan (lihat tabel 1). Skrining untuk tekanan darah tinggi, hilangnya pendengaran, masalah kaki, tantangan dalam ADL adalah hal yang biasanya dilakukan pada "*senior centre*" dan klinik Kesehatan. Skrining kesehatan dilakukan oleh medikal, institusi keperawatan, atau kelompok-kelompok khusus yang memiliki perhatian khusus pada lansia. Banyak skrining yang dapat dilakukan oleh orang awam yang bekerja dibawah naungan profesional. Pengkajian skrining untuk depresi dan resiko bunuh diri meskipun agak jarang digunakan tapi direkomendasikan pada populasi lansia. Beberapa perhatian khusus adalah lebih umum pada etnis populasi tertentu, meskipun terbatas penggunaan skrining dan status sosial ekonomi yang menjadi beberapa faktor. Sebagai contoh terdapat hal kompleks dan faktor-faktor yang saling berhubungan terhadap kejadian kanker dan kematian pada ras tertentu dan yang kurang dalam pelayanannya. Faktor yang paling signifikan seperti inadekuat asuransi kesehatan dan rendahnya status ekonomi.

Perawat semestinya melakukan skrining pada semua populasi pada masalah potensial dan mempromosikan identifikasi/deteksi dini dan *treatment* masalah. Ada beberapa skrining yang di cover oleh asuransi kesehatan.

Skrining kesehatan tidak di desain untuk menyediakan treatment, tapi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi temuan-temuan sehingga individu lansia yang paling banyak memerlukan bantuan dari pemberi layanan. Deteksi dini juga kan membuat lansia tidak mengalami frustrasi dan penggunaan waktu yang tidak efektif. Tergantung pada apa yang akan dievaluasi, skrining kesehatan mungkin dapat dilakukan pada individu secara langsung, email, telepon, online, sedikit dan sedikit penggunaannya (William, 2016)

Tabel 3.1: Preventive Medicine: Screening Recommendation for Older adult.

Screening Test	Recommendation
Tekanan darah tinggi	Setiap pemeriksaan klinik
Pemeriksaan payudara	Tiap tahun setelah usia 40 tahun
Mammogram	Tiap 2 tahun antara usia 50-72 tahun, tidak ada rekomendasi setelah 72 tahun selama seorang wanita dalam kondisi sehat.
Kolesterol	Tiap 5 tahun
Skrining untuk kanker rektal dan polip	Salah satu dari dibawah ini setelah usia 50 tahun: • Tiap tahun pada <i>fecal occult blood testing</i> • Flexible sigmoidoscopy tiap 5 tahun. • Colonoscopy tiap 10 tahun. • Double contrast barrium enema tiap 5 tahun. • CT colonoscopy (Virtual coloscopy) setiap 5 tahun.
Skrining untuk obesitas	Pada interval yang reguler.
Bone mineral Density	Direkomendasikan pada usia diatas 65 tahun atau lebih tua dan pada laki-laki yang memiliki riwayat DM.
Prostate examination/PSA	Konsultasikan pada pemberi layanan utama pada usia 50 tahun . atau usia 45 tahun pada pempuan afrika, keluarga dengan riwayat
Test skrining pendengaran	Setiap 10 tahun
Pengkajian mata lengkap	Every 1to 2 tahun
Ultrasound Abdomen (pemeriksaan aneurime aorta abdomen)	1 kali antara usia 65 dan 75 tahun pada laki-laki yang memiliki riwayat perokok.
Skrining hepatitis C	Direkomendasikan pada individu yang beresiko(riwayat <i>drug use</i>). Satu kali skrining untuk semua orang yang lahir antara 1945-1965).
Test HIV	Direkomendasikan pada individu yang beresiko.
Skrining DM tipe 2	Rekomendasi tiap 3 tahun bagi individu dengan TD selalu diatas 130/80 mmHg, orang dewasa

	dengan overweight, individu yang beresiko seperti kolesterol tinggi, riwayat keluarga, resiko tinggi secara ras, inaktifitas fisik.
--	---

Sumber: William, 2016

B. Pengkajian kesehatan

Pengkajian kesehatan secara mendalam membutuhkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Perawat melakukan pengkajian kesehatan pada lansia di komunitas, klinik, dan institusional setting. Pengkajian kesehatan meliputi pengumpulan semua informasi penting berkaitan dengan kesehatan dengan menggunakan berbagai teknik. Data meliputi semua informasi yang didapat dari seorang individu. Informasi ini digunakan untuk menegakkan diagnosa keperawatan dan merencanakan intervensi keperawatan, sehingga kelengkapan data yang akurat perlu dikumpulkan (William, 2016) Data meliputi:

1. Data objektif

Yaitu data yang dikumpulkan dengan menggunakan indra penglihatan, pendengaran, sentuhan dan penciuman. Informasi objektif dapat dikumpulkan dengan observasi secara langsung, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium/ test diagnostik. Karena data objektif adalah konkrit, maka untuk semua pengamat/observers harusnya mengumpulkan hasil/temuan yang hampir sama tentang seseorang atau perilaku seseorang. Perilaku seperti menangis, lemah/kepincangan, cengkraman/genggaman dapat diverifikasi dari seseorang orang lain yang mengobservasi pasien. Kemerahan dan lesi kulit, dan drainase seperti ini dapat dilihat semua orang. Data objektif dapat dibuat lebih *precise* dan spesifik dengan menggunakan meter, monitor atau dengan menggunakan alat ukur lainnya.

2. Data subyektif

Data subyektif adalah data yang dikumpulkan dari pandangan seseorang. Seperti: ketakutan, kecemasan, frustrasi, dan nyeri. Ketika melakukan pengkajian kesehatan pada lansia, perawat perlu memodifikasi cara pendekatan yang biasanya dilakukan untuk membuatnya lebih tepat untuk lansia.

C. Mewancarai Lansia

Wawancara yang dilakukan pada saat pasien masuk di pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan direncanakan dan dilakukan secara formal. Interview yang lainnya mungkin bisa saja dilakukan secara spontan, informal dan berdasarkan kebutuhan saat itu sesuai yang di kenali/dilihat oleh perawat. Sebelum

memulai interview dengan lansia, perlu direncanakan suatu situasi kondisi yang menciptakan kenyamanan dan rasa percaya lansia. Hal ini meliputi persiapan setting secara fisik, menyiapkan "rapport", dan struktur alur interview. Selama dalam fase persiapan, perlu dipertimbangkan kebutuhan-kebutuhan unik klien lansia (William, 2016).

1. Mempersiapkan setting fisik

Pilihlah lingkungan untuk interview/wawancara secara seksama dan hati-hati. Minimalkan distraksi: suara televisi, radio, suara-suara lain yang terlalu keras sehingga lansia mampu memahami kata dan pertanyaan. Perhatikan pencahayaan, karena Cahaya yang terlalu terang atau menyilaukan akan mengganggu penglihatan. Furniture pilih yang nyaman, dan perhatikan privasi lansia. Lakukan interview/wawancara di ruangan yang minimal terganggu. Jika ruangan kurang memadai, maka dapat menggunakan ruangan khusus klien, perhatikan gorden harus tertutup dan pintu tertutup, dan perhatikan kerapian ruangan dan kenyamanan ruangan. Jika klien sering ke toilet, maka sebelum wawancara dapat dikondisikan.

2. Mempersiapkan "Rapport"

Sangat disarankan pada saat memulai wawancara lansia dengan memulai dengan salam dan memperkenalkan diri Anda. Pada saat awal pertemuan, maka sebutkan nama Anda secara formal. Ketepatan dalam menggunakan nama menandakan respek dan sangat membantu dalam penyusunan hasil /rapport. Anda dapat menanyakan panggilan nama yang paling disukai.

Jelaskan tujuan wawancara secara singkat sehingga lansia tahu apa yang akan diekspektasikannya. Penjelasan juga akan membantu menurunkan kecemasan lansia jika tidak akan mengganggu pemahaman lansia. Jelaskan Anda memerlukan berapa lama untuk wawancaranya dan apa yang akan terjadi setelah selesai wawancara. Fokus dan bicara secara langsung pada lansia. Hal ini kadang berbeda di praktiknya, terutama jika lansia ada anggota keluarga yang lebih muda, dan terkadang cenderung mengambil alih menjawab saat wawancara. Hal tersebut kadang menimbulkan frustrasi dan merasa tidak penting pada lansia. Untuk itu, maka biarkan lansia untuk menjawabnya sendiri semaksimal mungkin, dan pada saat ada kendala seperti lansia bingung, tidak responsif, atau tidak memahami bahasanya, maka dapat melibatkan anggota keluarga untuk memperjelas jawaban lansia.

Tabel 3.2: Data riwayat kesehatan

Riwayat meliputi informasi berikut: IDENTITAS DATA • Nama • Tanggal lahir • Tempat tinggal • Etnis • Bahasa • Status marital • Pekerjaan sebelumnya dan sekarang • Pendidikan RIWAYAT LAMPAU (<i>Past History</i>) • Persepsi terhadap kesehatan secara umum • Frekuensi perawatan medis dan gigi, meliputi skrining mammografi, dll. • Alergi • Imunisasi *waktu dan tanggal) • Penyakit serius dimasa anak-anak • Riwayat hospitalisasi (alasan dan tanggal) • Riwayat pembedahan (tipe dan tanggal) • Perawatan kesehatan mental (tipe dan tanggal) • Review kebiasaan kesehatan, seperti diet, intake minuman, olahraga, pola tidur, pola BAB, alkohol, kopi, rokok, dll.	RIWAYAT KESEHATAN SEKARANG (<i>Present Medical History</i>) • Keluhan utama • Apakah masalah berkaitan dengan kecelakaan atau jatuh? • Simptom (lokasi, durasi, • Tanggal dan onset (mendadak atau bertahap) • Apa yang memperparah atau membaik? • Apa yang sudah dilakukan untuk meresponnya? (berkunjung ke dokter, dll) • Obat-obatan yang sekarang digunakan • Kepatuhan terhadap pengobatan? • Terapi saat ini (oksigen, fisioterapi, dll) RIWAYAT PSIKOSOSIAL DAN KELUARGA (<i>family and psychosocial History</i>) • Tinggal bersama dengan anggota keluarga (pasangan, anak, saudara,dll). • Kegiatan bersama dengan teman dan sosial lainnya (klub, tempat ibadah, komunitas tertentu, dll) • Hobby dan interest • Hewan peliharaan • Anggota keluarga yang penting dan telah meninggal.
---	--

3. Mempersiapkan struktur interview

Rencanakan waktu yang cukup saat wawancara. Lansia biasanya memiliki cerita hidup yang panjang dan komplek untuk diceritakan. Perlu diingat bahwa lansia biasanya memiliki kecepatan dalam mengingat dan respon verbal yang melambat seiring dengan bertambahnya usia. Individu akan merasa stress dan

tertekan jika dilakukan wawancara terlalu cepat(William, 2016).

Tidak mencoba terlalu banyak waktu dalam satu kali wawancara. Karena terkadang saat wawancara dapat membuat lansia lelah, khususnya pada lansia dengan masalah kesehatan. Lebih baik cukup 30 menit dalam satu sesi wawancara. Tetap waspada akan tanda-tanda kelelahan, yang mana ini menandakan bahwa wawancara segera diakhiri.

Pada saat wawancara gunakan beberapa teknik komunikasi untuk meyakinkan bahwa lansia memahami informasinya. Hindari menggunakan kata - kata yang sulit untuk dimengerti lansia. Sangat penting sekali untuk bicara secara lambat dan jelas, pesan simpel dan jelas. Anda tetap tenang dan empatetik pada lansia, dan pada saat lansia bicara jangan diinterupsi. Dengarkan pesan verbal dan lihat nonverbalnya. Terkadang lansia bicaranya panjang dan lebar, maka merangkum "*restatement*" dari percakapan sangatlah membantu.

Wawancara janganlah diakhiri secara mendadak. Persiapkan lansia dengan baik pada saat mengakhiri wawancara. Banyak sekali lansia yang mengalami kesepian menginginkan bercerita banyak, maka setting waktu untuk wawancara lanjutan dan tepati janji tersebut, sehingga lansia tidak hilang kepercayaan pada perawat pada saat wawancara selanjutnya.

D. Pengkajian Riwayat Kesehatan Lansia

Sebelum melakukan pengkajian fisik lansia, perawat akan menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan riwayat kesehatan. Riwayat ini dimulai dari mengidentifikasi data awal/inti meliputi riwayat kesehatan sebelumnya dan lalu mereview isu kesehatan sekarang. Beberapa lansia mampu memberikan informasi secara mudah, mungkin lainnya kesulitan memberikan riwayat kesehatannya. Kebanyakan disebabkan karena level kognitif lansia dan kompleksitas masalah riwayat kesehatan yang dialaminya. Pada saat lansia kurang mampu dalam memberikan informasi riwayat kesehatannya, maka perawat dapat mengalihkan informasi dari anggota keluarganya di waktu berikutnya. Sebagai tambahan mungkin Anda ingin mendapatkan informasi tambahan terkait status keluarga seseorang dan status psikologisnya. Riwayat kesehatan klien akan membantu perawat dalam membentuk kesan keseluruhan lansia dan eksplorasi dan pengkajian lanjutan(William, 2016)

E. Pemeriksaan Fisik Pada Lansia

Setelah riwayat kesehatan (history) Anda dapatkan, maka Anda dapat melanjutkan ke pemeriksaan fisik. Selama pemeriksaan ini, informasi objektif akan melengkapi data subjektif dari lansia. Informasi objektif akan membantu

menentukan kemampuan dan limitasi/keterbatasan individu. Pada saat mengkaji lansia, perlu diperhatikan tidak hanya perubahan fisiologi saja tapi juga pada perubahan mood atau perilaku lansia yang mana bisa menandakan suatu perubahan.

Lakukan pemeriksaan fisik diruangan yang nyaman, misalnya kamar lansia atau ruang khusus pemeriksaan fisik. Menjaga privacy klien, dan hanya bagian yang diperiksa saja yang terekspose. Jika pemeriksaan fisik didapatkan pada memberikan perawatan diri lansia seperti saat lansia mandi, maka yakinkan lansia tidak menggigil.

Persiapkan alat-alat pemeriksaan fisik dengan lengkap seperti *flashlight/penlight*, metlin (*measuring tape*), timbangan, spigmomanometer, stetoskop, dan thermometer sebelumnya. Hal ini untuk menunjukkan dan meyakinkan kompetensi Anda dan menjamin pemeriksaan fisik berjalan dengan lancar.

Lakukan pemeriksaan fisik secara lengkap sehingga tidak ada informasi yang terlewatkan. Mulailah dengan Gambaran umum lansia, meliputi tampilan secara umum, *hygiene, grooming* (penampilan), *alertness* (kewaspadaan), respon, mobilitas secara umum, lalu lanjutkan ke pemeriksaan khusus. Metode yang paling umum digunakan adalah metode "*head to toe*" yaitu pemeriksaan tubuh menyeluruh secara sistematis. Pendekatan lain dapat menggunakan "*body system*" atau "*functional approach*". (William, 2016)

Ketika melakukan pemeriksaan fisik, perawat menggunakan bervariasi Teknik meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.

1. Inspeksi

Inspeksi merupakan metode yang paling umum digunakan pada pemeriksaan fisik yang mana indra penglihatan, penciuman, dan pendengaran digunakan untuk mengumpulkan data. Inspeksi menuntut perawat untuk secara total aktif, alert, dan waspada segala apa yang dilihatnya, dengar dan bau. Hal ini diawali pada saat pertama kali berinteraksi dengan lansia. Meskipun pada interaksi singkat, skill perawat seharusnya melihat individu, segala sesuatu yang mengindikasikan perubahan situasi dan kondisi lansia.

Inspeksi dapat general dan spesifik. General inspeksi digunakan untuk mendeteksi kebutuhan untuk perlunya inspeksi lebih lanjut. Sebagai contoh, perawat melihat lansia makannya sedikit, maka inspeksi lebih lanjut pada inspeksi rongga mulut diindikasikan. Jika tercium bau yang kurang sedap, maka perlu pemeriksaan inspeksi terhadap kulit.

Inspeksi digunakan pada saat mengkaji secara keseluruhan level fungsi, seperti pada saat inspeksi area khusus. Pada saat inspeksi, perlu diperhatikan secara detail, Gunakan penerangan yang adekuat, lebih baik dengan cahaya

alami, ketika memeriksa kulit. Bandingkan ukuran dan mobilitas bagian tubuh dan bandingkan dengan sisi lainnya.

2. Palpasi

Palpasi menggunakan indra peraba jari dan tangan untuk mengumpulkan data. Palpasi digunakan untuk mengevaluasi beberapa pemeriksaan fisik seperti nadi, suhu, tekstur kulit, tekstur rambut, adanya tumor dan konsistensinya, distensi kandung kemih, adanya nyeri dan *tenderness*.

Pada saat palpasi gunakan ujung jari yang lebih sensitif. Tangan yang hangat dan tidak berkuku panjang akan menjaga injuri pada kulit lansia yang rapuh. Palpasi ringan dilakukan sebelum melakukan palpasi mendalam. Pada saat melakukan palpasi nadi lansia, palpasi mendalam mungkin akan menyebabkan menutup aliran pembuluh darah. Tekanan mendalam dapat menyebabkan nyeri, sehingga palpasi pada area yang mungkin akan menyebabkan nyeri dilakukan paling terakhir.

3. Perkusi

Perkusi adalah teknik untuk mengkaji ukuran, posisi, dan densitas dari struktur dibawah kulit, yaitu dengan melakukan ketukan dan mendengarkan resonansi suara. Tergantung pada jumlah vibrasi suara terdengar, adanya massa, cairan, atau udara. Teknik ini lebih sedikit digunakan oleh perawat dan memerlukan skill dan latihan khusus.

4. Auskultasi

Auskultasi menggunakan indra pendengaran untuk mendengarkan suara yang dihasilkan dari jantung paru dan suara usus yang menggunakan stetoskop untuk mendengarnya atau menggunakan doppler untuk memperjelas suaranya. Suara diidentifikasi berdasarkan: *quality (crackling, whistling, snapping), pitch (low/ high tones), intensity (loudness/ softness of tone), duration (length of time a sound), frequency (how often a sound heard)*

F. Mengukur Tanda-Tanda Vital Pada Lansia

Pengukuran tanda-tanda vital melibatkan semua teknik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketika mengukur vital sign, perawat seharusnya sudah melakukan inspeksi secara general untuk menentukan apakah observasi subjektif dan objektif akan mempengaruhi prosedur dan hasil pengukuran. Karena, aktifitas, medikasi, makan, stress, proses penyakit, dan lingkungan akan mempengaruhi vital sign. Hal tersebut harus dipertimbangkan. Hasil pengukuran vital sign didapatkan selama kontak awal dengan lansia dan hasil ini sebagai perbandingan adanya perubahan vital sign berikutnya (William, 2016).

1. Suhu

Inspeksi general membantu memilih rute yang tepat dalam pengukuran suhu, juga jenis thermometer yang digunakan. Apakah menggunakan thermometer kaca/merkuri, digital/elektronik/sensor, apakah menggunakan rute oral, rectal, aksila dan sebagainya. Perhatikan kontraindikasi dari masing-masing teknik pengukuran suhu. Masing-masing Teknik pengukuran dan rute pengukuran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Secara umum, pada lansia yang sehat, aktif, lansia mampu mempertahankan suhu inti tubuh dalam batas normal yaitu $37^{\circ}\text{C} \pm 0,6^{\circ}\text{C}$. Studi menunjukkan khususnya lansia diatas 72 tahun memiliki rata-rata suhu inti 36°C . Penurunan ini dapat disebabkan karena inaktifitas, penurunan lemak, diet yang tidak adekuat, atau factor lingkungan.

2. Nadi

Sebelum pengukuran, posisikan klien senyaman mungkin dan pada saat pengukuran harus dalam posisi yang sama. Nadi dapat diukur dari beberapa tempat seperti temporal, karotis, brachialis, radialis, femoralis, popliteal, tibia posterior, arteri dorsalis pedis, atau apek jantung. Jika mungkin, lakukan pengukuran pada dua sisi dan bandingkan. Pemeriksaan radialis adalah sisi yang paling umum dilakukan, dan lakukan secara lembut agar tidak menghambat aliran darah. Hitung jumlah nadi, ritme dan volumenya/ Normal nadi pada lansia dalam kondisi istirahat antara 50-90 kali/menit.

3. Respirasi

Setelah melakukan pengkajian terhadap semua faktor yang mempengaruhi respirasi, posisikan senyaman mungkin lansia sehingga dapat bernafas secara nyaman. Kaji jumlah respirasi, kedalaman, dan kemudahan bernafas, Satu pernafasan adalah kombinasi dari inspirasi dan ekspirasi. RR yang normal pada lansia adalah 12-20 kali per menit. Penurunan RR pada saat istirahat adalah signifikan pada lansia, hal ini mengindikasikan adanya inspeksi sebelum suhu yang meningkat terjadi. Peningkatan RR biasanya terjadi karena lansia cemas, nyeri, peningkatan suhu, dan peningkatan aktifitas fisik. Kedalaman pernafasan lansia cenderung menurun dengan bertambahnya usia. Ekspansi dada menurun, dikarenakan alterasi bentuk dari rongga dada, kelemahan otot, *sedentary life style*, atau proses penyakit. Jika terjadi irreguler pernafasan maka diperlukan pemeriksaan lanjutan.

4. Tekanan darah

Tekanan darah adalah hasil pengukuran yang sangat penting dalam pemeriksaan fisik, hal ini sangat esensial tekanan darah didapatkan dari pengukuran yang tepat. Pengukuran yang tepat adalah posisi pasien pada saat lengan atas selevel dengan posisi jantung. Pemilihan alat ukur juga harus

diperhatikan karena ini akan mempengaruhi hasil pengukuran. Pemilihan cuff size harus disesuaikan ukuran lengan atas klien. Ukuran cuff yang tepat adalah 20% lebih lebar daripada diameter lengan atas *at midpoint*. Teknik pengukuran tekanan darah harus mengikuti standar dari American Heart Association. Hal ini meliputi pengambilan tekanan darah dengan palpasi dahulu lalu dengan menggunakan auskultasi. Jangan memompa terlalu kuat cuff nya, karena hal ini dapat menyebabkan memar. Tekanan darah pada lansia sangat bervariasi. Beberapa lansia memiliki tekanan darah rendah-normal, dan ada lansia dengan tekanan darah yang cenderung tinggi. Hipertensi menjadi hal yang umum terjadi pada lansia karena masalah renal dan kardiovaskuler. Peningkatan tekanan darah dapat berkaitan dengan emosional, nyeri yang berlebihan, makan, merokok. Peningkatan tekanan darah tersebut akan menurun jika faktor penyebabnya tidak ada. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, minimalkan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan yakinkan lansia telah istirahat sekitar 3-5 menit.

G. Pengkajian Sensori pada lansia

Pengkajian sederhana penglihatan dan pendengaran berdasarkan data empiris (cara individu merespon visual dan *auditory clues*). Amati apakah lansia mampu membaca dan melakukan hal yang menuntut penglihatan central yang bagus atau apakah lansia dapat melihat televisi atau melihat aktifitas lainnya dengan baik. Jika lansia menggunakan kacamata maka kaji bagaimana kemampuan melihat dengan dan tanpa kacamata.

Berbicara dengan lansia juga dapat untuk mengetahui ada atau tidaknya kemampuan pendengarannya. Indikator adanya masalah pendengaran dapat dilihat dari kesulitan lansia dalam atensi, berulang kali mengulang informasi, kesalahan dalam memahami perintah. Jika memungkinkan dapat menggunakan pengkajian "*hearing-aid*" jika lansia menggunakan alat tersebut dengan tepat. Pengkajian penglihatan dan audiometric secara khusus dapat dilakukan lebih lanjut ke spesialis (William, 2016)

H. Pengkajian Psikososial Pada lansia

Pengkajian psikososial dilakukan untuk mengetahui apakah lansia alert dan peduli pada sekitarnya atau mengalami gangguan kebingungan, delirium, atau demensia. Status psikologis sangat bagus dikaji dengan pengamatan secara langsung dan lebih baik menggunakan tool yang terstandart.

Tabel 3.3: Example of Psychological Assessment Tool on the Internet

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Mini-Mental Status Examination (MMSE)• Cornell Scale for Depression in Dementia |
|--|

- Short Test for Dementia
- Functional Activities Questionnaire
- Clinical Dementia Rating Scale
- Informant Questionnaire on Cognitive Decline in The Elderly
- Confusion Assessment Method

I. Pengkajian Perubahan Kondisi Pada lansia

Status kesehatan berubah pada lansia seringkali sangat "subtle/distinction" dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Deteksi dini dan treatment yang tepat dapat mengurangi bahaya pada lansia. Beberapa instrument telah dikembangkan untuk membantu perawat untuk melakukan pengkajian secara sistematis dan komprehensif (William, 2016)

1. Fulmer Spices

SPICES adalah akronim dari 6 tanda umum pada lansia yang dapat mengidentifikasi potensi masalah kesehatan lansia. Tool ini dapat digunakan secara rutin dalam pengkajian untuk mengidentifikasi atau mencegah potensi masalah atau untuk memonitor status kesehatan (Fulmer, 2012). Identifikasi satu atau lebih masalah ini mengindikasikan peningkatan risiko terhadap penurunan status fungsional dan bahkan kematian. Pengkajian lanjutan diperlukan pada saat masalah ditemukan. Pengkajian ini tidaklah total masalah yang signifikan, sebagai contoh masalah nyeri, eliminasi yang tidak termasuk dalam tool ini, tapi pengkajian benar benar ditujukan pada masalah-masalah umum dan relevan. Informasi tambahan dan tool ini didesain untuk membantu perawat dalam melakukan pengkajian yang efektif dan tersedia secara online (Fulmer T, 2008)

Tabel 3.4: SPICES

S- Sleep disorder
P-Problem with eating or feeding
I-Incontinence
C-Confusion
E-Evidence of Falls
S-Skin breakdown

2. Fancapes

Pada saat perawat merasa bahwa situasi benar-benar emergensi atau masalah yang serius ada dan terus progresif, maka pengkajian yang fokus, tepat sangat diperlukan. Mnemonik berikut dapat digunakan dalam pengkajian:

Tabel 3.5: *FANCAPES*

- F-Fluid
- A-Aeration
- N-Nutrition
- C-Cognition,
communication
- A-Activity/abilities
- P-Pain
- E-Elimination
- S-Skin-Socialization

J. Latihan

1. Pada pengkajian fisik lansia, bagian tubuh mana yang harus diperiksa secara lebih mendetail untuk mendeteksi adanya penurunan kekuatan otot?
 - A. Kaki dan tangan
 - B. Leher dan punggung
 - C. Wajah dan mata
 - D. Perut dan dada
 - E. Leher dan kaki
2. Pengkajian fisik pada lansia seringkali melibatkan penilaian terhadap sistem muskuloskeletal. Apa tanda yang mungkin menunjukkan adanya masalah pada sistem ini pada lansia?
 - A. Penurunan penglihatan
 - B. Nyeri atau kaku pada sendi
 - C. Peningkatan tekanan darah
 - D. Penurunan nafsu makan
 - E. Kesemutan
3. Mengapa penilaian terhadap penglihatan dan pendengaran penting dilakukan dalam pengkajian fisik lansia?
 - A. Untuk mendeteksi adanya gangguan neurologis
 - B. Untuk mengetahui kemampuan lansia dalam beraktivitas sehari-hari
 - C. Untuk menilai fungsi ginjal
 - D. Untuk memeriksa gangguan tidur
 - E. Untuk mengetahui kemampuan merespon
4. Apa yang perlu diperhatikan saat mengukur tekanan darah pada lansia?
 - A. Menggunakan manset yang lebih kecil dari ukuran normal
 - B. Lansia harus berdiri saat pengukuran tekanan darah

- C. Mengukur tekanan darah saat lansia sedang stres
 - D. Memastikan lansia duduk dengan tenang selama pengukuran
 - E. Mengukur tekanan darah dalam posisi jantung selevel dengan lengan atas dan kondisi tenang.
5. Apa tujuan utama dari pemeriksaan mental pada lansia?
- A. Menilai kemampuan fisik lansia
 - B. Menilai fungsi kognitif dan emosional lansia
 - C. Mengukur kekuatan fisik lansia
 - D. Mengidentifikasi pola tidur lansia
 - E. Mengidentifikasi kemampuan ADL lansia

Soal Essay:

1. Apa yang dimaksud dengan "status mental"? Apa saja instrumen atau tool yang dapat digunakan untuk mengukur status mental pada lansia?
2. Seorang lansia mengalami kesulitan dalam mengingat nama orang dan tanggal penting, namun kemampuan fisiknya relatif baik. Apakah gejala ini dapat mengindikasikan demensia? Bagaimana Anda melakukan pengkajian pada lansia tersebut?
3. Tes kognitif mana yang paling sering digunakan untuk mendeteksi penurunan fungsi kognitif pada lansia? Jelaskan cara kerjanya.
4. Seorang lansia menunjukkan perubahan suasana hati yang cepat, seperti kebingungan dan kecemasan yang disertai dengan penurunan kesadaran. Apa kondisi yang mungkin dialami pasien tersebut? Jelaskan langkah-langkah pemeriksaan lebih lanjut yang diperlukan.
5. Bagaimana cara Anda melakukan wawancara dengan lansia untuk mengidentifikasi kemungkinan gangguan mental? Jelaskan pendekatannya

Kunci Jawaban

1. A
2. B
3. B
4. E
5. B

K. Rangkuman Materi

Meskipun inisial pengkajian pada lansia sangat penting, hal itu barulah titik awal pengkajian. Pengkajian adalah proses berkelanjutan dan selalu berjalan terus. Pemahaman dan penguasaan konsep tentang pengkajian kesehatan pada lansia

adalah hal krusial yang harus dimiliki perawat pada lansia. Pengkajian kesehatan pada lansia meliputi skrining kesehatan, pengkajian kesehatan secara umum, pemeriksaan fisik, pengukuran tanda-tanda vital, pengkajian sensori, pengkajian psikososial, dan pemeriksaan khusus pada perubahan kondisi lansia. Penguasaan metode, teknik wawancara, dan cara pemeriksaan sangat penting untuk mendapatkan hasil pengkajian yang valid. Perawat memiliki waktu yang cukup lama dengan lansia, maka perawat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dapat mengkaji dan mengenali perubahan-perubahan yang signifikan pada lansia. Perawat memiliki tanggungjawab dalam melakukan pengkajian yang berkelanjutan dan menggunakan hasil tersebut untuk melakukan asuhan keperawatan. Pada kondisi yang mengalami perubahan, maka perawat dapat menggunakan pendekatan seperti tool SPICES dan FANCAPES dalam melakukan pengkajian lanjutan agar hasil pengkajian sistematis dan komprehensif sesuai dengan kondisi lansia.

L. Glosarium

Inspeksi: Inspeksi adalah pemeriksaan dengan cara mengamati atau memeriksa bagian tubuh pasien secara visual untuk menemukan tanda-tanda atau kelainan yang mungkin terjadi. Contohnya, dokter dapat memeriksa kulit, bentuk tubuh, atau gerakan pasien dengan melihatnya secara langsung.

Perkusi: Perkusi adalah teknik pemeriksaan dengan cara mengetuk atau memukul ringan permukaan tubuh untuk mendengar suara yang dihasilkan. Teknik ini digunakan untuk menilai kondisi organ di bawah permukaan tubuh, seperti paru-paru atau hati, dengan mendengarkan perbedaan suara yang muncul (misalnya, suara tumpul atau resonan).

Palpasi: Palpasi adalah pemeriksaan dengan cara meraba atau menyentuh tubuh pasien untuk merasakan kondisi jaringan atau organ yang ada di bawah kulit. Misalnya, palpasi dapat digunakan untuk meraba pembengkakan, ketegangan otot, atau mengukur ukuran organ seperti hati dan limpa.

Auskultasi: Auskultasi adalah teknik pemeriksaan dengan cara mendengarkan suara tubuh, terutama suara yang dihasilkan oleh jantung, paru-paru, dan saluran pernapasan. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan detak jantung, bunyi pernapasan, atau suara lainnya yang mungkin menunjukkan kelainan.

Status Mental: Status mental adalah kondisi atau keadaan kognitif dan emosional seseorang pada saat tertentu. Ini mencakup aspek seperti tingkat kesadaran, orientasi terhadap waktu, tempat, dan orang, serta kemampuan untuk berpikir, berbicara, dan memproses informasi. Pemeriksaan status mental sering dilakukan oleh tenaga medis untuk menilai kesehatan mental seseorang.

Demensia: Demensia adalah kondisi penurunan fungsi otak yang progresif dan kronis, yang mempengaruhi memori, kemampuan berpikir, pengambilan keputusan, serta perilaku seseorang. Penyakit Alzheimer adalah jenis demensia yang paling umum, tetapi ada berbagai jenis demensia lain seperti demensia vaskular, demensia frontotemporal, dan lain-lain. Gejalanya bisa meliputi kehilangan ingatan jangka panjang, kesulitan dalam berbicara, dan perubahan kepribadian.

Delirium: Delirium adalah gangguan mental sementara yang menyebabkan kebingungan dan perubahan dalam kesadaran atau tingkat perhatian. Delirium bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi, dehidrasi, efek samping obat, atau masalah medis lainnya. Delirium biasanya terjadi secara tiba-tiba dan bisa memburuk atau membaik dalam waktu singkat, tergantung pada penyebab yang mendasarinya.

M. Daftar Pustaka

Fulmer T. (2008). Screening For Mistreatments of Older adult. *Am J Nurs*, 108(12), 52–59.

William, P. (2016). *Basic Geriatric Nursing* (6th ed.). Elsevier.

BAB 4

PROSES KEPERAWATAN PADA INDIVIDU DAN KELOMPOK KHUSUS LANSIA

Capaian Pembelajaran:

Setelah menyelesaikan pembelajaran dalam buku ini, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan yang profesional, holistik, dan berbasis bukti pada individu dan kelompok khusus lansia, dengan mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

CPMK

Mahasiswa mampu menerapkan proses keperawatan secara holistik pada lansia dengan memperhatikan perubahan fisiologis, psikososial, dan fungsional untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

Sub CPMK:

1. Menjelaskan konsep dasar dan teori penuaan dalam keperawatan lansia.
2. Mengidentifikasi perubahan fisiologis dan psikososial yang terjadi pada lansia.
3. Melakukan pengkajian keperawatan secara komprehensif pada lansia.
4. Menyusun perencanaan asuhan keperawatan berbasis bukti untuk lansia.
5. Melaksanakan implementasi asuhan keperawatan pada lansia secara efektif.
6. Melakukan evaluasi asuhan keperawatan lansia secara sistematis dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Lanjut usia (lansia) adalah fase kehidupan yang ditandai oleh proses penuaan biologis, psikologis, sosial, dan fungsional. Dalam menghadapi perubahan-perubahan yang kompleks ini, lansia memerlukan pendekatan asuhan keperawatan yang holistik dan berbasis bukti. Tenaga keperawatan memiliki peran penting dalam memberikan perawatan yang efektif dan humanistik, baik pada individu maupun kelompok lansia. Untuk itu, pemahaman yang komprehensif tentang konsep dasar keperawatan lansia, perubahan fisiologis dan psikososial, teknik pengkajian, serta intervensi yang sesuai sangat dibutuhkan. Buku ajar ini hadir sebagai panduan lengkap bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan bagi lansia secara optimal, guna meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian lansia dalam kehidupan sehari-hari.

A. Konsep Dasar Keperawatan Lansia

Lanjut usia (lansia) merupakan tahap akhir dari siklus kehidupan yang secara umum ditandai oleh proses penuaan secara biologis, psikologis, dan sosial. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2021) mendefinisikan lansia sebagai individu yang berusia 60 tahun atau lebih. Kelompok ini sering kali dibagi menjadi beberapa tahap berdasarkan usia, yaitu lansia muda (60-74 tahun), lansia tengah (75-84 tahun), dan lansia sangat tua (85 tahun ke atas). Definisi ini penting karena setiap kelompok usia lansia memiliki kebutuhan khusus yang berbeda, yang mempengaruhi bagaimana pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan diberikan.

Proses penuaan sendiri merupakan hal alami yang tidak bisa dihindari, dan setiap individu akan mengalami proses tersebut secara berbeda-beda tergantung pada faktor genetik, gaya hidup, lingkungan, dan kondisi kesehatan. Dalam perspektif keperawatan, memahami definisi lansia dengan tepat sangat penting untuk menentukan pendekatan asuhan yang spesifik, individual, dan berbasis bukti. Asuhan keperawatan pada lansia memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai perubahan yang terjadi akibat proses penuaan serta dampaknya terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Dalam upaya memahami mengapa penuaan terjadi, berbagai teori dikembangkan oleh para ahli yang terbagi dalam dua kategori besar, yaitu teori biologis dan teori psikososial. Teori-teori biologis mencoba menjelaskan mekanisme fisiologis dan biologis yang mendasari proses penuaan. Salah satu teori biologis utama adalah teori radikal bebas. Teori ini menjelaskan bahwa penuaan terjadi karena kerusakan sel yang diakibatkan oleh radikal bebas—molekul tidak stabil yang dihasilkan dari proses metabolisme tubuh. Radikal bebas ini dapat merusak protein, lipid, dan DNA, menyebabkan degenerasi fungsi sel dan jaringan tubuh yang akhirnya mempercepat proses penuaan dan meningkatkan risiko berbagai penyakit degeneratif (Harman, 2020).

Teori biologis lainnya adalah teori pemendekan telomer (programmed aging theory), yang menyatakan bahwa setiap kali sel mengalami pembelahan, bagian akhir dari kromosom yang disebut telomer akan memendek. Pemendekan ini secara bertahap menyebabkan sel tidak mampu lagi memperbarui dirinya, yang kemudian menyebabkan berbagai gejala penuaan dan penurunan fungsi organ tubuh (Jiang & Ju, 2021). Selain itu, terdapat pula teori imunologis yang menjelaskan bahwa penurunan fungsi sistem imun pada lansia membuat mereka lebih rentan terhadap

infeksi dan penyakit autoimun, yang menjadi penyebab meningkatnya morbiditas dan mortalitas di kalangan lansia (Nikolich-Žugich, 2021).

Selain teori biologis, penuaan juga dijelaskan oleh teori-teori psikososial. Teori-teori ini memandang penuaan dari aspek sosial dan psikologis, mencoba memahami bagaimana interaksi sosial, perilaku, serta adaptasi emosional lansia dalam menghadapi perubahan hidup yang drastis. Misalnya, teori disengagement menyatakan bahwa lansia secara alami menarik diri dari peran sosialnya seiring bertambahnya usia. Teori ini berpendapat bahwa pelepasan dari keterlibatan sosial dianggap normal dalam persiapan menghadapi akhir kehidupan, meskipun sering kali dikritik karena tidak semua lansia mengalami disengagement ini (Cumming & Henry dalam Carstensen, 2021).

Sebaliknya, teori aktivitas menegaskan bahwa lansia yang aktif secara fisik, sosial, dan mental memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan cenderung lebih bahagia dibandingkan mereka yang kurang aktif. Menurut teori ini, keaktifan lansia dalam kegiatan sehari-hari dan interaksi sosial membantu mereka menjaga harga diri, merasa dihargai, dan tetap memiliki makna dalam hidupnya (Cavanaugh & Blanchard-Fields, 2022). Teori kontinuitas juga memberikan wawasan penting dengan menyatakan bahwa lansia cenderung mempertahankan pola hidup yang konsisten sejak masa mudanya hingga lanjut usia, sehingga menjaga kesejahteraan psikologis dan emosional mereka meskipun menghadapi berbagai perubahan dalam hidup (Atchley dalam Carstensen, 2021).

Karakteristik populasi lansia mencakup berbagai aspek kehidupan mereka yang unik, yang perlu diperhatikan dalam proses keperawatan. Dari aspek fisik, lansia mengalami berbagai perubahan signifikan yang meliputi penurunan kekuatan otot, keseimbangan yang menurun, serta kemampuan fungsional yang terbatas. Perubahan-perubahan ini sering kali berdampak pada risiko jatuh yang meningkat, gangguan mobilitas, dan ketergantungan pada orang lain dalam aktivitas sehari-hari (Potter et al., 2022). Selain itu, lansia juga mengalami penurunan fungsi indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perabaan, yang secara langsung mempengaruhi kualitas hidup mereka (Miller, 2021).

Secara psikologis, lansia sering menghadapi tantangan berupa perubahan kognitif seperti gangguan memori, penurunan kemampuan berpikir kritis, dan konsentrasi yang kurang optimal. Hal ini terkadang berujung pada kondisi demensia atau gangguan kognitif ringan yang mengharuskan pendekatan khusus dalam pemberian asuhan keperawatan. Di sisi lain, masalah emosional seperti depresi, kecemasan, dan perasaan kesepian juga umum ditemui pada lansia akibat kehilangan pasangan, isolasi sosial, atau perasaan tidak berguna akibat berkurangnya produktivitas (Diniz et al., 2022).

Dari sudut pandang sosial, lansia mengalami perubahan signifikan dalam peran sosial mereka, seperti pensiun dari pekerjaan yang selama ini menjadi sumber identitas dan aktivitas harian mereka. Perubahan ini bisa menyebabkan hilangnya struktur harian dan penurunan interaksi sosial, yang memperbesar risiko kesepian dan isolasi sosial. Di sisi ekonomi, lansia sering menghadapi tantangan finansial akibat berkurangnya sumber pendapatan setelah pensiun, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap kemiskinan atau ketergantungan pada bantuan keluarga atau pemerintah (Bengtson & Settersten, 2021).

Dengan memahami definisi lansia secara menyeluruh, teori-teori penuaan yang relevan, serta karakteristik khas populasi lansia, tenaga keperawatan mampu merancang dan melaksanakan asuhan keperawatan yang lebih efektif, humanistik, dan berbasis bukti, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan.

B. Perubahan Fisiologis dan Psikososial pada Lansia

Proses penuaan merupakan suatu fenomena kompleks yang ditandai oleh berbagai perubahan, baik secara fisiologis maupun psikososial. Perubahan-perubahan tersebut secara alami terjadi seiring bertambahnya usia, dan dapat memengaruhi kualitas hidup lansia secara signifikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perubahan ini menjadi sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam merencanakan asuhan yang tepat dan efektif untuk lansia.

Dalam aspek fisiologis, lansia mengalami perubahan yang mencakup hampir semua sistem tubuh. Salah satu yang paling menonjol adalah perubahan pada sistem muskuloskeletal, di mana terjadi penurunan massa otot (sarkopenia), hilangnya kepadatan tulang (osteoporosis), dan penurunan fleksibilitas sendi. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya kekuatan dan ketahanan fisik lansia, sehingga mereka lebih rentan mengalami cedera, jatuh, dan patah tulang. Selain itu, perubahan pada sistem kardiovaskular juga terjadi, seperti penurunan elastisitas pembuluh darah dan penebalan dinding jantung. Hal ini menyebabkan lansia lebih rentan terhadap hipertensi, penyakit jantung koroner, dan gagal jantung (Potter et al., 2022).

Selain itu, sistem pernapasan juga mengalami penurunan kapasitas vital paru-paru yang mengakibatkan penurunan efektivitas pernapasan. Lansia cenderung memiliki kapasitas paru-paru yang lebih rendah, mengakibatkan mudahnya terjadi sesak napas, infeksi paru-paru seperti pneumonia, dan penurunan daya tahan tubuh terhadap berbagai infeksi pernapasan. Sistem pencernaan juga tidak luput dari perubahan, ditandai dengan penurunan produksi asam lambung, enzim

pencernaan, dan motilitas usus. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya konstipasi, malnutrisi, serta gangguan penyerapan nutrisi yang penting bagi tubuh (Miller, 2021).

Selanjutnya, sistem saraf juga mengalami perubahan signifikan pada lansia, antara lain penurunan jumlah sel neuron, penurunan kecepatan transmisi saraf, serta gangguan fungsi kognitif. Penurunan ini menyebabkan gangguan ingatan ringan hingga kondisi yang lebih berat seperti demensia, termasuk penyakit Alzheimer. Perubahan pada sistem sensorik seperti penurunan kemampuan penglihatan (presbiopia, katarak, glaukoma), gangguan pendengaran (presbikusis), serta penurunan sensitivitas penciuman dan perabaan turut berperan dalam membatasi aktivitas harian dan interaksi sosial lansia (Touhy & Jett, 2020).

Akibat dari perubahan fisiologis tersebut, lansia menjadi kelompok populasi yang rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan kronis. Beberapa penyakit yang paling sering ditemukan pada lansia antara lain diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, osteoarthritis, penyakit jantung koroner, dan osteoporosis. Penyakit-penyakit kronis ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup secara fisik tetapi juga memperbesar risiko kecacatan dan ketergantungan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, lansia dengan osteoarthritis sering mengalami keterbatasan mobilitas yang berujung pada ketergantungan pada orang lain dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti berpakaian, mandi, dan berjalan (Miller, 2021).

Sementara dari aspek psikososial, lansia juga menghadapi berbagai tantangan penting yang sering kali kurang diperhatikan namun memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup mereka. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah perubahan peran sosial. Lansia yang dulunya aktif dalam pekerjaan dan memiliki posisi tertentu dalam masyarakat, sering mengalami perasaan kehilangan identitas saat pensiun. Kehilangan identitas ini dapat memicu perasaan kurang berarti, isolasi sosial, serta depresi. Banyak lansia yang merasa tidak lagi dihargai oleh masyarakat atau keluarganya, yang semakin memperbesar risiko masalah psikologis (Diniz et al., 2022).

Selain itu, lansia sering mengalami kehilangan pasangan hidup atau teman dekat yang menyebabkan perasaan duka yang berkepanjangan dan kesepian. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan mobilitas fisik dan gangguan sensorik, sehingga lansia cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Akibatnya, lansia menjadi lebih rentan terhadap depresi, kecemasan, dan gangguan tidur yang secara signifikan menurunkan kualitas hidup dan kemampuan fungsional mereka dalam aktivitas sehari-hari (Touhy & Jett, 2020).

Stigma sosial tentang penuaan juga merupakan masalah psikososial yang serius. Dalam beberapa budaya, lansia sering dianggap tidak produktif, kurang

kompeten, atau menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat. Stigma ini dapat menyebabkan lansia mengalami diskriminasi sosial, menurunkan harga diri, serta meningkatkan risiko masalah emosional seperti kecemasan dan depresi. Kondisi psikososial tersebut juga dapat menghambat lansia untuk mengakses layanan kesehatan, menyebabkan keterlambatan dalam mendapatkan penanganan medis yang tepat (Carstensen, 2021).

Secara keseluruhan, perubahan fisiologis dan psikososial pada lansia sangat kompleks dan saling terkait. Kondisi fisik yang memburuk dapat memperburuk kondisi psikososial, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, dalam konteks keperawatan lansia, pendekatan yang bersifat holistik sangat penting. Pendekatan tersebut harus memperhatikan semua aspek kehidupan lansia, baik fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Tenaga kesehatan khususnya perawat perlu memahami perubahan-perubahan ini secara mendalam agar mampu memberikan intervensi yang efektif, mendukung, serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan.

C. Pengkajian Keperawatan pada Lansia

Pengkajian keperawatan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif dan tepat pada lansia. Tahap ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah kesehatan yang sedang dialami lansia, tetapi juga untuk mengenali potensi risiko yang dapat mengganggu kesehatan mereka di masa depan. Dalam konteks lansia, pengkajian keperawatan yang holistik mencakup pemeriksaan fisik, pengkajian fungsional, serta evaluasi psikososial yang menyeluruh untuk mendapatkan gambaran lengkap kondisi kesehatan lansia secara komprehensif.

Pengkajian fisik pada lansia dilakukan untuk mendeteksi perubahan fisiologis yang berkaitan dengan proses penuaan serta gangguan kesehatan yang umum terjadi di kalangan lansia. Pengkajian ini dimulai dengan pemeriksaan tanda-tanda vital, meliputi tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu tubuh. Penilaian tanda-tanda vital sangat penting karena lansia cenderung memiliki variabilitas fisiologis yang tinggi akibat penuaan, seperti hipertensi atau hipotensi postural. Selain itu, pengkajian sistem organ tubuh juga perlu dilakukan secara teliti. Misalnya, pemeriksaan sistem kardiovaskular mencakup evaluasi terhadap denyut jantung yang tidak teratur, murmur jantung, dan tanda-tanda insufisiensi jantung seperti edema perifer.

Sistem pernapasan pada lansia perlu diperiksa secara seksama untuk mendeteksi perubahan kapasitas paru-paru atau adanya tanda-tanda infeksi seperti pneumonia, yang sering terjadi akibat penurunan daya tahan tubuh pada lansia.

Pemeriksaan sistem muskuloskeletal juga penting untuk mendeteksi penurunan massa otot, gangguan mobilitas, dan risiko jatuh. Selain itu, pemeriksaan neurologis juga penting, termasuk evaluasi fungsi kognitif seperti memori jangka pendek dan panjang, orientasi terhadap waktu, tempat, dan orang, serta koordinasi motorik untuk mendeteksi dini gejala demensia atau penyakit degeneratif lainnya.

Selain pengkajian fisik, aspek lain yang tidak kalah penting dalam pengkajian keperawatan pada lansia adalah pengkajian fungsional. Pengkajian ini bertujuan menilai kemampuan lansia dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari (Activity of Daily Living atau ADL) serta aktivitas instrumental kehidupan sehari-hari (Instrumental Activity of Daily Living atau IADL). ADL mencakup aktivitas dasar seperti mandi, berpakaian, makan, toileting, berpindah posisi, dan mobilitas. Sedangkan IADL meliputi kemampuan melakukan tugas yang lebih kompleks seperti menggunakan telepon, mengelola keuangan pribadi, berbelanja, memasak, melakukan pekerjaan rumah tangga ringan, serta mengatur pengobatan. Evaluasi terhadap kemampuan fungsional ini sangat penting karena menurunnya fungsi fungsional pada lansia akan berdampak langsung pada kualitas hidup, tingkat ketergantungan, dan kebutuhan terhadap dukungan atau bantuan dari keluarga maupun tenaga kesehatan.

Dalam melakukan pengkajian fungsional, tenaga keperawatan biasanya menggunakan instrumen yang terstandardisasi seperti Indeks Katz untuk ADL dan skala Lawton untuk IADL. Hasil pengkajian ini dapat membantu tenaga kesehatan merencanakan intervensi yang tepat guna menjaga atau meningkatkan independensi lansia, mencegah terjadinya penurunan fungsi lebih lanjut, serta mengurangi risiko kecelakaan domestik seperti jatuh.

Pengkajian psikososial merupakan komponen penting lainnya dalam pengkajian keperawatan lansia yang bersifat holistik. Pengkajian ini bertujuan mengevaluasi kondisi emosional, sosial, serta psikologis yang sangat mempengaruhi kesejahteraan lansia secara keseluruhan. Dalam konteks ini, tenaga keperawatan perlu melakukan wawancara mendalam untuk mengevaluasi kondisi emosional seperti adanya gejala depresi, kecemasan, stres, dan perasaan kesepian. Kondisi-kondisi ini seringkali muncul akibat perubahan hidup yang signifikan seperti kehilangan pasangan, isolasi sosial, atau perubahan peran sosial setelah pensiun. Evaluasi terhadap kondisi psikologis ini bisa menggunakan instrumen yang terstandardisasi seperti Geriatric Depression Scale (GDS) atau skala kecemasan khusus lansia.

Selain aspek emosional, aspek sosial juga perlu dikaji secara mendalam, termasuk hubungan lansia dengan keluarga, komunitas, atau jaringan sosial lainnya. Evaluasi dukungan sosial, baik secara emosional, finansial, maupun instrumental,

sangat penting karena mempengaruhi kemampuan lansia dalam mengatasi tantangan sehari-hari. Lansia dengan dukungan sosial yang memadai cenderung lebih mampu mengatasi masalah kesehatan dan psikologis yang dialaminya dibandingkan mereka yang kurang mendapatkan dukungan.

Selain itu, penting juga untuk mengkaji aspek spiritual yang sering menjadi sumber kekuatan bagi lansia dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Pertanyaan tentang keyakinan agama atau spiritual, praktik keagamaan, serta bagaimana lansia memandang makna hidup dan menghadapi kematian dapat memberikan wawasan penting bagi perawat dalam memberikan intervensi yang bersifat spiritual sesuai kebutuhan lansia.

Secara keseluruhan, pengkajian keperawatan yang komprehensif pada lansia harus mencakup dimensi fisik, fungsional, dan psikososial. Informasi yang diperoleh dari pengkajian ini akan menjadi dasar dalam menyusun rencana asuhan keperawatan yang tepat, individual, serta berbasis bukti. Hal ini bertujuan untuk membantu lansia mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup mereka, meminimalkan risiko komplikasi akibat penyakit kronis, dan mendukung mereka agar mampu menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri dan bermakna.

D. Perencanaan Asuhan Keperawatan Lansia

Perencanaan asuhan keperawatan lansia merupakan langkah penting dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk menentukan intervensi yang tepat berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan pada tahap pengkajian. Proses perencanaan ini melibatkan tahap-tahap yang sistematis dan terstruktur, diawali dengan menentukan diagnosis keperawatan prioritas, dilanjutkan dengan penyusunan tujuan dan kriteria hasil yang jelas, hingga menetapkan intervensi keperawatan yang berbasis bukti ilmiah.

Menentukan diagnosis keperawatan prioritas merupakan langkah awal dalam proses perencanaan asuhan keperawatan. Diagnosis keperawatan adalah penilaian klinis tentang respons individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan aktual atau potensial. Dalam konteks lansia, penentuan diagnosis keperawatan prioritas harus didasarkan pada tingkat urgensi masalah, dampaknya terhadap kualitas hidup, serta potensi komplikasi yang dapat terjadi. Sebagai contoh, lansia yang mengalami risiko jatuh tinggi akibat gangguan mobilitas dan kelemahan otot harus mendapatkan prioritas tinggi dalam diagnosis keperawatannya dibandingkan dengan diagnosis lain yang memiliki dampak yang lebih ringan.

Untuk menentukan diagnosis keperawatan secara akurat dan relevan, perawat perlu menggunakan data yang telah dikumpulkan selama tahap pengkajian, baik

data fisik, fungsional, maupun psikososial. Diagnosis tersebut harus didasarkan pada standar diagnosis keperawatan yang baku, seperti yang diterbitkan oleh North American Nursing Diagnosis Association (NANDA International, 2021). Diagnosis keperawatan prioritas pada lansia sering mencakup risiko jatuh, gangguan mobilitas fisik, defisit perawatan diri, gangguan eliminasi, ketidakefektifan koping, gangguan pola tidur, nyeri kronis, serta isolasi sosial.

Setelah menentukan diagnosis keperawatan prioritas, langkah berikutnya dalam perencanaan adalah menyusun tujuan dan kriteria hasil yang jelas dan spesifik. Tujuan merupakan pernyataan tentang hasil yang diharapkan dari intervensi keperawatan, sementara kriteria hasil merupakan indikator konkret yang digunakan untuk menilai keberhasilan intervensi tersebut. Penyusunan tujuan pada lansia harus realistis, spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam waktu tertentu. Sebagai contoh, jika diagnosis prioritas adalah risiko jatuh, tujuan intervensi dapat berupa lansia mampu mempertahankan keseimbangan tubuh dan tidak mengalami jatuh dalam periode waktu tertentu.

Kriteria hasil yang jelas juga diperlukan untuk mengevaluasi kemajuan lansia terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria hasil tersebut bisa berupa lansia mampu berjalan secara mandiri sejauh beberapa meter tanpa bantuan atau menunjukkan perbaikan dalam kekuatan otot dan koordinasi tubuh yang diukur melalui observasi dan penilaian rutin oleh perawat. Kriteria hasil ini harus terukur agar perawat dapat menilai secara objektif sejauh mana intervensi keperawatan yang dilakukan efektif dalam mengatasi masalah lansia.

Tahap akhir dari perencanaan asuhan keperawatan lansia adalah menyusun intervensi keperawatan berbasis bukti. Intervensi keperawatan ini merupakan tindakan yang dirancang secara khusus berdasarkan bukti ilmiah yang kuat untuk mencapai tujuan dan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam menentukan intervensi ini, perawat perlu merujuk pada hasil-hasil penelitian terbaru, pedoman klinis, serta rekomendasi praktik terbaik dalam bidang keperawatan geriatri. Intervensi berbasis bukti memastikan bahwa tindakan keperawatan yang diberikan kepada lansia efektif, efisien, dan aman untuk diterapkan.

Intervensi keperawatan pada lansia sering kali bersifat multidimensi dan mencakup berbagai aspek seperti fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Sebagai contoh, untuk lansia dengan risiko jatuh tinggi, intervensi dapat mencakup latihan fisik terstruktur yang bertujuan memperkuat otot dan meningkatkan keseimbangan, modifikasi lingkungan rumah untuk mengurangi bahaya jatuh seperti menghilangkan karpet licin atau memasang pegangan di kamar mandi, serta edukasi kepada lansia dan keluarga tentang pencegahan jatuh dan teknik mobilisasi yang aman.

Intervensi psikososial juga merupakan bagian penting dari asuhan keperawatan lansia. Misalnya, untuk lansia yang mengalami isolasi sosial atau depresi, intervensi dapat berupa terapi kelompok, intervensi berbasis komunitas, konseling psikologis, atau kegiatan sosial terjadwal yang membantu lansia tetap aktif dalam komunitasnya. Intervensi semacam ini memiliki bukti kuat dalam meningkatkan kesejahteraan emosional, mengurangi risiko depresi, serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan.

Dalam menyusun intervensi, perawat juga perlu melibatkan lansia dan keluarga sebagai mitra aktif dalam perencananya. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dipilih sesuai dengan preferensi dan kemampuan lansia, meningkatkan kepatuhan terhadap intervensi yang dirancang, serta memperbesar peluang keberhasilan intervensi tersebut.

Secara keseluruhan, perencanaan asuhan keperawatan lansia yang efektif membutuhkan pendekatan sistematis yang dimulai dengan penentuan diagnosis keperawatan prioritas berdasarkan kebutuhan dan risiko lansia, diikuti oleh penyusunan tujuan yang realistis serta kriteria hasil yang jelas, hingga penetapan intervensi yang berbasis bukti ilmiah. Dengan pendekatan seperti ini, asuhan keperawatan yang diberikan akan tepat sasaran, efektif, efisien, serta dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup lansia.

E. Implementasi Asuhan Keperawatan Lansia

Implementasi asuhan keperawatan lansia merupakan tahap penting dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk melaksanakan rencana intervensi yang telah disusun sebelumnya. Tahap ini sangat menentukan efektivitas proses keperawatan karena di sinilah rencana yang telah disusun diterapkan secara langsung kepada lansia. Implementasi asuhan keperawatan ini melibatkan pelaksanaan intervensi fisik, intervensi psikososial, serta pemberian edukasi kesehatan yang efektif kepada lansia dan keluarganya.

Pelaksanaan intervensi keperawatan fisik pada lansia berfokus pada pengelolaan atau pencegahan gangguan kesehatan yang umum dialami oleh lansia, seperti gangguan mobilitas, nyeri kronis, gangguan nutrisi, dan gangguan eliminasi. Dalam melaksanakan intervensi ini, perawat perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kondisi fisik lansia serta keterampilan klinis yang baik untuk memastikan efektivitas intervensi. Contohnya, bagi lansia yang mengalami risiko jatuh akibat kelemahan otot dan gangguan keseimbangan, perawat perlu melaksanakan latihan fisik yang terstruktur dan teratur, seperti latihan penguatan otot, senam keseimbangan, atau fisioterapi khusus yang terbukti efektif dalam meningkatkan kekuatan otot, stabilitas, serta mobilitas lansia. Selain latihan fisik,

perawat juga melakukan tindakan untuk modifikasi lingkungan seperti memasang alat bantu jalan, pegangan di kamar mandi, atau pengaturan tempat tidur yang aman guna meminimalisir risiko jatuh.

Pada lansia dengan masalah nyeri kronis, intervensi fisik yang efektif mencakup manajemen nyeri dengan pendekatan farmakologis maupun non-farmakologis. Pendekatan non-farmakologis dapat berupa terapi relaksasi, terapi panas atau dingin, pijat terapeutik, atau akupresur yang mampu mengurangi intensitas nyeri tanpa menambah efek samping pengobatan. Selain itu, lansia yang mengalami masalah nutrisi juga perlu mendapatkan perhatian khusus melalui intervensi nutrisi yang tepat, termasuk penyesuaian jenis makanan, frekuensi makan, serta pemberian suplementasi nutrisi yang diperlukan sesuai dengan kondisi kesehatan mereka.

Intervensi psikososial merupakan aspek penting lain dalam implementasi asuhan keperawatan lansia. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan emosional dan sosial lansia dengan mengatasi berbagai masalah psikososial yang sering mereka alami, seperti isolasi sosial, depresi, kecemasan, dan rasa kesepian. Dalam pelaksanaannya, intervensi psikososial melibatkan aktivitas yang mendorong lansia untuk tetap aktif secara sosial dan emosional, seperti mengikuti terapi kelompok, kelompok dukungan sebaya, atau aktivitas rekreasi yang sesuai dengan minat mereka. Kegiatan ini tidak hanya membantu lansia menjaga hubungan sosial tetapi juga memberikan mereka rasa kebersamaan dan tujuan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, intervensi psikososial juga dapat mencakup konseling individu atau kelompok yang berfokus pada pengelolaan stres, koping positif, dan resolusi masalah. Pendekatan terapeutik seperti terapi perilaku kognitif (CBT) atau konseling berbasis mindfulness terbukti efektif dalam membantu lansia mengatasi gejala-gejala kecemasan dan depresi. Penting juga bagi perawat untuk mendorong keterlibatan keluarga dalam proses ini karena dukungan keluarga memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan efektivitas intervensi psikososial serta memperkuat dukungan emosional bagi lansia.

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam implementasi asuhan keperawatan lansia adalah pemberian edukasi kesehatan kepada lansia dan keluarganya. Edukasi ini bertujuan agar lansia dan keluarganya memahami dengan baik kondisi kesehatan lansia, tindakan pencegahan penyakit, manajemen gejala yang timbul, serta strategi menjaga kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang. Edukasi yang efektif harus disampaikan dengan jelas dan sederhana, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh lansia serta disesuaikan dengan tingkat literasi kesehatan mereka.

Topik edukasi kesehatan yang penting untuk lansia meliputi pencegahan jatuh, pengelolaan penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi, pengaturan pola

makan yang sehat, pentingnya aktivitas fisik rutin, serta penggunaan obat secara tepat dan aman. Selain itu, edukasi juga harus mencakup pentingnya menjaga kesehatan mental, seperti cara mengenali gejala depresi atau kecemasan, teknik relaksasi sederhana yang dapat dilakukan di rumah, serta pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat dengan lingkungan sekitar.

Peran keluarga dalam edukasi kesehatan sangat signifikan. Dengan melibatkan keluarga dalam sesi edukasi, mereka akan lebih mampu mendukung lansia dalam menjalani rekomendasi yang diberikan oleh perawat. Keluarga juga akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam merawat lansia di rumah, seperti mengenali tanda-tanda perburukan kondisi kesehatan lansia, pemberian obat yang tepat, serta manajemen perawatan sehari-hari yang aman dan nyaman bagi lansia.

Secara keseluruhan, implementasi asuhan keperawatan lansia yang efektif membutuhkan kombinasi intervensi fisik, intervensi psikososial, dan edukasi kesehatan yang holistik dan terintegrasi. Pelaksanaan yang tepat akan membantu lansia mencapai hasil kesehatan yang optimal, meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh, serta mendukung mereka agar tetap aktif, mandiri, dan terintegrasi dalam kehidupan sosial dan keluarga.

F. Evaluasi Asuhan Keperawatan Lansia

Evaluasi dalam proses asuhan keperawatan lansia merupakan langkah kritis yang bertujuan untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana keperawatan tercapai. Proses ini juga digunakan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilaksanakan serta mengidentifikasi kemungkinan adanya kebutuhan untuk modifikasi atau revisi rencana keperawatan. Evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan kontinu, melibatkan berbagai indikator yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengukur keberhasilan intervensi secara obyektif.

Indikator evaluasi keberhasilan intervensi merupakan ukuran spesifik yang digunakan untuk menentukan sejauh mana hasil yang diharapkan telah dicapai oleh lansia melalui intervensi keperawatan yang telah diberikan. Indikator ini harus bersifat terukur, relevan, dan spesifik, sehingga dapat menggambarkan secara jelas tingkat kemajuan yang dicapai lansia. Indikator ini mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek fisik, fungsional, psikososial, hingga edukatif. Misalnya, dalam aspek fisik, indikator keberhasilan intervensi bisa berupa peningkatan kekuatan otot yang dapat diukur melalui kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri tanpa bantuan. Indikator lainnya bisa berupa menurunnya frekuensi jatuh atau kejadian cedera akibat jatuh selama periode waktu tertentu.

Untuk aspek fungsional, indikator evaluasi mencakup peningkatan kemampuan lansia dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari (ADL) seperti mandi, berpakaian, atau makan tanpa bantuan orang lain. Instrumen baku seperti

Indeks Katz atau Lawton sering digunakan untuk menilai perubahan dalam kemampuan fungsional lansia secara objektif. Dalam aspek psikososial, indikator evaluasi dapat mencakup penurunan gejala depresi atau kecemasan yang terukur menggunakan skala standar seperti Geriatric Depression Scale (GDS). Indikator lain bisa berupa peningkatan interaksi sosial atau partisipasi aktif lansia dalam kegiatan komunitas atau keluarga, yang menunjukkan perbaikan kualitas hidup sosial dan emosional lansia.

Aspek edukasi kesehatan juga memerlukan indikator evaluasi yang jelas. Misalnya, indikator keberhasilan edukasi bisa berupa peningkatan pengetahuan lansia dan keluarga tentang cara mengelola penyakit kronis, teknik pencegahan jatuh, penggunaan obat yang tepat, serta pentingnya menjaga pola makan sehat dan aktivitas fisik rutin. Hal ini dapat diukur melalui wawancara atau kuesioner yang menilai tingkat pemahaman lansia dan keluarga sebelum dan setelah edukasi diberikan.

Evaluasi tidak hanya berhenti pada penilaian indikator saja, tetapi juga memerlukan dokumentasi yang jelas dan terstruktur. Dokumentasi evaluasi merupakan catatan tertulis tentang hasil intervensi keperawatan yang telah dilakukan, kemajuan lansia dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, serta rekomendasi tindak lanjut yang mungkin diperlukan. Dokumentasi ini penting untuk komunikasi antar tim kesehatan, kontinuitas perawatan, dan sebagai dasar hukum dalam praktik keperawatan.

Dokumentasi evaluasi harus mencakup data hasil observasi, hasil wawancara dengan lansia dan keluarga, hasil pengukuran menggunakan instrumen atau skala tertentu, serta kesimpulan tentang tingkat pencapaian tujuan keperawatan. Selain itu, dokumentasi juga harus mencatat hambatan atau kendala yang dihadapi selama pelaksanaan intervensi, yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun revisi rencana keperawatan. Dokumentasi ini juga menjadi bagian dari rekam medis lansia, sehingga harus dibuat secara jelas, akurat, objektif, serta dapat dipahami oleh semua anggota tim kesehatan yang terlibat dalam perawatan lansia.

Revisi rencana asuhan merupakan tindak lanjut logis dari proses evaluasi. Jika dalam evaluasi ditemukan bahwa tujuan yang ditetapkan belum tercapai secara optimal atau intervensi yang dilakukan tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka perawat perlu melakukan revisi rencana keperawatan. Revisi ini mungkin berupa penyesuaian tujuan agar lebih realistis, perubahan intervensi yang digunakan, atau penambahan strategi baru yang lebih efektif. Misalnya, jika intervensi latihan fisik belum menunjukkan hasil dalam meningkatkan kekuatan otot lansia, maka perawat dapat merevisi intervensi tersebut dengan menambahkan teknik latihan baru atau meningkatkan frekuensi dan intensitas latihan sesuai

kemampuan lansia.

Proses revisi ini memerlukan kolaborasi aktif antara perawat, lansia, dan keluarga, serta melibatkan tim multidisiplin seperti dokter, fisioterapis, atau ahli gizi jika diperlukan. Revisi harus didasarkan pada analisis data evaluasi yang akurat dan mencerminkan kebutuhan spesifik lansia. Melalui revisi yang tepat, intervensi yang diberikan menjadi lebih efektif, sehingga tujuan perawatan dapat tercapai dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, evaluasi asuhan keperawatan lansia merupakan komponen yang sangat penting dalam proses keperawatan secara keseluruhan. Melalui evaluasi yang sistematis dan terstruktur, perawat mampu mengukur keberhasilan intervensi, mendokumentasikan hasil yang diperoleh secara jelas, serta melakukan revisi rencana keperawatan yang dibutuhkan. Dengan demikian, proses keperawatan yang dilakukan terhadap lansia menjadi lebih terarah, efektif, dan mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup lansia secara menyeluruh.

G. Latihan Soal

Kasus 1

Seorang perempuan lansia bernama Ny. Ani, usia 78 tahun, mengalami penurunan massa otot dan kekuatan otot yang menyebabkan ia sulit berdiri dan berjalan sendiri. Berdasarkan teori penuaan, manakah yang paling relevan untuk menjelaskan kondisi yang dialami Ny. Ani?

- A. Teori disengagement
- B. Teori radikal bebas
- C. Teori kontinuitas
- D. Teori aktivitas
- E. Teori imunologis

Jawaban: B. Teori radikal bebas

Pembahasan:

Teori radikal bebas menjelaskan bahwa penuaan terjadi akibat akumulasi kerusakan sel akibat radikal bebas, yang memengaruhi degenerasi jaringan seperti otot. Ini relevan dengan kondisi Ny. Ani yang mengalami penurunan massa otot (sarkopenia), sehingga sulit berdiri dan berjalan.

Kasus 2

Tn. Agus berusia 82 tahun mengeluh sering lupa dengan kejadian baru-baru ini dan sulit mengenali anggota keluarga yang jauh. Saat dilakukan pengkajian keperawatan, perawat menemukan gangguan fungsi kognitif. Pengkajian

keperawatan mana yang paling tepat untuk menilai fungsi kognitif pada Tn. Agus?

- A. Indeks Katz
- B. Skala Lawton
- C. Geriatric Depression Scale (GDS)
- D. Mini-Mental State Examination (MMSE)
- E. Barthel Index

Jawaban: D. Mini-Mental State Examination (MMSE)

Pembahasan:

MMSE adalah alat pengkajian kognitif yang dirancang untuk mengevaluasi fungsi memori, orientasi, konsentrasi, serta kemampuan mengenali orang dan tempat. MMSE paling tepat untuk digunakan dalam kasus Tn. Agus yang menunjukkan tanda-tanda gangguan kognitif.

Kasus 3

Ny. Sari, usia 75 tahun, tinggal sendiri sejak ditinggal meninggal suaminya setahun lalu. Akhir-akhir ini ia terlihat murung, menarik diri dari aktivitas sosial, dan mengeluh merasa tidak berarti lagi. Menurut teori psikososial penuaan, kondisi yang dialami Ny. Sari paling tepat dijelaskan oleh teori:

- A. Teori aktivitas
- B. Teori disengagement
- C. Teori kontinuitas
- D. Teori radikal bebas
- E. Teori imunologis

Jawaban: B. Teori disengagement

Pembahasan:

Teori disengagement menjelaskan bahwa lansia secara bertahap menarik diri dari kehidupan sosial sebagai bagian dari proses alami menghadapi akhir kehidupan. Kondisi Ny. Sari yang menarik diri dari lingkungan dan aktivitas sosial serta merasa tidak berarti sangat mencerminkan teori ini.

Kasus 4

Pak Budi, 80 tahun, mengalami gangguan keseimbangan yang membuatnya sering hampir jatuh. Setelah pengkajian, diagnosis keperawatan prioritas yang tepat untuk Pak Budi adalah:

- A. Defisit nutrisi
- B. Risiko jatuh
- C. Isolasi sosial
- D. Gangguan eliminasi

E. Ketidakefektifan koping

Jawaban: B. Risiko jatuh

Pembahasan:

Diagnosis keperawatan prioritas bagi Pak Budi yang paling tepat adalah risiko jatuh, karena ia mengalami gangguan keseimbangan yang meningkatkan kemungkinan mengalami jatuh dan cedera.

Kasus 5

Ny. Tuti, lansia usia 70 tahun, mengalami hipertensi kronis. Perawat memberikan edukasi kesehatan kepada keluarga mengenai manajemen hipertensi. Indikator keberhasilan edukasi yang paling tepat adalah:

- A. Keluarga mampu memberikan makanan rendah garam secara konsisten
- B. Keluarga mampu menjelaskan konsep umum tentang kesehatan
- C. Keluarga mengajak lansia beraktivitas sosial lebih sering
- D. Lansia mengikuti kegiatan rekreasi
- E. Lansia mampu melakukan latihan fisik berat

Jawaban: A. Keluarga mampu memberikan makanan rendah garam secara konsisten

Pembahasan:

Indikator keberhasilan edukasi untuk manajemen hipertensi harus spesifik, relevan, dan langsung terkait dengan penyakitnya. Kemampuan keluarga memberikan makanan rendah garam secara konsisten merupakan indikator keberhasilan yang tepat untuk mengelola hipertensi secara efektif.

H. Rangkuman Materi

Asuhan keperawatan pada lansia merupakan proses yang holistik dan komprehensif, mencakup pengkajian, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi yang berkelanjutan. Lansia mengalami berbagai perubahan fisiologis, psikologis, sosial, dan fungsional akibat proses penuaan, yang masing-masing individu dapat mengalami dengan cara berbeda tergantung pada faktor genetik, gaya hidup, dan lingkungan.

Pemahaman terhadap konsep dasar keperawatan lansia, teori-teori penuaan seperti teori biologis (radikal bebas, pemendekan telomer, imunologis) dan psikososial (disengagement, aktivitas, kontinuitas), serta karakteristik khas populasi lansia menjadi landasan penting bagi perawat dalam memberikan asuhan yang efektif dan berbasis bukti. Pengkajian keperawatan yang komprehensif mencakup pemeriksaan fisik, pengkajian fungsional (ADL dan IADL), serta psikososial, yang selanjutnya digunakan untuk menentukan diagnosis prioritas secara tepat.

Perencanaan asuhan harus dilakukan secara sistematis, melibatkan penyusunan tujuan, kriteria hasil yang jelas dan terukur, serta intervensi yang berbasis bukti ilmiah, meliputi aspek fisik, psikososial, dan edukasi kepada lansia dan keluarga. Implementasi intervensi yang efektif membutuhkan keterampilan klinis perawat, dukungan keluarga, serta pendekatan psikososial dan edukasi yang tepat guna meningkatkan kemandirian lansia dan kualitas hidupnya.

Evaluasi dilakukan secara kontinu dengan indikator yang spesifik, terukur, dan relevan, dilengkapi dokumentasi yang jelas sebagai dasar komunikasi antar tim kesehatan dan revisi rencana asuhan jika diperlukan. Secara keseluruhan, pendekatan keperawatan yang sistematis, holistik, dan berbasis bukti sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup lansia secara signifikan, serta membantu mereka tetap aktif, mandiri, dan berdaya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul seiring bertambahnya usia.

I. Glosarium

Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (Activity of Daily Living/ADL)

Aktivitas dasar harian yang mencakup mandi, berpakaian, makan, toileting, berpindah posisi, dan mobilitas.

Aktivitas Instrumental Kehidupan Sehari-hari (Instrumental Activity of Daily Living/IADL)

Aktivitas kompleks harian seperti menggunakan telepon, mengelola keuangan pribadi, berbelanja, memasak, pekerjaan rumah tangga ringan, dan mengelola pengobatan.

Asuhan Keperawatan Lansia

Proses keperawatan yang mencakup pengkajian, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi yang holistik dan spesifik bagi lanjut usia.

Demensia

Kondisi penurunan fungsi kognitif progresif yang memengaruhi kemampuan berpikir, ingatan, orientasi, dan aktivitas harian.

Diagnosis Keperawatan

Penilaian klinis tentang respons individu terhadap masalah kesehatan aktual atau potensial.

Hipertensi Postural

Perubahan tekanan darah secara signifikan saat berpindah posisi dari duduk atau berbaring ke berdiri, umum terjadi pada lansia.

Isolasi Sosial

Kondisi di mana seseorang menarik diri dari interaksi sosial, sering kali dialami lansia akibat berbagai perubahan kehidupan.

Kapasitas Vital Paru-Paru

Jumlah udara maksimum yang dapat dihirup dan dihembuskan secara maksimal, menurun pada lansia.

Kriteria Hasil

Indikator konkret untuk mengukur pencapaian tujuan intervensi keperawatan.

Mini-Mental State Examination (MMSE)

Alat pengkajian yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi kognitif, seperti memori, orientasi, konsentrasi, dan kemampuan mengenali orang serta tempat.

Osteoporosis

Kondisi penurunan kepadatan tulang yang meningkatkan risiko patah tulang, sering ditemukan pada lansia.

Programmed Aging Theory (Teori Pemendekan Telomer)

Teori yang menjelaskan penuaan disebabkan oleh pemendekan telomer (ujung kromosom) saat pembelahan sel berulang, menyebabkan penurunan fungsi sel.

Radikal Bebas

Molekul tidak stabil yang dihasilkan proses metabolisme, menyebabkan kerusakan pada sel dan jaringan tubuh, dikaitkan dengan proses penuaan.

Risiko Jatuh

Kondisi yang dialami lansia akibat penurunan keseimbangan, kekuatan otot, dan gangguan mobilitas yang meningkatkan risiko cedera.

Sarkopenia

Kondisi penurunan massa dan kekuatan otot yang signifikan pada lansia, menyebabkan kesulitan aktivitas sehari-hari.

Skala Depresi Geriatrik (Geriatric Depression Scale/GDS)

Alat pengkajian khusus untuk mengevaluasi tingkat depresi pada lansia.

Teori Aktivitas

Teori psikososial yang menyatakan bahwa lansia yang tetap aktif secara sosial dan fisik memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Teori Disengagement

Teori psikososial yang menyatakan bahwa lansia secara bertahap menarik diri dari aktivitas sosial seiring bertambahnya usia sebagai persiapan menghadapi akhir kehidupan.

Teori Immunologis

Teori yang menyatakan bahwa penurunan sistem kekebalan tubuh pada lansia menyebabkan meningkatnya risiko penyakit infeksi dan autoimun.

Teori Kontinuitas

Teori psikososial yang menyatakan lansia cenderung mempertahankan pola hidup yang konsisten sejak muda hingga usia lanjut untuk menjaga kesejahteraan emosional dan psikologis.

Variabilitas Fisiologis

Perbedaan signifikan dalam parameter fisiologis seperti tekanan darah dan denyut jantung yang sering terjadi pada lansia.

WHO (World Health Organization)

Organisasi kesehatan dunia yang menetapkan usia lanjut (lansia) sebagai individu yang berusia 60 tahun atau lebih.

J. Daftar Pustaka

- Bengtson, V. L., & Settersten, R. A. (2021). *Handbook of theories of aging* (3rd ed.). Springer Publishing Company.
- Carstensen, L. L. (2021). *Socioemotional selectivity theory: Aging and emotion*. American Psychological Association.
- Cavanaugh, J. C., & Blanchard-Fields, F. (2022). *Adult development and aging* (9th ed.). Cengage Learning.
- Diniz, B. S., Reynolds, C. F., & Butters, M. A. (2022). Psychological aspects of aging: Cognitive impairment, depression, and anxiety disorders. *Clinics in Geriatric Medicine*, 38(4), 631–646. <https://doi.org/10.1016/j.cger.2022.05.002>
- Harman, D. (2020). Free radical theory of aging. In *Handbook of the Biology of Aging* (9th ed., pp. 95–114). Academic Press.
- Jiang, H., & Ju, Z. (2021). Telomere shortening and aging. *Cell Research*, 31(2), 169–185. <https://doi.org/10.1038/s41422-020-00472-9>
- Miller, C. A. (2021). *Nursing for wellness in older adults* (9th ed.). Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
- NANDA International. (2021). *NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2021-2023* (12th ed.). Thieme.
- Nikolich-Žugich, J. (2021). The twilight of immunity: Emerging concepts in aging of the immune system. *Nature Immunology*, 22(7), 889–899. <https://doi.org/10.1038/s41590-021-00936-x>
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2022). *Fundamentals of nursing* (11th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Touhy, T. A., & Jett, K. F. (2020). *Ebersole and Hess' Gerontological Nursing & Healthy Aging* (5th ed.). Elsevier.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Decade of healthy ageing: Baseline report*. World Health Organization.

BAB 5

PROSEDUR TINDAKAN KEPERAWATAN PADA LANSIA

Tujuan Instruksional:

Menerapkan terapi kognitif pada lansia

Melatih terapi aktivitas untuk lansia

Melakukan bantuan aktivitas sehari hari (activity daily living/ADL) pada kelompok lansia

Melatih senam lansia

Capaian Pembelajaran:

CPL- PRODI yang dibebankan pada MK	
	Mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip <i>caring</i> sesuai kode etik profesi
Capaian pembelajaran Mata kuliah (CPMK)	
CPMK 5	Mahasiswa mampu Mengaplikasikan pengetahuan, sikap dan keterampilan praktik dan aktivitas menerapkan perawatan pada lansia yang efektif baik ditatanan layanan individu di rumah maupun di rumah sakit serta layanan di tingkat keluarga dan kelompok.
Sub-CPMK	
Sub-CPMK 5.1	Menerapkan tindakan keperawatan pada lansia
Sub-CPMK 5.2	Menerapkan terapi kognitif pada lansia
Sub-CPMK 5.3	Melatih terapi aktivitas untuk lansia
Sub-CPMK 5.4	Melakukan bantuan aktivitas sehari hari (activity daily living/ADL) pada kelompok lansia
Sub-CPMK 5.5	Melatih senam lansia

Pendahuluan:

Implementasi keperawatan atau tindakan keperawatan merupakan salah satu tahap dalam proses keperawatan (Potter, A & Perry, 2015). Proses keperawatan sendiri terdiri dari pengkajian, penegakan diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi.

Penerapan implementasi keperawatan pada lansia pada dasarnya sama pada penerapan implementasi untuk kelompok usia lainnya. Pelaksanaan implementasi harus sesuai dengan intervensi atau perencanaan yang disusun atau lebih tepatnya tergantung 3 tahap proses keperawatan sebelumnya. Perencanaan disusun dengan memperhatikan ketercapaian tujuan yang ingin dicapai. Implementasi atau tindakan keperawatan bentuk aktif dari intervensi yang terdiri dari kegiatan observasi, terapeutik/tindakan mandiri keperawatan dan edukasi serta kolaborasi. Implementasi yang bersifat kolaborasi pada dasarnya tidak harus ada dalam setiap intervensi.

Pada bab ini akan memberikan beberapa implementasi keperawatan yang dapat diberikan pada lansia. Implementasi yang akan dibahas pada bab ini merupakan tindakan keperawatan yang bersifat terapeutik dan edukasi. Tujuan dari bab ini adalah mahasiswa keperawatan tahu lebih banyak apa tindakan terapeutik dan edukasi yang dapat diberikan pada lansia dalam mengatasi masalah kesehatan yang dialami oleh lansia. Pada bab ini juga akan diberikan penjelasan dari tindakan keperawatan yang dilakukan pada lansia. Saran yang dapat kami berikan kepada mahasiswa keperawatan adalah sebelum mempelajari tentang tindakan keperawatan, mahasiswa keperawatan harus benar benar menguasai dan memahami 3 buku yaitu buku standar diagnosa keperawatan Indonesia, buku standar luaran keperawatan Indonesia, dan buku standar intervensi Keperawatan Indonesia.

Gambaran awal yang saya dapat berikan adalah implementasi butuh waktu untuk melihat efektifitas atau hasil dan ini sangat tergantung dengan apa tujuan atau luaran yang ingin dicapai dan kemampuan perawat melakukan analisis. Lamanya Implementasi adalah sesuai batasan waktu atau analisis waktu pemberian implementasi yang tertuang pada tujuan yang dicapai. Topik pada bab ini adalah fokus pada implementasi yang bersifat terapeutik yang dapat dilakukan secara mandiri nantinya oleh lansia dan bisa dilakukan sendiri atau dengan kelompok. Dan Pemberian penjelasan akan tindakan keperawatan yang akan diberikan pada lansia dapat melalui kegiatan edukasi kesehatan.

Metode pembelajaran yang digunakan adalah diawali dengan metode contextual teaching and learning, selanjutnya menggunakan metode praktikum. Pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan adalah dengan pendekatan berbasis masalah, pendekatan berbasis proyek. Pedoman penggunaan buku ajar ini adalah baca dan pahami materi dan selanjutnya bisa buka buka artikel yang terkait dan melihat video yang terkait. Sumber tambahan yang bisa digunakan adalah artikel penelitian baik internasional maupun nasional dan video pada youtube yang dikeluarkan oleh instansi instansi kesehatan.

Uraian Materi

Materi bab ini akan fokus membahas pada implementasi keperawatan yang dapat diberikan pada lansia. Pada bab implementasi keperawatan akan dijabarkan menjadi 5 sub bab, yaitu: implementasi keperawatan pada lansia, terapi kognitif pada lansia, terapi aktivitas untuk lansia, bantuan aktivitas sehari-hari (activity daily living/ADL) pada kelompok lansia dan senam lansia. Di bawah ini penjelasan dari masing-masing sub bab.

A. Tindakan keperawatan pada lansia

Konsep Tindakan Keperawatan Pada lansia akan dibahas di Sub Bab 1 ini sebagai berikut:

1. Pengertian

Tindakan keperawatan pada lansia merupakan bagian dari proses keperawatan urutan Nomor 4. Tindakan keperawatan dilakukan sebagai upaya mengatasi masalah keperawatan yang muncul pada lansia. Tindakan keperawatan atau disebut juga implementasi keperawatan dilakukan berdasarkan perencanaan tindakan yang telah disusun dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang dapat terdiri dari kegiatan observasi, tindakan mandiri keperawatan/terapeutik dan edukasi serta bisa ditambahkan kolaborasi jika memang diperlukan dengan tim kesehatan lain atau di singkat OTEK (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Tindakan keperawatan dilakukan dengan memperhatikan kondisi lansia khususnya kondisi fisik, psikis dan sosial dari lansia. Jika implementasi membutuhkan kemampuan fisik dalam pelaksanaannya jelas kondisi fisik harus diperhatikan.

Tindakan keperawatan yang diberikan pada lansia ada yang bisa dilakukan secara individu tetapi ada yang lebih dianjurkan dilakukan secara berkelompok. Tindakan keperawatan yang diberikan pada lansia berdasarkan prioritas masalah keperawatan pada lansia yang harus diatasi atau diselesaikan terlebih dahulu. Tindakan keperawatan yang diberikan pada lansia harus mendapatkan pemantauan dalam bentuk evaluasi, baik evaluasi formatif maupun evaluasi sumatif (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2018).

2. Macam Tindakan Keperawatan Pada Lansia

Tindakan keperawatan pada lansia terdiri dari 3 kegiatan yaitu:

a. Tindakan Berupa Observasi

Hal-hal yang perlu diobservasi dari lansia tergantung dengan masalah keperawatan yang dialami. Contohnya, pada masalah resiko jatuh, implementasi atau Tindakan keperawatan yang dilakukan dalam bentuk tindakan observasi adalah identifikasi faktor resiko jatuh, identifikasi faktor

lingkungan tempat tinggal, monitor kemampuan berpindah dari tempat satu ke tempat satunya, dan hitung nilai resiko jatuh. Pada masalah keperawatan ansietas tindakan observasi yang dilakukan pada lansia adalah identifikasi saat saat apa tingkat ansietas berubah, identifikasi kemampuan mengambil keputusan, dan monitor tanda-tanda ansietas. Pada masalah keperawatan berduka, tindakan keperawatannya adalah identifikasi kehilangan yang dihadapi, identifikasi proses berduka yang dialami, identifikasi sifat keterikatan pada sesuatu yang hilang dan identifikasi reaksi awal dari kehilangan. Pada masalah gangguan pola tidur, implementasi yang bersifat observasi adalah identifikasi pola aktivitas tidur, identifikasi faktor pengganggu tidur baik itu fisik maupun psikologis, identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur, dan identifikasi obat tidur yang biasa dikonsumsi. Pada masing masing masalah keperawatan berbeda pada Tindakan yang bersifat observasinya. Dan ini bisa di lihat lebih lengkap pada buku SIKI. (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017)

b. Tindakan Berupa Tindakan Mandiri Keperawatan

Tindakan keperawatan yang bersifat terapeutik yang diberikan pada lansia pada dasarnya sama dengan yang diberikan pada kelompok usia lainnya, tetapi tindakan keperawatan yang diberikan tergantung pada masalah yang dihadapi dan tetap memperhatikan kondisi lansia. Contohnya, pada masalah keperawatan gangguan pola tidur, Tindakan yang bersifat terapeutik atau Tindakan mandiri oleh perawat adalah memodifikasi lingkungan mulai dari pencahayaannya, kebisingannya, suhu, matras serta tempat tidurnya, Tindakan lainnya adalah Menyusun jadwal agar tidur siang tidak terlalu lama, melakukan terapi pijatan, memberikan pilihan posisi yang nyaman dan melakukan terapi akupresure. Pada masalah lansia dengan masalah berduka, Tindakan terapeutik yang diberikan adalah, perawat menunjukkan sikap empatinya, memberikan kesempatan mengungkapkan perasaanyang dialami, meminta keluarga memberikan dukungan pada lansia akan perasaan kehilangannya, memfasilitasi kebiasaan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi suasana berduka, memberikan kesempatan untuk mengekspresikan perasaan, dan mengajak diskusi tentang strategi koping.

Contoh contoh Tindakan yang sesuai dengan masalah ada di buku SIKI. Tindakan keperawatan lansia yang bersifat terapeutik dapat diberikan secara mandiri oleh perawat kepada lansia dengan mempertimbangkan masalah keperawatan yang dialami lansia dan kemampuan lansia dan melihat perencanaan yang telah disusun dan tinggal mengaplikasikan rencana tersebut.

c. Tindakan Berupa Edukasi Kesehatan

Berbicara tentang tindakan keperawatan yang dapat dilakukan lansia yang bersifat edukatif harus memperhatikan tingkat kemampuan kognitif lansia khususnya memori, selain itu harus juga mempertimbangkan metode penyuluhan yang tepat untuk lansia. Tindakan yang bersifat edukasi, materi yang diberikan juga sesuai dengan kebutuhan lansia dan masalah keperawatan yang terjadi pada lansia. Alangkah lebih baiknya tindakan edukasi kesehatan ada anggota lain dari lansia yang mengikuti kegiatan edukasi kesehatan tersebut atau media seperti leaflead atau poster bisa diberikan pada lansia untuk dapat di baca sebagai sarana pengingat. Leaflead atau poster harus mengikuti kaidah yang baik dalam penyusunannya.

d. Tindakan Berupa Kolaboratif

Beberapa masalah keperawatan yang terjadi memerlukan Tindakan keperawatan yang bersifat kolaboratif. Perawat bisa berkolaborasi dengan tim kesehatan lain dalam mengatasi masalah keperawatan klien seperti dengan dokter, pakar gizi, psikolog, fisioterapi dan yang lainnya. Hal ini untuk mendukung terselesaikannya masalah keperawatan lansia. Perawat menjalankan perannya sebagai manajer kasus untuk lansia yang dirawatnya.

3. Prinsip Tindakan Keperawatan Pada Lansia

Prinsip dalam memberikan tindakan keperawatan pada lansia salah satunya harus melakukan pendekatan. Pendekatan disini ada 4 yaitu pendekatan fisik, pendekatan psikis, pendekatan spiritual dan pendekatan sosial(Aryani, 2021). Tindakan keperawatan bersifat mengakomodir kebutuhan kebutuhan lansia dan perawatan lansia bersifat khusus. Perawat dalam memberikan perawatan pada lansia harus menerapkan prinsip prinsip seperti memunculkan sikap empati atau ikut merasakan apa yang dirasakan tapi tetap harus membatasi tidak larut dalam perasaan yang sama dengan lansia, Tindakan yang diberikan tidak merugikan lansia seperti Tindakan yang diberikan tidak menambah penderitaan, memberikan hak otonomi lansia atau menghargai keputusan yang lansia ambil akan dirinya sendiri, dalam perawatan secara umum juga perawat lansia berbuat adil dalam memberikan Tindakan pada semua lansia yang dirawatnya, dan yang terakhir adalah prinsip kesungguhan hati dalam merawat klien karena dalam kesungguhan hati akan ada rasa kasih sayang dan keikhlasan dalam melakukan tindakan keperawatan.

Hal lain yang menjadi prinsip pelayanan *geriatric* adalah dalam merawat lansia harus dengan prinsip perawatan yang diberikan adalah *holistic* atau perawatan menyeluruh baik fisik, mental, sosial, ekonomi dan spiritual dari lansia(S. E. Meiner, 2019). Pada dasarnya secara prinsip perawatan kita harus

memenuhi semua kebutuhan dari lansia dari beberapa aspek.(Indrayanti, 2024)

B. Terapi kognitif pada lansia

Terapi kognitif untuk lansia

1. Pengertian

Terapi kognitif merupakan salah satu terapi yang dapat diterapkan pada lansia yang bertujuan untuk memperlambat proses degeneratif dan membantu keberfungsian sosial. Terapi kognitif merupakan salah satu terapi yang mana menggunakan pendekatan yang terstruktur, aktif, direktif dan berjangka waktu singkat yang bertujuan untuk menghadapi hambatan dalam kepribadian seperti ansietas atau depresi(Arysusilawati & dkk, 2017). Terapi kognitif merupakan terapi individu yang dapat diajarkan dan dilatih dengan tujuan mengontrol distorsi pikiran dengan benar dan tepat mempertimbangkan faktor dalam berkembangnya dan menetapkan gangguan mood (Townsend, 2010). Terapi kognitif merupakan terapi yang menjelaskan bahwa bukan suatu peristiwa yang menyebabkan kecemasan dan tanggapan maladaptif melainkan harapan Masyarakat, penilaian dan interpretasi dari peristiwa, sugesti bahwa perilaku maladaptif dapat diubah oleh berhubungan langsung dengan pikiran dan keyakinan orang(Stuart, 2016). Terapi kognitif adalah salah satu terapi jangka pendek yang mana prosesnya terstruktur, aktif, direktif dan dengan waktu singkat yang mana dapat digunakan untuk menghadapi berbagai masalah kepribadian seperti depresi dan kecemasan.

2. Macam-macam terapi kognitif

Terapi kognitif dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan teknik yang digunakan. Dibawah ini macam teknik yang dilakukan dalam terapi kognitif(Yosep & Sutini, 2016), yaitu sebagai berikut:

a. Teknik Restrukturisasi

Teknik ini memiliki tujuan akhirnya adalah memodifikasi dari cara penilaian sebelumnya tentang berbagai hal, jenis pemikiran dan penilainnya dari sudut yang berbeda yang lebih baik. Berikan pemahaman bahwa hidup kita ini sangat tergantung dengan cara kita menafsirkan sesuatu, karena hidup itu akan tunduk pada penilaian subjektif kita, maka mari kita modifikasi pemikiran yang selama ini di miliki. Teknik ini diawali dengan identifikasi pemikiran yang konkret, berlanjut identifikasi keyakinan, menerjemahkan pemikiran sebelumnya, membenarkan restrukturisasi kognitif, menanyakan pertanyaan akan kognisi maladaptif, pertanyaan perilaku kognisi maladaptif, mempertanyakan keyakinan dan asumsi, dan Tingkat kepercayaan pada alternatif yang rasional. Bados, A., García, E. (2010). Teknik restrukturisasi kognitif. .Departemen kepribadian, evaluasi dan perawatan psikologis. Fakultas

Psikologi, Universitas Barcelona. Teknik restrukturisasi merupakan teknik yang dimulai dengan cara membuka atau memperluas kesadaran dari diri dan berlanjut dengan mengamati perasaan dan pemikiran yang muncul.

b. Teknik Penemuan Fakta Fakta

Teknik pengumpulan informasi dengan melakukan pertemuan dan melakukan wawancara atau ngan yang lainnya. Perawat memfasilitasi kliennya agar melatih menuangkan apa yang dipikirkan dengan konkrit yang ditulis, hal ini untuk menudahkan perawat melakukan analisis Bersama klien.

c. Teknik Penentuan Alternatif

Disini perawat meminta kliennya menuliskan seluruh masalah yang dirasakan, setelah semua masalah tertuang dalam tulisan, perawat selanjutnya berdiskusi dengan klien terkait pengurutan dari masalah dari yang ringan hingga yang berat, jika sudah tersusun satu persatu dicari penyelesaiannya atau alternatif penyelesaiannya.

d. *Dekatastropik*

Perawat menolong klien dengan cara membantu melakukan evaluasi dari situasi yang dihadapi kliennya, seperti saat klien memandang situasi permasalahan yang dihadapi secara berlebihan.

e. *Reframing*

Tehink ini merupakan saat perawat menentukan strategi merubah persepsi klien terhadap baik itu perilaku maupun situasi.

f. *Thought Stopping*

Teknik Dimana klien diminta stop memikirkan masalahnya atau abaikan dulu. Karena kadang permasalahan semakin dipikir semakin menjadi berat. Hal yang dapat dilakukan klien adalah memejamkan mata membayangkan saat ini mendengar bel yang terus berbunyi selanjutnya bayangkan bel itu tiba tiba berhenti dan suasana jadi sepi dan tenang. Atau bisa juga dengan membuat klien bercerita tentang permasalahannya dan ditengah Tengah cerita tiba tiba perawat meminta berhenti bercerita. Dan ini bisa diterapkan pada kondisi keseharian.

g. Learning New Behavior with Modelling

Klien dibantu dalam memecahkan masalahnya, tapi untuk selanjutnya klien diminta berlatih memecahkan sendiri masalahnya. Tapi sebelumnya klien diajak melakukan observasi pada seseorang yang berhasil memecahkan masalah.

h. Membentuk pola

Kata lainnya adalah teknik shaping yang mana klien akan mendapatkan reinforcement dari keberhasilan memecahkan masalahnya.

i. *Token economy*

Hal ini hampir sama dengan membentuk pola yang mana klien akan mendapatkan reinforcement positif atas upaya yang konsisten dari klien.

j. *Role Play*

Perawat memberikan kesempatan pada klien untuk belajar menganalisa perilakunya yang selama ini dilakukan baik itu benar maupun salah yang coba dipraktikan dalam sebuah sandiwara atau dimainkan tapi dengan cara klien sebagai pengevaluasi dan peran klien dilakukan oleh orang lain.

k. *Social Skill Training*

Teknik ini membuktikan bahwa keterampilan didapatkan dari proses belajar. Sehingga keterampilan menyelesaikan masalah akan baik jika terus belajar menyelesaikan masalah tersebut

l. *Aversion Therapy*

Tahap ini memiliki tujuan untuk menghentikan kebiasaan buruk yang selama ini dilakukan oleh klien dengan cara mengaversikan kegiatan atau perilaku buruk akan situasi yang biasa dilakukan tersebut menjadi sesuatu yang tidak klien sukai atau benci.

m. *Contingency Contracting*

Tahap ini perawat membuat perjanjian yang dibuat dengan klien yang didalamnya mengandung reward and punishment dari perilaku klien setelah kognitif terapi di jalankan.

Teknik teknik dalam terapi kognitif sangat banyak dan pengetahuan tentang teknik teknik diatas sangat diperlukan pada saat perawat memberikan terapi kognitif pada lansia yang nantinya agar hasilnya lebih optimal. Itupun perawat masih harus mengkombinasikan teknik diatas dengan kemampuan lain dari perawat seperti teknik komter, milieu therapy dan counseling.

3. Manfaat Terapi Kognitif

Manfaat dari terapi kognitif sangat banyak sebagai mekanisme koping. Ditinjau dari perseptif kognitif, klien yang diberikan Latihan untuk mengenal dan menghilangkan pikiran, persepsi dan harapan yang negative akan memiliki dimensi dan emosi yang lain pada korteks serebrinya. Dengan terapi kognitif maka akan membantu klien membuat persepsi positif dari pikiran yang awalnya muncul bersifat negatif karena sudah adanya koping yang positif. Dengan Proses ini maka hal yang didapatkan adalah penurunan tingkat depresi. Gangguan depresi pada lansia disebabkan karena lansia cukup banyak mengalami berbagai peristiwa kehidupan yang tidak menyenangkan atau yang cukup berat sehingga terjadinya gangguan depresi sebagai respons perilaku terhadap berbagai stressor kehidupan yang dialami(Maramis, 2014). Terapi kognitif akan membantu orang

yang mengalami depresi mengenali masalah kehidupan yang buruk dan juga membantu untuk mengembangkan tujuan hidup yang positif dan mengkaji kepribadian yang lebih positif (Albrecht, 2003). Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa terapi kognitif efektif dalam menurunkan tingkat depresi pada lansia, sehingga kita bisa menerapkan terapi kognitif sebagai salah satu tindakan keperawatan pada klien lansia kita yang mengalami depresi pada tingkat ringan hingga sedang. Untuk mengetahui tingkat depresi dari klien lansia, kita bisa menggunakan kuesioner geriatri depression scale (GDS).

Manfaat lain dari pemberian tindakan keperawatan terapi kognitif adalah :

- a. Membantu klien memperkuat persepsi yang lebih akurat melalui peningkatan kemampuan klien dalam mengidentifikasi, menganalisis dan menentang kognisi yang bersifat negative sehingga mengatasi depresi yang dialami.
- b. Melibatkan klien dalam perawatan dirinya secara langsung
- c. Mengembangkan pola pikir yang rasional
- d. Memfokuskan pada diri
- e. Mencegah kekambuhan depresi
- f. Merubah pola pikir lebih positif
- g. Merestrukturisasi distorsi kognitif
- h. Mengatasi fobia
- i. Memandang diri sebagai individu yang kuat

4. Fase dalam Terapi Kognitif

Langkah dalam melakukan terapi kognitif ada 16 sesi dan dari 16 langkah atau sesi tersebut dikelompokkan menjadi 3 fase yaitu fase awal, fase pertengahan, dan fase akhir. Fase awal terdiri dari 4 langkah, fase pertengahan terdiri dari 8 langkah, dan fase akhir terdiri dari 4 tahapan. Pada fase awal yang dilakukan adalah membentuk hubungan terapeutik dengan klien lanjut mengajarkan klien tentang bentuk kognitif yang salah dan pengaruhnya terhadap emosi dan fisik, dan selanjutnya menentukan tujuan terapi serta mengajarkan klien untuk mengevaluasi pikiran-pikiran yang otomatis. Setelah tahap awal selesai maka lanjut pada fase pertengahan.

Pada fase pertengahan hal yang dilakukan adalah mengubah secara berangsur-angsur kepercayaan yang salah, setelah itu membantu klien mengenal akar kepercayaan diri dengan cara meminta klien mempraktikkan keterampilan beresponnya terhadap hal-hal yang menimbulkan permasalahan, depresi dan selanjutnya memodifikasinya. Setelah fase pertengahan selesai maka berlanjut pada fase akhir. Pada fase akhir hal yang dilakukan adalah menyiapkan klien untuk fase perpisahan atau terminasi dan memprediksi situasi yang beresiko tinggi yang relevan untuk terjadinya kekambuhan, selanjutnya mengonsolidasi

pembelajaran melalui tugas tugas terapi sendiri.

5. Strategi Pendekatan Terapi kognitif

Pada terapi kognitif ada strategi pendekatan yang dapat digunakan yaitu ada 4. Dibawah ini 4 strategi pendekatan pada terapi kognitif, yaitu:

- a. Menghilangkan pikiran otomatis
- b. Menguji pikiran pikiran otomatis
- c. Mengidentifikasi asumsi maladaptive
- d. Menguji validitas asumsi maladaptive

6. Indikasi Dilakukan Terapi Kognitif

Terapi kognitif dapat dilakukan pada klien dengan atau memiliki suatu kondisi. Terapi kognitif dinilai efektif mengatasi beberapa masalah psikiatri umum seperti:

- a. Depresi

Terapi kognitif untuk pemberian terapi kognitif hanya bisa pada depresi Tingkat ringan dan sedang, dan depresi dengan Tingkat berat tidak bisa menggunakannya. Kita ketahui bahwa salah satu masalah kesehatan jiwa yang sering terjadi pada lansia adalah depresi.

- b. Gangguan panik atau gangguan kecemasan

Pada lansia Tingkat kejadian akan masalah kesehatan mental seperti kecemasan jumlahnya sangat tinggi.

- c. Stress emosional
- d. Gangguan obsesif kompulsif
- e. Gangguan fobia
- f. Gangguan stress pasca trauma
- g. Gangguan makan
- h. Gangguan mood
- i. Gangguan psikoseksual
- j. Mengurangi kemungkinan kekambuhan

C. Terapi aktivitas untuk lansia

Terapi aktivitas untuk lansia dapat berupa terapi aktivitas individu dan terapi aktivitas secara kelompok, dibawah ini akan dijelaskan tentang terapi aktivitas individu dan terapi aktivitas kelompok untuk lansia.

1. Pengertian Terapi Aktivitas

Terapi aktivitas kelompok (TAK) merupakan terapi yang berupa kegiatan yang diberikan pada sekelompok klien sehingga seluruh anggota kelompok akan terjadi peningkatan kualitas hidup dan respon sosialnya. Terapi aktivitas kelompok juga merupakan sebuah terapi yang berfungsi meningkatkan fungsi kognitif lansia. TAK merupakan terapi yang diberikan pada sebuah kelompok oleh

seorang terapis. TAK adalah terapi modalitas keperawatan untuk melatih perilaku baru yang adaptif dan meningkatkan fungsi kognitif yang dilakukan pada kelompok dengan masalah yang sama dengan mengaktifkan dinamika interaksi yang saling tergantung dan saling membutuhkan (Keliat, 2014).

2. Tujuan Terapi Aktivitas Kelompok

Tujuan umum dari dilakukannya terapi aktivitas kelompok adalah meningkatkan atau mengembangkan kemampuan individu dalam stimulasi persepsi, orientasi realistis, stimulasi sensori dan sosialisasi. Tujuan khusus dari terapi aktivitas kelompok ini bagi lansia adalah meningkatkan eksistensi lansia dalam kelompok, membantu merubah perilaku maladaptive menjadi adaptif, berbagi pengalaman salah satunya dalam penyelesaian masalah (Samsuni et al., 2024).

3. Jenis Terapi Aktivitas Kelompok pada Lansia

Dibawah ini beberapa terapi aktivitas kelompok yang dapat diterapkan pada kelompok lansia yaitu:

a. TAK Stimulasi Sensori

TAK stimulasi sensori dapat dilakukan dengan mendengarkan music.

b. TAK Stimulasi Persepsi

Klien dilatih cara mempersepsikan stimulus setelah membaca, memontoh acara televisi dan lainnya

c. TAK Orientasi Realitas

Melatih kemampuan akan orientasi orang, tempat dan waktu.

d. TAK Sosialisasi

Mengembalikan kemampuan bersosialisasi dengan orang lain dan dilakukan secara bertahap

e. Terapi Berkebun

Terapi berkebun memiliki tujuan melatih kesabaran mulai dari menunggu tumbuh, menunggu berbunga dan berbuah serta menunggu untuk menikmati hasil yang di tanam. Kegiatan berkebun bisa dilakukan secara kelompok maupun secara individu. terapi berkebun merupakan terapi aktivitas dengan memanfaatkan waktu luang lansia.

f. Terapi dengan Binatang

Terapi dengan binatang juga merupakan terapi aktivitas yang dapat dilakukan secara personal maupun berkelompok. Terapi ini dapat mencegah masalah gangguan jiwa yang rentan terjadi pada lansia. Lansia dapat memelihara Binatang untuk meningkatkan kasih sayang, mengisi kesepian serta masih dibutuhkan. Lansia bisa memelihara kucing atau ikan, atau ayam dan sebagainya. Bahkan jika yang dipelihara adalah ternak yang bisa

dikonsumsi, akan ada kebanggaan jika ada keluarga datang dan itu jadi suguhannya. Selain itu hewan peliharaan terakang serasa diajak berbicara.

g. Terapi Okupasi

Terapi okupasi merupakan terapi aktivitas yang dapat dilakukan secara kelompok maupun individu. Terapi okupasi adalah terapi aktivitas memanfaatkan waktu luang untuk membuat karya yang nanti dapat dimanfaatkan, seperti membuat kerajinan tangan. Bahkan jika di koordinasi hasil karyanya dapat diperjualbelikan seperti yang ada di pasti werdha. Tujuan terapi ini adalah pemanfaatan waktu luang lansia dan meningkatkan produktifitas serta tidak menutup kemungkinan menambah penghasilan.

h. Terapi kognitif

Terapi kognitif bisa dilakukan secara kelompok dan ini bertujuan untuk mencegah penurunan daya ingat dengan melakukan kegiatan kelompok berupa lomba cerdas cermat, bermain tebak tebakkan, menyusun puzzle dan mengisi teka teki silang. Untuk Menyusun puzzle dan teta teki silang dapat juga dilakukan sendiri dan ini bagian dari terapi aktivitas individu.(Robiyanto et al., 2019)

i. Live Review Therapy

TAK jenis *live review therapy* ini adalah secara kelompok yang didalamnya nantinya masing masing menceritakan pengalaman hidup, hal hal yang lucu yang dialami sepanjang hidupnya bahkan bisa bercerita masa mudanya, dan ini akan meningkatkan harga diri dan gairah hidupnya.

j. Rekreasi

Rekreasi merupakan TAK yang baik untuk lansia karena akan meningkatkan sosialisasi, meningkatkan gairah hidup atau semangat hidup, mengurangi rasa bosan. TAK rekreasi dapat mengatasi stress dan depresi. Rekreasi akan seru jika dilakukan Bersama sama. Rekresi di sini tidak harus pergi ke tempat wisata saja tetapi bisa berupa berkunjung ke rumah anak cucu, mengunjungi saudara, ikut kegiatan organisasi, bertemu teman seumuran dan sebagainya.

k. Terapi keagamaan

Terapi keagamaan ini merupakan terapi aktivitas yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Pada lansia menunjukkan peningkatan pada segi kebutuhan spiritualitasnya. Lansia dapat melakukan terapi keagamaan secara individu dengan melakukan ibadah dan berzikir (bagi muslim) serta membaca kitab suci, ataupun terapi keagamaan berkelompok seperti ziarah, mendatangi kajian, ibadah Bersama. Terapi keagamaan akan meningkatkan kenyamanan, perasaan tidak sendirian terkhususnya pada

kondisi menghadapi menjelang kematian.

I. Terapi keluarga

Terapi keluarga merupakan salah satu bentuk terapi aktivitas kelompok yang melibatkan anggota keluarga. Keluarga merupakan sumber daya yang dapat berperan sebagai support sistem bagi anggota keluarga lainnya. Proses terapi keluarga ada 3 fase yaitu fase orientasi, fase kerja dan fase terminasi. Terapi keluarga diawali dengan mengumpulkan semua anggota keluarga yang selanjutnya dilakukan pengembangan hubungan saling percaya, setelahnya bersama sama mengidentifikasi isu yang ada serta menetapkan tujuan. Setelahnya memasuki fase kedua yaitu fase kerja yang mana kegiatannya adalah merubah pola interaksi yang blm sesuai seperti Bagaimana berinteraksi, kemudian aturan dalam keluarga serta Batasan dalam keluarga. Dan pada fase terminasi seluruh anggota keluarga flashback Kembali proses yang telah dijalani di fase kerja yang dapat mencapai tujuan.

4. Prinsip Terapi Aktivitas Kelompok

Prinsip terapi aktivitas kelompok adalah homogenitas dari kelompok itu sendiri. Seperti tiap individu memiliki masalah keperawatan yang sama atau gejala yang sama, kategori individunya sama, alangkah lebih baiknya jenis kelaminnya pun sama, kelompok umur sama serta jumlah anggota tidak banyak atau terlalu sedikit karena ini terkait dengan efektif dari TAK yang dilakukan.

D. Bantuan Aktivitas Sehari Hari (*Activity Daily Living/ADL*) pada kelompok lansia

Bantuan aktivitas sehari hari (activity daily living/ADL) pada kelompok lansia

1. Pengertian *Activity Daily Living*

ADL adalah aktivitas perawatan pada diri yang harus dilakukan setiap hari dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup dan ini bagian dari tuntutan hidup (burner 2002), ADL adalah aktivitas yang dilakukan normalnya biasanya sepanjang hari yang terdiri dari berpindah atau ambulasi, makan, berpakaian, mandi, menyikat gigi, berhias dengan tujuan memenuhi perannya sebagai pribadi dan bagian dari Masyarakat dan ini bersifat akut, kronis, temporer, permanen atau rehabilitatif(Potter, A & Perry, 2015).

2. Macam macam ADL

ADL terdiri ADL Dasar, ADL instrumental, ADL Vokasional dan ADL non vokasional. Tetapi yang menjadi topik kali ini ADL dasar yang terdiri dari berpakaian, makan minum, toileting, mandi, berhias dan mobilitas.

3. Faktor yang mempengaruhi ADL

Beberapa faktor yang mempengaruhi ADL adalah umur dan status perkembangan, kesehatan fisiologis, fungsi kognitif, fungsi psikososial, Tingkat

stress, ritme biologi, dan status mental.hardywinoto 2007

4. Teori keperawatan terkait pemenuhan ADL

Teori perawatan diri oleh Orem terdiri dari 3 yaitu *selfcare*, *deficit selfcare*, dan *nursing system*. Pada pandangan teori system, perawat memberikan identifikasi pada system pelayanan yaitu sistem bantuan secara penuh, sistem bantuan Sebagian dan sistem suportif dan edukasi. Sistem bantuan secara penuh diberikan karena klien tidak mampu dalam memenuhi tindakan perawatan dasar secara mandiri dan memerlukan bantuan dalam pemenuhan dan pergerakannya. Hal ini bisa terjadi pada klien koma, klien fraktur vertebra, klien stroke berat maupun pada klien retardasi mental. Pada bantuan Sebagian akan diberikan pada klien yang masih ada kemampuan melakukan perawatan. Suportif dan edukatif diberikan pada klien berupa pengajaran tentang prosedur Tindakan perawatan diri. Pada lansia, dalam menentukan Tingkat bantuan yang akan diberikan dalam pemenuhan ADL nya adalah dengan penilaian status fungsional lansia.

5. Penilaian Status Fungsional Lansia

Penilaian status fungsional merupakan cara pengukuran Tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari hari yang digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan dan keterbatasan dalam melakukan aktivitas harian dan hasil analisisnya untuk menentukan pemilihan tindakan yang tepat dalam perawatan. Ada 2 cara melakukan penilaian fungsional pada lansia yaitu Katz Indeks dan Bartel Indeks.

Katz indeks lebih tepat digunakan pada lansia dengan kondisi kesehatan memiliki penyakit kronis. Katz indeks menilai kemampuan klien melakukan 6 fungsi ADL yaitu mandi, berpakaian, toileting, berpindah, kontinen dan makan. Tiap kemampuan akan dinilai mandiri jika klien mampu melakukan tanpa pengawasan, pengarahan atau bantuan aktif. Dengan Katz indeks dikategorikan dengan A, B, C, D, E, F dan G.

Bartel indeks lebih mengukur secara umum baik mandiri maupun ketergantungan klien. Pada Bartel indeks tingkat fungsional klien dibagi menjadi 5 yaitu mandiri, ketergantungan ringan, ketergantungan sedang, ketergantungan berat dan ketergantungan. Penilaian ini tergantung dari skor atas 10 pertanyaan tentang kegiatan sehari hari seperti makan, aktivitas toilet, berpindah, kebersihan diri, mandi, berjalan, naik turun tangga, berpakaian, mengontrol devesiasi dan mengontrol berkemih.

Bentuk bantuan perawatan diri yang kita berikan sangat tergantung pada kondisi klien berdasarkan penilaian Tingkat kemandirian. Pada lansia mandiri harus kita upayakan tetap mandiri dengan mendorong lansia melakukan tindakan mempertahankan kemandirian ADL dengan Latihan Latihan.

6. Manfaat Latihan Mempertahankan ADL pada lansia

Manfaat dari Latihan fisik untuk mempertahankan kemandirian ada 3 kelompok manfaat yaitu manfaat fisiologis, manfaat psikologis, manfaat sosial. Adapun manfaat fisiologisnya yaitu: mengatur kadar gula darah, merangsang adrenal dan non adrenal, peningkatan kualitas dan kuantitas tidur, daya tahan kardiovaskuler, kekuatan otot rangka, kelenturan, keseimbangan, kelincahan Gerak. Manfaat psikologis dari latihan mempertahankan kemampuan ADL adalah memberi perasaan santai, mengurangi ketegangan dan cemas, meningkatkan perasaan senang, kesehatan jasmani dan Rohani, kesehatan jiwa, fungsi kognitif, penampilan dan fungsi motorik, dan keterampilan. Manfaat sosial berupa pemberdayaan lansia, peningkatan integritas, keterpaduan, kesetiakawanan sosial, jaringan Kerjasama, pertahanan peranan dan kegiatan antargenerasi.

7. Langkah Langkah mempertahankan ADL

Langkah mempertahankan kemampuan pemenuhan ADL melalui kemampuan kemandirian diri yang dapat dilatih dengan gerakan:

- a. Latihan kepala dan leher (lihat ke atas kemudian menunduk sampai dagu menempel di dada, putar kepala dengan melihat bahu kanan lalu ke bahu kiri, miringkan kepala ke bahu kanan lalu ke bahu kiri)
- b. Latihan bahu dan lengan (angkat kedua bahu mendekati telinga kemudian turunkan Kembali secara perlahan, tepukkan kedua tangan, lutuskan sejajar bahu lalu angkat diatas kepala. Satu tangan menyentuh bagian belakang kepala dan leher kemudian raih punggung sejauh mungkin, lakukan bergantian tangan satunya. Letakkan tangan di punggung lalu raih ke atas dan gantian tangan satunya)
- c. Latihan tangan (letakkan telapak tangan dimeja lalu lebarkan jari jari dan tekankan pada meja, baliklah telapak tangan selanjutnya ibu jari menyentuh kelingking, ibu jari menyentuh jari manis, selanjutnya ibu jari menyentuh jari Tengah dan yang terakhir ibu jari menyentuh jari telunjuk. Selanjutnya kepalkan tangan sekualnya lalu buka dan luruskan secara perlahan)
- d. Latihan punggung (berdiri tegak, tangan disamping badan, bengkokkan badan ke satu sisi kemudian ke sisi tubuh lainnya, lalu tangan di pinggang selanjutnya putar tubuh melihat bahu kanan dan kiri, tepukkan kedua tangan di belakang dan kedua bahu diregangkan ke belakang)
- e. Latihan paha (lipat satu lutut ke arah dada, dan kaki lain tetap lurus dan tahan beberapa saat, gantian lakukan pada kaki satunya. Luruskan kaki, lakukan penekanan pada kedua lutut dengan kedua tangan sehingga bagian belakang lutut menempel pada alas, Tarik telapak kaki ke arah badan lalu regangkan

Kembali, tekuk dan regangkan jari kaki tanpa menekuk lutut, putar telapak kaki ke arah dalam, lanjut berdiri angkat tumit dan putarkan

- f. Latihan pernapasan (duduk di kursi, punggung bersandar dan bahu rileks, letakkan kedua telapak tangan pada tulang rusuk, selanjutnya Tarik nafas lewat hidung secara perlahan dan jika sudah terasa dada mengembang, keluarkan nafas perlahan lahan, hal ini hampir sama pada Tindakan nafas dalam)
- g. Latihan muka (kerutkan dahi dengan mendekatkan antar alis, tutup mata kuat kuat dan buka Kembali dengan lebar, dan kembangkan pipi keluar lalu isap ke dalam), beberapa Gerakan ini sama dengan Gerakan pada terapi otot progresif bagian muka)

E. Senam Lansia

Senam lansia dan macam-macamnya

1. Senam Lansia

a. Pengertian.

Senam lansia merupakan salah satu terapi yang berupa aktivitas olahraga yang dilakukan oleh individu yang telah memasuki usia lanjut bahkan mulai dari kelompok usia pra lansia. Senam lansia merupakan aktivitas berupa rangkaian Gerakan, dimana gerakannya teratur, terarah serta terencana. Senam lansia merupakan senam yang dalam gerakannya mudah, ringan yang mana tidak memberatkan lansia. Senam lansia merupakan salah satu tindakan keperawatan pada lansia yang dapat dilakukan secara mandiri baik individu maupun kelompok dan dengan instruktur maupun tanpa instruktur. Senam lansia adalah sebuah Latihan fisik berupa Gerakan yang dianjurkan dilakukan lansia dengan tujuan meningkatkan kemampuan fungsional dengan Gerakan yang teratur, terarah dan terencana demi menyesuaikan perubahan tubuh pada lansia dengan salah satunya dengan menurunkan kecepatan dari Gerakan.

b. Tujuan

Tujuan dari senam lansia tergantung dari jenis senam lansia yang dilakukan. Senam lansia banyak macam atau jenisnya, sesuai dengan tujuan dan manfaat dari masing masing senam tersebut. Senam lansia secara umum memiliki tujuan atau manfaat: meningkatkan kerja jantung, memperlancar peredaran darah, membantu menangkat radikal bebas sehingga lansia lebih sehat dan bugar, selain itu juga meningkatkan mood sehingga lansia terhindar dari stress. Pada tujuan khusus senam dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur, mengontrol kadar gula darah, membangun kekuatan otot dan

tulang, meningkatkan kelenturan tubuh, meningkatkan energi, mengurangi ketegangan dan kecemasan, meningkatkan kemampuan kognitif, mencegah depresi dan meningkatkan hubungan sosial.

Dibawah ini beberapa jenis senam untuk lansia dan penjelasannya, yaitu:

1) Senam kebugaran lansia

Sesuai dengan namanya senam ini memiliki manfaat meningkatkan kebugaran lansia. Gerakan Gerakan pada senam kebugaran berfungsi meregangkan otot-otot kepala. Gerakan senam kebugaran lansia diantaranya adalah menganggukan kepala keatas dan kebawah dengan hitungan 1 sampai 8 selama 5 kali dan dilanjutkan dengan Gerakan menengok kepala ke kiri dan ke kanan dengan hitungan 1 sampai 8 sebanyak 5 kali juga.

2) Senam Hipertensi

Senam ini untuk menurunkan tekanan darah atau menstabilkan tekanan darah (Habibi, 2020). Senam hipertensi dilakukan untuk menyehatkan aliran darah dan meningkatkan kinerja jantung. Salah satu gerakan senam hipertensi adalah Gerakan seperti tepuk tangan, lengan lurus di sejajar dada, dengan hitungan 1 sampai 8 dan dilakukan sebanyak 5 kali.

3) Senam diabetes

Senam diabetes dilakukan dengan tujuan memperlancar aliran darah dan merangsang saraf-saraf pada bagian perifer tubuh serta mengendalikan gula darah. Salah satu gerakannya adalah seperti tepuk tangan, tangan sejajar dada ke depan, tapi tiap tepukan salah satu jari ditekuk, dan hitungan 1 sampai 8 di ulang banyak 5 kali

4) Senam osteoporosis

Senam osteoporosis digunakan untuk mencegah pengeroposan tulang dengan cara memperkuat kekuatan otot dan tulang. Gerakan Gerakan pada senam osteoporosis adalah *shoulder lifts, squat, foot stomps, ball sit, hip leg lifts, bicep curl, hamstring curls, standing on one leg*, dan gerakan naik turun tangga

5) Senam otak

Senam otak berfungsi untuk memberikan energi bagi tubuh dan meningkatkan kesegaran mental. Senam otak juga merupakan salah satu terapi kognitif. Terapi senam otak bagi lansia ini dapat membantu menstimulasi fungsi kerja otak, melatih daya ingat serta menumbuhkan rasa bahagia pada saat melakukannya. Senam otak yang dikombinasi dengan relaksasi benson bermanfaat meningkatkan kualitas tidur dan

menurunkan resiko depresi pada lansia (Wulansari et al., 2019)(Wulansari et al., 2018).

Gerakan senam otak terdiri dari gerakan silang tubuh/cross crawl dengan manfaat merasa terbuka untuk mempelajari hal baru, gerakan kedua adalah membuat angka delapan posisi tidur sebanyak 3 kali dengan masing masing tangan dan selanjutnya buat 3 kali lagi dengan kedua tangan, hal ini akan mengurangi kebiasaan sering lupa. Gerakan ketiga yaitu membuat coretan ganda/double doodle, yang bermanfaat merilekskan tangan dan mata, sehingga menulis lebih mudah. Gerakan ke empat yaitu abjad 8, menulis huruf b dan d bersama atau p dan q, hal ini membuat mudah mengungkapkan pikiran saya. Dan gerakan lainnya lagi, yang masing masing gerakan baik untuk lansia(Denninson & Denninson, 2002).

6) Senam rematik

Senam rematik berfungsi merurunkan nyeri atau ketidaknyamanan rematik pada lansia. Gerakan senam rematik: genggam telapak tangan lalu buka, renggangkan jari jari tangan lalu rapatkan kembali, sentuh ibu jari dengan masing masing jari mulai dari telunjuk hingga kelingking, tekuk satu persatu jari dari ibu jari hingga kelingking dan setelah itu buka dimulai dari kelingking hingga ibu jari, tekuk pergelangan tangan ke atas dan ke bawah, buka lengan dengan kedua tangan di depan dada dengan telapak tangan menghadap ke bawah, buka tutup lengan atas bawah, tekuk lengan ke atas samping bahu, angkat ke dua lengan ke atas ke bawah, silangkan kedua tangan putar melewati sumbu tubuh, angkat turunkan bahu, putar bahu ke depan, gerakkan pingang ke samping kanan dan kiri, putar badan ke kanan dan kiri tangan didepan dada, gerakan menutup dada dengan bahu, mencengkeram jari kaki, tekuk pergelangan kaki ke atas dan ke bawah, buka tutup telapak kaki ke kanan ke kiri, putar pergelangan kaki satu persatu (Marsiarni et al., 2023).

7) Senam aerobik ringan

8) Tai Chi

9) Yoga

10) Senam kekuatan

11) Senam keseimbangan

12) Senam air

13) Pilates

14) Jalan santai

c. Syarat Melakukan Senam oleh Lansia

Ada beberapa yang harus diperhatikan oleh lansia maupun pendamping atau instruktur senam lansia pada saat pelaksanaan senam yaitu:(Aurelia, 3023)

- 1) Perhatikan keselamatan
Gerakan, tempat, kecepatan gerakan
- 2) Latihan yang tidak terlalu berat
Gerakan yang dilakukan sederhana, tidak berat, sesuai kemampuan
- 3) Hindarkan perasaan kompetisi
Senam dilakukan dengan santai, menyenangkan, tidak kompetitif.

F. Latihan

Latihan Sub.1

1. Tindakan keperawatan merupakan bagian dari proses keperawatan urutan ke...
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 5
2. Tindakan keperawatan merupakan bentuk aplikasi dari...
 - A. Analisa data
 - B. Intervensi
 - C. Tujuan
 - D. Evaluasi
 - E. Pengkajian

Latihan Sub.2

3. Perawat sedang melakukan terapi kognitif pada seorang lansia dan saat ini sedang pada fase pertengahan, hal yang dilakukan perawat pada fase ini adalah...
 - A. Mengubah secara berangsur angsur kepercayaan yang salah
 - B. Membentuk hubungan terapeutik dengan klien
 - C. Mengajarkan klien tentang bentuk kognitif yang salah
 - D. Menentukan tujuan terapi
 - E. Mengajarkan klien untuk mengevaluasi pikiran yang otomatis
4. Perawat sedang melakukan terapi kognitif dan perawat sedang memberikan pemahaman bahwa hidup kita ini sangat tergantung dengan cara kita menafsirkan sesuatu, karena hidup itu akan tunduk pada penilaian subjektif kita, maka mari kita modifikasi pemikiran yang selama ini di miliki. Teknik yang sedang digunakan perawat adalah Teknik...
 - A. Penentuan alternatif
 - B. Restrukturisasi

- C. Reframing
- D. Membentuk pola
- E. Token economy

Latihan Sub.3

5. Terapi aktivitas kelompok pada lansia dilakukan dengan tujuan umumnya adalah ...
- A. Meningkatkan atau mengembangkan kemampuan individu dalam stimulasi persepsi, orientasi realistis, stimulasi sensori dan sosialisasi
 - B. Meningkatkan eksistensi lansia dalam kelompok
 - C. Membantu merubah perilaku maladaptive menjadi adaptif
 - D. Berbagi pengalaman salah satunya dalam penyelesaian masalah
 - E. Menyenangkan hati

Latihan Sub.4

6. Bantuan activiti daily living pada lansia dilakukan sesuai dengan tingkat kemandirian atau tingkat ketergantungan lansia yang diniklai penawat menggunakan instrument?
- A. Katz Indeks
 - B. Bartel Indeks
 - C. Katz Indeks dan Bartel Indeks
 - D. MMSE
 - E. SPMSQ

Latihan Sub.5

7. Senam lansia diberikan pada lansia dengan mempertimbangkan kemampuan fisik lansia, dan memiliki banyak manfaat, dibawah ini manfaat senam lansia untuk psikologis adalah?
- A. Memperlancar peredaran darah
 - B. Meningkatkan kelenturan tubuh
 - C. Mengurangi ketegangan dan kecemasan dan mencegah depresi
 - D. Meningkatkan kemampuan kognitif
 - E. Meningkatkan hubungan sosial

Kunci Jawaban

- 1. D
- 2. B
- 3. A
- 4. B
- 5. A
- 6. C
- 7. C

G. Rangkuman Materi

Pada bab 5 ini membahas mengenai tindakan keperawatan yang bisa diberikan kepada lansia untuk mengatasi masalah kesehatan yang sering terjadi pada lansia. Sebagai awalan akan sedikit dibahas tentang konsep tindakan keperawatan yang merupakan bagian dari proses keperawatan. Tindakan keperawatan bukan asal melakukan tindakan tetapi hasil analisa dari upaya untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang terjadi pada lansia. Ada beberapa tindakan keperawatan yang dibahas pada bab ini yaitu tentang terapi kognitif pada lansia, terapi aktivitas kelompok pada lansia, bantuan ADL pada lansia dan senam senam yang spesifik dilakukan lansia. Pada masing masing tindakan telah dijelaskan pengertian, manfaat, cara melakukan atau memberikannya, dan dilengkapi dengan evidence hasil penelitian dari masing masing tindakan keperawatan ini.

H. Glosarium

Tindakan Keperawatan: Tindakan yang diberikan kepada klien untuk mengatasi masalah keperawatan dan berdasar rencana keperawatan yang sebelumnya telah disusun.

Proses keperawatan: Proses yang diawali dengan pengkajian untuk memperoleh data yang selanjutnya data dianalisis untuk menegakkan diagnosa, setelah diagnose ditegakkan maka akan disusun mana yang menjadi prioritas masalah. Setelah itu tiap tiap diagnose ditentukan tujuan yang akan di capai. Dengan melihat tujuan yang dicapai maka perlu analisi menentukan rencana Tindakan atau intervensi apa yang akan disusun. Rencana yang telah disusun akan dilakukan atau diujikan dalam bentuk Tindakan keperawatan. Lama tindakan sesuai dengan yang tertuang pada bagian tujuan. Setiap melakukan Tindakan nantinya akan dilakukan evaluasi dari Tindakan tersebut baik itu evaluasi formatif maupun evaluasi sumatif.

I. Daftar Pustaka

- Albrecht. (2003). *Berpikir Positif*. Pustaka Pelajar.
- Aryani, D. (2021). *Teknik pendekatan dalam perawatan lansia*.
- Arysusilawati, L. K. P., & dkk. (2017). *Buku ajar mata kuliah psikoterapi I*. Program studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- Aurelia, A. (3023). *Kebugaran*. detikhealth. <https://health.detik.com/kebugaran/d-6554011/15-gerakan-senam-lansia-agar-tetap-bugar-di-usia-senja>
- Denninson, P. E., & Denninson, G. E. (2002). *brain Gym* (A. Ariobimo Nusantara (ed.)). PT Gramedia Widya sarana Indonesia.

- Habibi, H. (2020). Penerapan Relaksasi Otot Progresif dalam Menurunkan Tekanan Darah pada Keluarga dengan Hipertensi : Literature Review. *Serambi Saintia: Jurnal Sains Dan Aplikasi*, 8(2), 86–93. <https://doi.org/10.32672/jss.v8i2.2421>
- Indrayanti. (2024). *Prinsip pelayanan pada lanjut usia*. <https://repo.stikesbethesda.ac.id/490>
- Keliat, B. A. (2014). *Terapi Aktivitas Kelompok*. Buku Kedokteran EGC.
- Maramis, M. M. (2014). Depresi pada lanjut usia. *Jurnal Widya Medika*, 2(1), 39–50. <http://journal.wima.ac.id/index.php/JWM/article/view/1650>
- Marsiami, A. S., Sari, I. F., Fahrudiana, F., & W, W. D. (2023). Manfaat Senam Rematik pada Lansia yang Mengalami Rheumatoid Arthritis. *Indonesian Journal of Health Development*, 5(1), 1–8. <https://ijhd.upnvj.ac.id/index.php/ijhd/article/view/111/71>
- Potter, A & Perry, A. G. (2015). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, Dan Praktik* (4 Vol 5). EGC. Jakarta.
- Robiyanto, O. I., Sartika, D., & Qodariah, S. (2019). Pengaruh Mindfulness-Based Cognitive Therapy Terhadap Penurunan Kecemasan Sosial Pada Mahasiswa Kedokteran. *SCHEMA (Journal of Psychological Research)*, 5, 1–13.
- S. E. Meiner. (2019). *Gerontologic Nursing*. ELSEVIER.
- Samsuni, S., Susanti, F., Ginting, A. G. N., Herlatini, A. D., Yuniarti, E., Febriana, W., & Polpa, E. (2024). Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) Pada Lansia Dengan Demensia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Cipayung. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Kesehatan Untuk Masyarakat*, 1(4), 123–131. <https://doi.org/10.52643/jppkm.v1i4.3925>
- Stuart, G. . (2016). *Prinsip dan Praktik Keperawatan Jiwa* (Indonesia). Elseiver.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia* (Tim Pokja SDKI DPP PPNI (ed.); 1st ed.). Dewan Pengurus PPNI.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2018). *Standar Luaran Diagnosis Keperawatan Indonesia* (Tim Pokja SDKI DPP PPNI (ed.); 1st ed.). Tim Pokja SDKI DPP PPNI.
- Townsend. (2010). *Diagnosa Keperawatan Psikiatri Rencana Asuhan Di Medikasi psikotropik*. EGC.
- Wulansari, W., Margawati, A., & Hadi W, R. (2018). Effect of Brain Exercise and Benson Relaxation Therapy on Depression Level in the Elderly in the Elderly Social Service Unit. *Belitung Nursing Journal*, 4(2), 211–218. <https://doi.org/10.33546/bnj.361>
- Wulansari, W., Mustain, M., & Ismiriyam, F. V. (2019). Pengaruh Terapi Beapreasi (Kombinasi Senam Otak Dengan Relaksasi Benson) Terhadap Kualitas Tidur Pada Lanjut Usia Dengan Insomnia. *Jurnal Perawat Indonesia*, 3(1), 8. <https://doi.org/10.32584/jpi.v3i1.199>

Yosep, I., & Sutini, T. (2016). *Buku Ajar keperawatan Jiwa*. Refika.

BAB 6

APLIKASI ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA DALAM KONTEKS INDIVIDU

Pendahuluan

Peningkatan harapan hidup dan perkembangan ilmu kesehatan menyebabkan jumlah populasi lansia terus bertambah. Lansia menghadapi berbagai perubahan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang memengaruhi kesehatannya secara keseluruhan. Dalam konteks individu, asuhan keperawatan gerontik berfokus pada pemenuhan kebutuhan spesifik lansia dengan pendekatan yang holistik dan berbasis bukti.

Perawat memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi lansia, baik dalam aspek pencegahan, pemeliharaan, maupun pemulihan kesehatan. Asuhan keperawatan pada lansia harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti perubahan fisiologis, penyakit degeneratif, penurunan fungsi kognitif, serta kebutuhan emosional dan sosial.

Bab ini akan membahas prinsip-prinsip dasar dalam asuhan keperawatan individu lansia, mulai dari proses pengkajian, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi keperawatan. Diharapkan setelah mempelajari bab ini, pembaca dapat memahami konsep dan praktik keperawatan gerontik yang berorientasi pada kebutuhan spesifik setiap individu lansia.

Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep serta keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan yang holistik dan berpusat pada individu lansia sesuai dengan prinsip-prinsip keperawatan gerontik.

Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep keperawatan gerontik dalam konteks individu, termasuk perubahan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pada lansia.
2. Melakukan pengkajian keperawatan pada individu lansia, mencakup riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, status mental, dan kebutuhan sosial.

3. Mengidentifikasi masalah kesehatan umum pada lansia, termasuk penyakit degeneratif, gangguan mobilitas, dan perubahan fungsi kognitif.
4. Menyusun rencana asuhan keperawatan yang sesuai dengan kondisi individu lansia, berdasarkan analisis data pengkajian.
5. Menerapkan intervensi keperawatan yang mendukung kesehatan fisik, psikososial, dan spiritual lansia secara optimal.
6. Mengevaluasi efektivitas asuhan keperawatan, serta menyesuaikan intervensi berdasarkan respon lansia terhadap perawatan yang diberikan.

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan
2. Mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan (klinik dan komunitas) untuk meningkatkan asuhan keperawatan dan keselamatan klien
3. Mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan keselamatan klien

Uraian Materi

Asuhan keperawatan pada lansia dalam konteks individu merujuk pada pendekatan perawatan yang berfokus pada kebutuhan unik setiap lansia, dengan mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini dikenal sebagai *person-centered care* atau perawatan yang berpusat pada individu. Perawat menggunakan proses keperawatan untuk memberikan perawatan yang berpusat pada pasien. Pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi adalah lima langkah yang saling terkait. proses keperawatan adalah pendekatan klinis yang digunakan oleh profesi. Ini adalah metode ilmiah untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan dan penyakit yang mendasari perawatan keperawatan dan membantu mencegah, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Konsep ini mengakui elemen fisik, psikologis, dan sosial yang berbeda dari orang lanjut usia, yang jika diterapkan pada orang dewasa yang lebih tua, sesuai dengan karakter holistik keperawatan geriatric. Lansia merupakan kelompok yang beragam yang memiliki berbagai macam kisah hidup, pengalaman, dan kemampuan serta memiliki kebutuhan yang kompleks dan beraneka ragam. Mereka dipengaruhi dengan cara yang unik oleh efek gabungan dari proses penuaan, proses penyakit, dan lingkungan, yang menantang rasa percaya diri mereka dan memengaruhi persepsi mereka terhadap kualitas hidup mereka.

A. Pengkajian

Tahap awal proses keperawatan, penilaian memegang peranan penting. Penilaian melibatkan pengumpulan data komprehensif tentang status kesehatan lansia, kemampuan fungsional, fungsi kognitif, kesejahteraan psikososial, dan faktor lingkungan. Mengingat kompleksitas penuaan, perawat menggunakan alat penilaian tervalidasi yang khusus untuk populasi geriatri, seperti *Comprehensive Geriatric Assessment* (CGA), untuk memastikan pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan individu (Miller, 2015; Royal College of Physicians Ireland, 2015)

CGA merupakan hal mendasar bagi penilaian, perencanaan, dan intervensi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan dan sosial bagi lansia yang lemah atau berisiko lemah. CGA melibatkan lintas profesi yaitu dokter, perawat, fisioterapis, terapis okupasi, pekerja sosial, dan anggota tim lainnya yang bekerja sama secara erat untuk memastikan penilaian dan respons terpadu terhadap kebutuhan individu lansia. CGA adalah pendekatan penilaian terorganisasi yang dirancang untuk menentukan kondisi medis, kesehatan mental, kapasitas fungsional, dan keadaan sosial orang lanjut usia. Tujuannya adalah untuk

mengembangkan dan menerapkan rencana yang terkoordinasi dan terpadu untuk perawatan, rehabilitasi, dukungan, dan tindak lanjut jangka panjang. CGA didasarkan pada premis bahwa evaluasi menyeluruh terhadap orang lanjut usia yang lemah oleh tim profesional perawatan kesehatan dapat mengidentifikasi berbagai masalah kesehatan yang dapat diobati, yang menghasilkan rencana dan pemberian perawatan yang terkoordinasi yang mengarah pada hasil kesehatan yang lebih baik (Royal College of Physicians Ireland, 2015).

B. Elemen Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)

Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) adalah pendekatan multidisiplin untuk menilai kondisi kesehatan lansia secara menyeluruh. CGA mencakup berbagai aspek yang saling berhubungan untuk menentukan status kesehatan dan fungsional lansia. Elemen CGA dapat dilihat pada gambar berikut 6.1.



Gambar 6.1: Elemen *Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)* ((Royal College of Physicians Ireland, 2015)

Gambar 5.1 menunjukkan elemen-elemen dalam Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) yang mempengaruhi status fungsional lansia. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing elemen (Royal College of Physicians Ireland, 2015):

1. Physical (Fisik)

- a. Pemeriksaan kondisi kesehatan fisik lansia, seperti penyakit kronis, gangguan mobilitas, kekuatan otot, dan keseimbangan.
- b. Pemeriksaan mencakup tekanan darah, fungsi organ, serta kemungkinan adanya nyeri atau gangguan muskuloskeletal.
- c. Mengidentifikasi masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi fungsi sehari-hari, seperti nyeri, gangguan jantung, paru-paru, atau osteoporosis

2. Psychological (Psikologis)

- a. Menilai kesehatan mental, termasuk adanya depresi, kecemasan, atau gangguan kognitif seperti demensia.
- b. Skrining menggunakan skala penilaian depresi geriatri (GDS) dan *Mini-Mental State Examination* (MMSE) untuk skrining kognitif.

3. Economic (Ekonomi)

- a. Menilai stabilitas keuangan lansia yang berpengaruh terhadap akses layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- b. Faktor ekonomi mempengaruhi akses lansia terhadap layanan kesehatan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
- c. Evaluasi mencakup sumber pendapatan, jaminan sosial, serta dukungan finansial dari keluarga atau pemerintah.

4. Cognitive (Kognitif)

- a. Menilai kemampuan berpikir, mengingat, membuat keputusan, dan memecahkan masalah.
- b. Menilai seberapa jauh gangguan kognitif dapat mempengaruhi kemandirian lansia dalam aktivitas sehari-hari.
- c. Menggunakan instrumen seperti *Montreal Cognitive Assessment* (MoCA) atau MMSE untuk menilai kemungkinan demensia atau gangguan kognitif lainnya.

5. Nutrition (Nutrisi)

- a. Mengidentifikasi risiko malnutrisi yang dapat menyebabkan kelemahan dan penurunan fungsi tubuh.
- b. Pemeriksaan **Body Mass Index (BMI)**, asupan makanan, dan tanda-tanda defisiensi nutrisi.

6. Pharmacological (Farmakologi/Obat-obatan)

- a. Evaluasi konsumsi obat-obatan (poli-farmasi) untuk mencegah interaksi obat yang merugikan.
- b. Meninjau kepatuhan pasien terhadap terapi dan kemungkinan efek samping obat.

7. Environmental (Lingkungan)

- a. Menilai lingkungan, seperti keamanan rumah, aksesibilitas fasilitas, dan dukungan sosial, mempengaruhi kemandirian lansia.

- b. Modifikasi lingkungan dapat mengurangi risiko jatuh dan meningkatkan kualitas hidup.

8. Gait/Balance (Gaya Berjalan/Keseimbangan)

- a. Mengukur keseimbangan dan risiko jatuh yang sering terjadi pada lansia.
- b. Menggunakan *Timed Up and Go Test* (TUGT) atau *Berg Balance Scale* untuk menilai mobilitas.

9. Social (Sosial)

- a. Mengidentifikasi dukungan sosial dari keluarga, teman, atau komunitas yang mempengaruhi kesejahteraan emosional lansia.
- b. Isolasi sosial dan kurangnya interaksi dapat meningkatkan risiko depresi dan penurunan kesehatan mental.

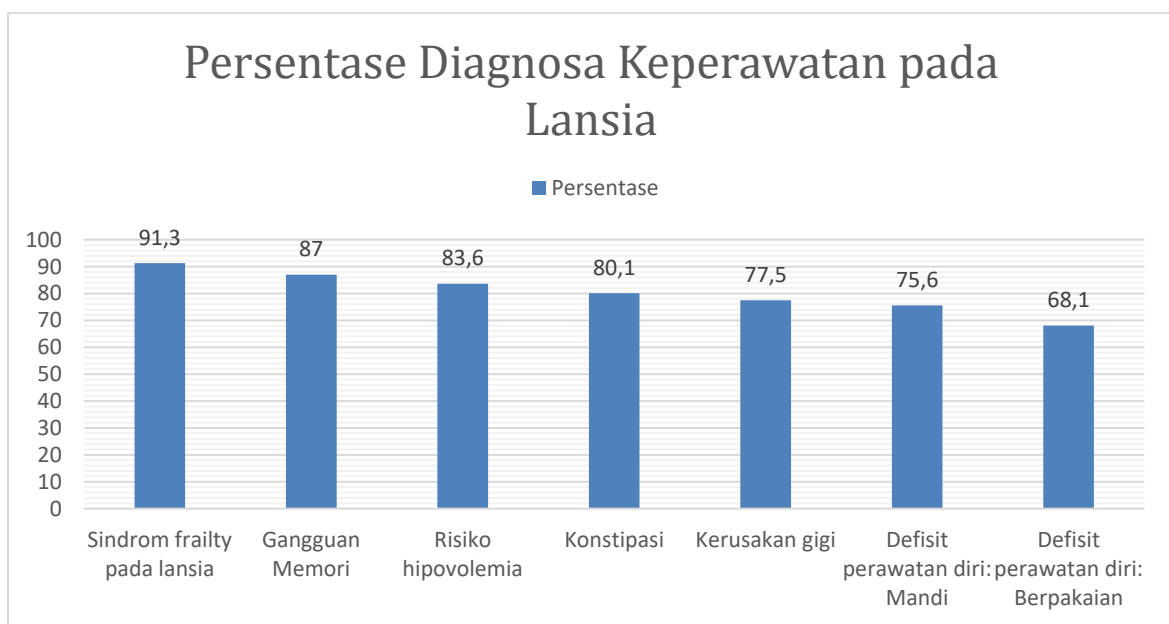
Semua elemen ini berkontribusi dalam menilai status fungsional lansia, yang mencerminkan sejauh mana mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri atau dengan bantuan. Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik lansia dan merancang intervensi yang tepat guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Berdasarkan elemen CGA tersebut, terdapat 4 dimensi utama dalam penilaian yang mencakup penilaian fisik, fungsional, psikologis, dan sosial yang tergambarkan dalam gambar 6.2 sebagai berikut.

Pengkajian Aspek Fisik • Keluhan yang dirasakan • Riwayat kesehatan sebelumnya • Riwayat pengobatan • Status nutrisi • Pemeriksaan lanjutan	Pengkajian Aspek Fungsional • ADL (Activity Daily Living) • Keseimbangan • Mobilitas
Pengkajian Aspek Psikologis • Pengkajian fungsi kognitif • Penilaian terhadap perasaan dan suasana hati	Pengkajian Aspek Sosial • Penilaian lingkungan tempat tinggal lansia • Ada tidaknya dukungan sosial bagi lansia • Kondisi keuangan • Lingkungan sekitar

Gambar 6.2: Dimensi Utama Penilaian CGA
(Royal College of Physicians Ireland, 2015)

C. Diagnosa Keperawatan

Perumusan diagnosis keperawatan dan penetapan rencana kperawatan harus disesuaikan untuk mengatasi masalah dan kekhawatiran kesehatan yang teridentifikasi pada lansia. Diagnosis keperawatan dalam konteks ini dapat mencakup sindrom geriatri seperti jatuh, kelemahan, inkontinensia, dan gangguan kognitif. Rencana perawatan bersifat individual, yang bertujuan tidak hanya untuk mengelola kondisi akut tetapi juga untuk meningkatkan fungsi optimal dan meningkatkan kualitas hidup lansia (Horta, 2024). Lansia merupakan individu yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan dan fungsional, sehingga pada individ lansia membutuhkan perhatian secara khusus. Diagnosa keperawatan yang sering terjadi pada lansia dapat dilihat pada gambar 6.3.



Gambar 6.3 Persentase diagnose keperawatan pada lansia (Horta, 2024)

Gambar 5.3 menunjukkan persentase diagnosis keperawatan pada lansia yang umum terjadi. Diagnosis ini mencerminkan kondisi kesehatan yang sering dialami oleh orang lanjut usia, yang membutuhkan perhatian dan intervensi keperawatan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing diagnosis berdasarkan persentase yang ditampilkan:

1. Sindrom frailty pada Lansia (91.30%): Sindrom kelemahan pada lansia merupakan kondisi yang ditandai dengan penurunan kekuatan fisik, ketahanan tubuh, dan mobilitas, sehingga meningkatkan risiko jatuh, cacat, dan kematian.
2. Gangguan memori (87%): Gangguan daya ingat sering terjadi akibat penuaan atau kondisi seperti demensia dan Alzheimer.
3. Risiko hipovolemia (83.60%): Lansia rentan mengalami dehidrasi akibat penurunan rasa haus atau kondisi medis tertentu.

4. Konstipasi (80.10%): Konstipasi sering terjadi akibat kurangnya asupan serat, dehidrasi, dan penurunan aktivitas fisik.
5. Kerusakan gigi (77.50%): Gangguan pada gigi atau gusi yang dapat mempengaruhi pola makan dan nutrisi lansia.
6. Defisit perawatan diri: mandi (75.60%): Kesulitan dalam melakukan aktivitas mandi akibat keterbatasan fisik atau kognitif.
7. Defisit perawatan diri: berpakaian (68.10%): Kesulitan dalam berpakaian secara mandiri karena keterbatasan mobilitas atau gangguan kognitif.

Dari grafik ini, dapat disimpulkan bahwa sindrom kelemahan pada lansia, gangguan memori, dan risiko defisiensi cairan merupakan tiga diagnosis keperawatan yang paling umum terjadi. Oleh karena itu, pendekatan keperawatan harus berfokus pada pemeliharaan fungsi fisik, kognitif, dan hidrasi lansia, serta memberikan dukungan dalam aktivitas sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

D. Intervensi Keperawatan

Asuhan keperawatan pada lansia dalam konteks individu memerlukan pendekatan yang personal, holistik, dan berfokus pada peningkatan kualitas hidup. Perawat berperan penting dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan intervensi, dan memastikan lansia mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk hidup mandiri dan bermartabat. Kolaborasi dengan tim kesehatan dan keluarga juga menjadi kunci keberhasilan dalam merawat lansia. Asuhan keperawatan pada lansia (lanjut usia) memerlukan pendekatan yang holistik dan individual karena lansia sering mengalami perubahan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang kompleks. Intervensi keperawatan pada lansia harus disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap individu, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, kemampuan fungsional, dan preferensi pribadi. Pendekatan berbasis individu atau *person-centered care* sangat penting dalam intervensi keperawatan bagi lansia. Asuhan keperawatan harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap individu, melibatkan lansia dalam pengambilan keputusan, serta mendukung kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial mereka (Horta, 2024).

Berikut adalah intervensi keperawatan pada lansia dalam konteks individu yang dapat dilakukan oleh seorang perawat:

1. Pendekatan Holistik dalam Asuhan Keperawatan Lansia: Lansia sering mengalami multiple morbiditas (beberapa penyakit sekaligus) dan perubahan terkait penuaan yang memengaruhi kualitas hidup. Oleh karena itu, intervensi keperawatan harus mencakup:

- a. Aspek fisik: Mengatasi masalah kesehatan seperti gangguan mobilitas, nyeri, atau penyakit kronis.
 - b. Aspek psikologis: Memberikan dukungan emosional dan mengatasi masalah seperti depresi atau kecemasan.
 - c. Aspek sosial: Memastikan lansia tetap terhubung dengan keluarga dan komunitas.
 - d. Aspek spiritual: Menghargai keyakinan spiritual lansia dan mendukung kebutuhan rohani mereka.
2. Prinsip intervensi pada lansia: tujuan intervensi pada lansia adalah meningkatkan kualitas hidup lansia, mempertahankan kemandirian mereka, serta mencegah risiko komplikasi kesehatan. Beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan dalam merancang intervensi keperawatan untuk lansia meliputi:
- a. Individualisasi: Setiap lansia memiliki kebutuhan yang unik, sehingga intervensi harus disesuaikan dengan kondisi dan preferensi individu.
 - b. Pencegahan: Fokus pada pencegahan komplikasi dan promosi kesehatan.
 - c. Kemandirian: Mendorong lansia untuk tetap mandiri sebisa mungkin.
 - d. Keamanan: Memastikan lingkungan aman untuk mencegah cedera atau kecelakaan.
 - e. Partisipasi keluarga: Melibatkan keluarga dalam perawatan untuk meningkatkan dukungan sosial dan emosional.

E. Implementasi

Implementasi asuhan keperawatan (Askep) pada lansia harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual individu. Preferensi implementasi ini berfokus pada pendekatan *person-centered care*, yang berarti bahwa setiap intervensi harus disesuaikan dengan kebutuhan, preferensi, dan kondisi spesifik dari lansia yang bersangkutan (Meiner & Yeager, 2016).

1. Prinsip Dasar Implementasi Askep Lansia: Sebelum melaksanakan intervensi, perawat harus mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut:

Tabel 6.1: Prinsip dasar implementasi pada lansia

Prinsip Dasar	Hal yang dapat dilakukan
Kemandirian Lansia	Memberikan bantuan hanya sebatas yang diperlukan untuk mendorong partisipasi aktif lansia.
Pencegahan Komplikasi	Mengidentifikasi dan mengurangi faktor risiko seperti jatuh, dehidrasi, dan malnutrisi

Holistik dan Multidisiplin	Melibatkan tenaga medis lain, keluarga, dan komunitas dalam proses perawatan
Komunikasi Efektif	Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menghargai preferensi komunikasi lansia

2. Implementasi Berdasarkan Kebutuhan Individu: Implementasi merupakan aspek terpenting dalam proses keperawatan. Dalam memberikan perawatan pada lansia diperlukan beberapa hal dalam focus pemeliharaan kesehatan tubuh pada lansia (Horta, 2024; Miller, 2015), yaitu:

a. Kebutuhan Fisik

Intervensi difokuskan pada pemeliharaan kesehatan tubuh dan pencegahan penyakit kronis. Kebutuhan fisik yang dapat dilakukan pada lansia terlihat dalam tabel 6.2 (Meiner & Yeager, 2016).

Tabel 6.2: Kebutuhan fisik pada implementasi asuhan keperawatan pada lansia

Prinsip Dasar	Hal yang dapat dilakukan
Mobilisasi & Aktivitas Fisik	- Menyesuaikan latihan dengan kemampuan individu, seperti senam ringan atau jalan kaki; - Mencegah risiko jatuh dengan alat bantu jika diperlukan.
Pencegahan Komplikasi	- Menyesuaikan latihan dengan kemampuan individu, seperti senam ringan atau jalan kaki; - Mencegah risiko jatuh dengan alat bantu jika diperlukan.
Nutrisi & Hidrasi	- Menyediakan makanan sesuai kebutuhan gizi lansia; - Mempertimbangkan tekstur makanan bagi yang memiliki gangguan gigi; - Memastikan lansia minum cukup air untuk mencegah dehidrasi.
Perawatan Diri	- Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menghargai preferensi komunikasi lansia; - Memandu lansia dalam aktivitas sehari-hari seperti mandi dan berpakaian, namun tetap mendorong kemandirian; Menggunakan alat bantu seperti

	pegangan di kamar mandi atau pakaian dengan ritsleting/magnet.
--	--

b. Kebutuhan Psikologis

Lansia sering mengalami kecemasan, depresi, atau demensia ringan. Implementasi yang dapat dilakukan pada lansia melalui pendekatan seperti tabel 6.3 berikut (Meiner & Yeager, 2016).

Tabel 6.3: Kebutuhan psikologis pada implementasi asuhan keperawatan pada lansia

Prinsip Dasar	Hal yang dapat dilakukan
Stimulasi Kognitif	Latihan memori melalui permainan, membaca, atau terapi reminiscence (mengenang masa lalu).
Pendampingan dan Dukungan Emosional	- Mendengarkan keluhan lansia dengan empati, memberikan waktu untuk berbicara; - Mendorong keterlibatan dalam aktivitas sosial untuk mencegah isolasi

c. Kebutuhan Sosial

Dukungan sosial sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Implementasi yang dapat dilakukan pada lansia melalui pendekatan kebutuhan sosial seperti tabel 6.4 berikut (Meiner & Yeager, 2016).

Tabel 6.4 Kebutuhan sosial pada implementasi asuhan keperawatan pada lansia

Prinsip Dasar	Hal yang dapat dilakukan
Keterlibatan Keluarga dan Komunitas	- Memastikan keluarga terlibat dalam perawatan dan mengambil keputusan bersama. - Mengajak lansia mengikuti kegiatan sosial, seperti arisan atau kelompok keagamaan.

d. Kebutuhan Spiritual

Kebutuhan spiritual pada lansia merupakan suatu pencarian jati diri untuk dapat mencari dan memahami suatu makna dalam hidup. Keterkaitan aspek

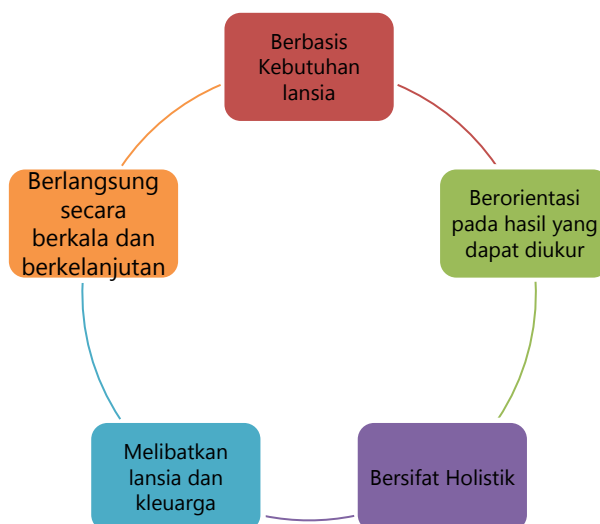
spiritual dalam pemberian perawatan holistic pada lansia merupakan salah satu sarana bagi petugas kesehatan dalam membantu pemulihan kesehatan bagi lansia secara keseluruhan (Elmaghfuroh, 2022). Kebutuhan spiritual yang dapat dilakukan pada lansia dapat dilihat pada tabel 6.5 (Meiner & Yeager, 2016).

Tabel 6.5: Kebutuhan spiritual pada implementasi asuhan keperawatan pada lansia

Prinsip Dasar	Hal yang dapat dilakukan
Pendampingan Spiritual	- Menghormati nilai-nilai dan keyakinan lansia; - Memfasilitasi kegiatan ibadah sesuai kepercayaan mereka

F. Evaluasi

Evaluasi dalam asuhan keperawatan lansia bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan dan memastikan bahwa lansia menerima perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Evaluasi dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual lansia. Prinsip evaluasi yang dapat disusun dalam proses keperawatan pada lansia dapat dilihat pada gambar 6.3 berikut.



Gambar 6.3: Prinsip Evaluasi dalam Asuhan Keperawatan pada Lansia

Berdasarkan gambar 5.3 menyebutkan bahwa prinsip evaluasi yang dapat dilakukan pada asuhan keperawatan pada lansia adalah berbasis individu, yang artinya evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik lansia,

baik dari segi fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual; dan setiap lansia memiliki kondisi yang berbeda, sehingga pendekatan evaluasi harus fleksibel dan disesuaikan secara personal. Selain itu evaluasi juga harus berorientasi pada hasil yang dapat diukur. Pengukuran hasil dilakukan dengan parameter objektif (tekanan darah, berat badan, tingkat mobilitas) dan subjektif (kepuasan lansia, persepsi kesejahteraan). Evaluasi mencakup perubahan nyata yang terjadi setelah intervensi diberikan. Evaluasi juga harus bersifat holistik yang tidak hanya menilai aspek fisik, tetapi juga kesejahteraan emosional, sosial, dan spiritual lansia. Pendekatan holistik memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan lansia diperhatikan dalam evaluasi. Prinsip selanjutnya dalam evaluasi asuhan keperawatan pada lansia adalah melibatkan lansia dan keluarga serta beralangsur secara berkala dan berkelanjutan. Lansia dan keluarga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan intervensi. Evaluasi dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, atau observasi untuk mengetahui apakah lansia merasa lebih baik setelah intervensi. Dimana evaluasi tersebut dilakukan secara rutin untuk menilai perkembangan kondisi lansia. Jika ditemukan ketidakefektifan intervensi, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan strategi keperawatan (Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI), 2015).

G. Latihan

Pilihan Ganda

1. Apa yang menjadi fokus utama dalam asuhan keperawatan lansia dalam konteks individu?
 - A. Mengobati penyakit yang sudah ada
 - B. Meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian lansia
 - C. Menjaga agar lansia tetap berada di fasilitas kesehatan
 - D. Mencegah interaksi lansia dengan lingkungan luar
 - E. Mengandalkan obat-obatan sebagai solusi utama
2. **Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)** digunakan dalam pengkajian lansia untuk...
 - A. Mengidentifikasi kebutuhan kesehatan lansia secara menyeluruh
 - B. Menentukan apakah lansia harus menjalani operasi
 - C. Mendiagnosis penyakit spesifik pada lansia
 - D. Mengukur tingkat kebahagiaan lansia dalam keluarga
 - E. Menghitung risiko keuangan lansia dalam pengobatan
3. Salah satu intervensi keperawatan untuk mencegah **jatuh pada lansia** adalah...
 - A. Mengurangi aktivitas fisik lansia

- B. Menganjurkan lansia untuk tetap di tempat tidur sepanjang hari
 - C. Menggunakan alat bantu jalan seperti walker atau tongkat jika diperlukan
 - D. Memberikan obat tidur secara rutin untuk mengurangi pergerakan lansia
 - E. Meniadakan pegangan tangan di kamar mandi agar lansia lebih mandiri
4. Salah satu intervensi keperawatan untuk **mencegah dehidrasi pada lansia** adalah...
- A. Mengurangi asupan cairan untuk menghindari sering buang air kecil
 - B. Memberikan air putih secara teratur sesuai kebutuhan lansia
 - C. Mengandalkan suplemen elektrolit tanpa mempertimbangkan pola makan
 - D. Mengurangi konsumsi buah dan sayur
 - E. Mengganti semua cairan dengan susu berkalori tinggi
5. Tujuan utama dari intervensi keperawatan lansia adalah...
- A. Menyembuhkan penyakit yang diderita lansia
 - B. Meningkatkan kualitas hidup, mempertahankan kemandirian, dan mencegah komplikasi
 - C. Membantu keluarga dalam perawatan tanpa keterlibatan lansia
 - D. Mengurangi interaksi lansia dengan lingkungan sekitar
 - E. Membuat lansia lebih bergantung pada tenaga medis

Essay

Jawablah dengan singkat pertanyaan di bawah ini

1. Jelaskan konsep ***person-centered care*** dalam asuhan keperawatan lansia dan mengapa pendekatan ini penting!
2. Sebutkan dan jelaskan empat dimensi utama dalam Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) yang digunakan dalam pengkajian lansia!
3. Bagaimana langkah-langkah intervensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mobilitas dan mencegah risiko jatuh pada lansia?
4. Mengapa aspek psikologis dan sosial harus diperhatikan dalam asuhan keperawatan lansia? Jelaskan dengan contoh!
5. Bagaimana prinsip evaluasi dalam asuhan keperawatan lansia dapat membantu meningkatkan efektivitas perawatan?

Kunci Jawaban

1. B
2. A
3. C
4. B
5. B

H. Rangkuman Materi

Asuhan keperawatan pada lansia dalam konteks individu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, mempertahankan kemandirian, serta mencegah komplikasi kesehatan yang umum terjadi pada lansia. Pendekatan yang digunakan adalah person-centered care, yaitu perawatan yang berfokus pada kebutuhan spesifik setiap individu lansia, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Asuhan keperawatan lansia harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, berbasis individu, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup. Melalui pengkajian yang menyeluruh, intervensi yang tepat, serta evaluasi yang berkelanjutan, lansia dapat menjalani kehidupan dengan lebih sehat, mandiri, dan bermartabat.

Proses keperawatan pada lansia dimulai dengan pengkajian menggunakan alat seperti *Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)*, yang mencakup aspek fisik, psikologis, ekonomi, kognitif, nutrisi, farmakologi, lingkungan, gaya berjalan, dan sosial. Setelah pengkajian, perawat merumuskan diagnosa keperawatan yang umumnya meliputi sindrom frailty, gangguan memori, risiko hipovolemia, konstipasi, dan masalah perawatan diri. Intervensi keperawatan pada lansia dilakukan dengan pendekatan holistik, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Beberapa prinsip intervensi yang penting adalah individualisasi, pencegahan, kemandirian, keamanan, dan partisipasi keluarga. Implementasi asuhan keperawatan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu lansia, termasuk kebutuhan fisik seperti mobilisasi dan nutrisi, kebutuhan psikologis seperti stimulasi kognitif, serta kebutuhan sosial dan spiritual. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan. Evaluasi ini bersifat holistik, melibatkan lansia dan keluarga, serta dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Jika intervensi tidak efektif, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan strategi keperawatan.

I. Glosarium

- Activity Daily Living (ADL): Aktivitas sehari-hari yang mencakup makan, berpakaian, mandi, berpindah tempat, dan menggunakan toilet.
- Asuhan Keperawatan Lansia: Perawatan yang diberikan kepada individu lanjut usia dengan pendekatan holistik yang meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.
- Comprehensive Geriatric Assessment (CGA): Pendekatan multidisiplin dalam pengkajian kondisi kesehatan lansia secara menyeluruh, termasuk aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan.
- Defisit Perawatan Diri: Ketidakmampuan individu untuk melakukan aktivitas

sehari-hari secara mandiri, seperti mandi, berpakaian, atau makan, akibat keterbatasan fisik atau kognitif.

- Demensia: Gangguan kognitif progresif yang memengaruhi daya ingat, pemikiran, dan kemampuan dalam aktivitas sehari-hari.
- Depresi Geriatri: Kondisi depresi yang sering terjadi pada lansia akibat faktor psikososial seperti kesepian, kehilangan pasangan, atau perubahan status kesehatan.
- Frailty Syndrome (Sindrom Frailty): Kondisi kelemahan fisik pada lansia yang ditandai dengan penurunan mobilitas, kekuatan otot, dan daya tahan tubuh, yang meningkatkan risiko jatuh dan kecacatan.
- Geriatri: Cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada kesehatan dan perawatan lansia.
- Holistik: Pendekatan perawatan yang mempertimbangkan seluruh aspek individu, termasuk fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.
- Inkontinensia Urin: Ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol buang air kecil, yang umum terjadi pada lansia.
- Intervensi Keperawatan: Tindakan atau perawatan yang dilakukan oleh perawat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pasien, baik dalam aspek fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual.
- Kognitif: Kemampuan otak dalam berpikir, mengingat, dan membuat keputusan.
- Malnutrisi: Kondisi akibat kekurangan atau kelebihan asupan nutrisi yang berdampak pada kesehatan dan fungsi tubuh lansia.
- Mini-Mental State Examination (MMSE): Alat skrining untuk menilai fungsi kognitif dan mendeteksi adanya gangguan seperti demensia atau Alzheimer.
- Osteoporosis: Penyakit tulang yang ditandai dengan kerapuhan dan peningkatan risiko patah tulang, sering terjadi pada lansia.
- Person-Centered Care: Pendekatan dalam perawatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan individu pasien, menghargai preferensi, dan melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan.
- Polifarmasi: Penggunaan beberapa jenis obat secara bersamaan oleh lansia yang dapat meningkatkan risiko efek samping dan interaksi obat yang merugikan.
- Psikososial: Interaksi antara faktor psikologis (emosional, kognitif) dan sosial (hubungan dengan keluarga dan lingkungan) dalam mempengaruhi kesehatan seseorang.
- Reminiscence Therapy: Terapi yang melibatkan pengingatan kembali pengalaman masa lalu, sering digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis lansia.

- Risiko Jatuh: Kemungkinan lansia mengalami jatuh akibat faktor seperti gangguan keseimbangan, kelemahan otot, atau lingkungan yang tidak aman.
- Timed Up and Go Test (TUGT): Tes untuk menilai mobilitas dan risiko jatuh pada lansia dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk berdiri, berjalan, dan duduk kembali.

J. Daftar Pustaka

- Elmaghfuroh, D. R. (2022). Ilmu Keperawatan Komunitas dan Gerontik (Aspek Psikososial dan Spiritual pada Lansia). In A. Munandar (Ed.), *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1). Media Sains Indonesia.
- Horta, T. (2024). *The Nursing Process in Geriatric Care : A Comprehensive Approach* ClinicSearch *The Nursing Process in Geriatric Care: A Comprehensive Approach*. November. <https://doi.org/10.31579/2834-5029/064>
- Meiner, S. E., & Yeager, J. J. (2016). *Gerontologic Nursing*. 1–23.
- Miller, C. A. (2015). *Nursing for Wellness in Older Adults* (6th ed.). Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins.
- Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI). (2015). *Working with older people Professional guidance*. 2nd, 6.
- Royal College of Physicians Ireland. (2015). *Comprehensive Geriatric Assessment A Summary*. 1–6. <https://www.hse.ie/eng/services/publications/clinical-strategy-and-programmes/comprehensive-geriatric-assessment-summary.pdf>.

PROFIL PENULIS



Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Boyolali, 12 Juni 1983 dari pasangan Bapak Djiman dan Ibu Sri Wuryati. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran tahun 2008 dan melanjutkan program pendidikan Profesi di kampus yang sama pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 keperawatan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2004 menjadi staff di Akper Ngudi Waluyo, selanjutnya sambil bekerja juga melanjutkan pendidikan baik itu jenjang S1, Profesi maupun S2. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Universitas Ngudi Waluyo tepatnya di Program Studi D3 Keperawatan dan mengampu mata kuliah Keperawatan Jiwa, Keperawatan Gerontik, Keperawatan Keluarga, Promosi Kesehatan, Keperawatan Dasar, Komunikasi keperawatan, dan Manajemen Klien Safety. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pelatihan, pengajar, melakukan penelitian, melakukan pengabdian kepada masyarakat, menyusun modul modul pembelajaran dan pengembangan sarana pembelajaran. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wulansari@unw.ac.id
Motto: "Berusahalah selalu, jangan berhenti dan yakinlah pasti akan tercapai"



Dr. Iskim Luthfa, S.Kep.,Ns.,M.kep Penulis lahir di Demak, 20 Juni 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 lulus pada tahun 2007 dan Ners tahun 2009 di Universitas Muhammadiyah Semarang. Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan studi S3 di Universitas Airlangga dan lulus tahun 2024. Riwayat pekerjaan sejak tahun 2009 sampai sekarang sebagai Dosen Program Studi Fakultas Ilmu Keperawatan Departemen Keperawatan Komunitas, Universitas Islam Sultan Agung. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Penulis juga aktif dalam organisasi profesi sebagai pengurus IPEGRI Jawa Tengah bidang Pelayanan dan Humas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: iskimluthfa@unissula.ac.id
Motto: "Hidup adalah perjalanan, jadi nikmati setiap langkahnya"

PROFIL PENULIS



Suwanti.,S.Kep.,Ns.,MNS. Lahir di Sragen, 18 Desember 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan pada Program Studi AKPER Ngudi Waluyo Ungaran, S1 dan Profesi Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Kasetsart University di Bangkok, Thailand dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2004 di STIKES Aisyiyah Surakarta, tahun 2005-2009 sebagai Perawat di Medical Intensive Care Unit di King Fahad Hospital Medina, Kingdom of Saudi Arabia, Tahun 2011- sekarang bekerja di Prodi S1 Keperawatan Universitas Ngudi Waluyo. Saat ini penulis bekerja di Universitas Ngudi Waluyo mengampu mata kuliah keperawatan Gerontik, Keperawatan komunitas, Keperawatan Keluarga, Terapi Komplementer, dan Bahasa Inggris Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, penelitian, pengabdian dan publikasi,. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wanticintanurfatwa@gmail.com

Motto: "Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tapi keberhasilan adalah milik orang yang senantiasa berusaha"



Ns. Arneliwati, M.Kep. Lahir di Pekanbaru, 15 Februari 1979. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Akademi Keperawatan (AKPER) (2000), S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Universitas Andalas - Padang (2003) Program Studi Profesi Ners Universitas Andalas - Padang (2004),. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia – Jakarta, Keperawatan Komunitas dan lulus tahun pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2004 sebagai Dosen DIII Akademi Perawat (AKPER) Universitas Abdurrahman Tabrani. Saat ini penulis bekerja di Universitas Riau mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keluarga, Gerontik dan Kebencanaan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan aktif dalam berbagai organisasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: arneliwati20@gmail.com

Motto: "*Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.*"

PROFIL PENULIS



Penulis lahir di Kota Jember pada tanggal 20 April 1990. Saat ini penulis merupakan salah satu dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember. Sebelumnya penulis juga menempuh Pendidikan Sarjana dan Profesi Ners di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember dilanjutkan dengan menempuh Pendidikan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Pascasarjana Universitas Jember dan Lulus pada tahun 2018. Sebelum menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Jember, penulis memulai

karirnya sebagai dosen keperawatan di STIKES Widya Cipta Husada Malang.

Ketertarikan penulis di bidang Keperawatan Gerontik diawali saat pertama kali menjadi dosen, penulis menjadi salah satu tim di bidang Keperawatan Komunitas yang berfokus pada perawatan pada kelompok khusus/agregat Lansia. Setelah melanjutkan karir di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember, penulis juga berkecimpung di departemen Keperawatan Gerontik. Pengalaman penulis dalam menulis buku diawali dengan menulis Book Chapter yang berjudul Ilmu Keperawatan Komunitas dan Gerontik bersama dengan penulis lainnya yang membahas tentang Aspek Psikososial dan Spiritual pada Lansia, kemudian berlanjut dengan Judul buku Keperawatan Paliatif (Aspek dan Penerapan) Melalui buku ini, penulis ingin mengenalkan bagaimana proses asuhan keperawatan yang dilakukan pada lansia dalam konteks individu.

Email penulis: diyanarel@gmail.com

Motto: "This is life, not heaven. You don't have to be perfect, but you can be kind"



Kartinah, S.Kep., Ns., M.P.H., lahir di Klaten pada 18 Desember 1974. Pendidikan D3 keperawatan diselesaikan pada tahun 1997 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya beliau menyelesaikan pendidikan D4 Perawat Pendidik dari Universitas Diponegoro, tahun 2001. Pendidikan sarjana keperawatan lulus tahun 2007 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dan S2 Kesehatan masyarakat dari UGM pada tahun 2017. Saat ini aktif sebagai dosen di prodi

keperawatan FIK UMS dan mengampu mata kuliah Keperawatan Dasar, Komunikasi Keperawatan dan Keperawatan Gerontik. Penelitian dan pengabdian yang beliau lakukan saat ini banyak berfokus pada bidang keperawatan gerontik. Beliau saat ini juga aktif sebagai pengurus pada organisasi perawat (PPNI) tingkat kabupaten. Email : kar194@ums.ac.id Hp : 081393682000

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Gerontik disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang perawatan lansia, mulai dari konsep dasar tentang penuaan hingga aplikasi praktis dalam perawatan sehari-hari. Buku ini mengawali pembahasannya dengan mengulas berbagai perubahan fisiologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang dialami lansia, serta kebutuhan dasar mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Paradigma baru pelayanan kesehatan lansia yang menekankan pendekatan humanis turut menjadi bagian penting dalam buku ini, dengan penekanan khusus pada peran perawat gerontik di berbagai lini pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, buku ini mendalami berbagai model keperawatan gerontik yang dikembangkan oleh ahli-ahli terkemuka seperti Callista Roy, Martha Rogers, Betty Neuman, Virginia Henderson, dan Dorothea Orem. Setiap model dibahas secara detail untuk memberikan landasan teoritis kuat dalam praktik keperawatan, disertai latihan-latihan yang mempermudah pemahaman konsep tersebut. Materi ini bertujuan agar pembaca mampu mengintegrasikan teori-teori ini dalam pelayanan yang lebih terarah dan efektif.

Pada bagian akhir, pembaca disajikan dengan panduan rinci tentang pengkajian kesehatan lansia, proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan keperawatan, serta tindakan perawatan spesifik seperti terapi kognitif dan aktivitas, bantuan dalam aktivitas sehari-hari (ADL), dan senam lansia. Dengan pendekatan Comprehensive Geriatric Assessment (CGA), buku ini menyediakan metode yang holistik untuk memastikan perawatan yang optimal dan berorientasi pada kebutuhan individu, sehingga pembaca mampu menerapkan ilmu yang diperoleh secara nyata dalam praktik sehari-hari.

Buku Ajar Keperawatan Gerontik disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang perawatan lansia, mulai dari konsep dasar tentang penuaan hingga aplikasi praktis dalam perawatan sehari-hari. Buku ini mengawali pembahasannya dengan mengulas berbagai perubahan fisiologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang dialami lansia, serta kebutuhan dasar mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Paradigma baru pelayanan kesehatan lansia yang menekankan pendekatan humanis turut menjadi bagian penting dalam buku ini, dengan penekanan khusus pada peran perawat gerontik di berbagai lini pelayanan kesehatan. Selanjutnya, buku ini mendalami berbagai model keperawatan gerontik yang dikembangkan oleh ahli-ahli terkemuka seperti Callista Roy, Martha Rogers, Betty Neuman, Virginia Henderson, dan Dorothea Orem. Setiap model dibahas secara detail untuk memberikan landasan teoritis kuat dalam praktik keperawatan, disertai latihan-latihan yang mempermudah pemahaman konsep tersebut. Materi ini bertujuan agar pembaca mampu mengintegrasikan teori-teori ini dalam pelayanan yang lebih terarah dan efektif.

Pada bagian akhir, pembaca disajikan dengan panduan rinci tentang pengkajian kesehatan lansia, proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan keperawatan, serta tindakan perawatan spesifik seperti terapi kognitif dan aktivitas, bantuan dalam aktivitas sehari-hari (ADL), dan senam lansia. Dengan pendekatan Comprehensive Geriatric Assessment (CGA), buku ini menyediakan metode yang holistik untuk memastikan perawatan yang optimal dan berorientasi pada kebutuhan individu, sehingga pembaca mampu menerapkan ilmu yang diperoleh secara nyata dalam praktik sehari-hari.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



Optimal
Untuk
Negeri



Optimal
Untuk
Negeri



IKAPI
IKATAN PERAWAT INDONESIA

ISBN 978-634-96029-3-8



9

786349

602938